



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

KEPERAWATAN KELUARGA DALAM ASUHAN KESEHATAN ANAK

Liza Putri • Yupi Supartini • Rina Nur Hidayati
Helena Kidi Labot • Hanny Rasni

Editor: Misroh Mulianingsih



BUNGA RAMPAI: KEPERAWATAN KELUARGA DALAM ASUHAN KESEHATAN ANAK

Penulis:

Ns. Liza Putri, M.Kep.

Yupi Supartini, S.Kp. M.Sc.

Rina Nur Hidayati, S.Kep., Ns, M.Kep., Sp.Kep.Kom.

Helena Kidi Labot, SST., M.Kes.

Hanny Rasni, S.Kp., M.Kep.

Editor:

Dr. Misroh Mulianingsih, S. Kep, Ners, MPH.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

**BUNGA RAMPAI:
KEPERAWATAN KELUARGA DALAM ASUHAN KESEHATAN ANAK**

Penulis: Ns. Liza Putri, M.Kep.
Yupi Supartini, S.Kp. M.Sc.
Rina Nur Hidayati, S.Kep., Ns, M.Kep., Sp.Kep.Kom.
Helena Kidi Labot, SST., M.Kes.
Hanny Rasni, S.Kp., M.Kep.

Editor: Dr. Misroh Mulianingsih, S. Kep, Ners, MPH.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7219-09-1

Cetakan Pertama

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Keperawatan keluarga dalam asuhan kesehatan anak : bunga rampai / penulis, Ns. Liza Putri, M.Kep., Yupi Supartini, S.Kp. M.Sc., Rina Nur Hidayati, S.Kep., Ns, M.Kep., Sp.Kep.Kom., Helena Kidi Labot, SST., M.Kes., Hanny Rasni, S.Kp., M.Kep. ; editor, Dr. Misroh Mulianingsih, S. Kep, Ners, MPH.

EDISI
PUBLIKASI
DESKRIPSI FISIK
IDENTIFIKASI
SUBJEK
KLASIFIKASI
PERPUSNAS ID

Cetakan pertama
Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
vi, 98 halaman : ilustrasi ; 30 cm
ISBN 978-634-7219-09-1
Kesehatan anak, Pelayanan -- Keperawatan -- Kesejahteraan anak
362.198 92 [23]
<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1212087>

Prakata

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, buku dengan judul "Bunga Rampai: Keperawatan Keluarga dalam Asuhan Kesehatan Anak" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai wujud kepedulian terhadap pentingnya peran keluarga, khususnya dalam konteks keperawatan, untuk mendukung tumbuh kembang dan kesehatan anak secara optimal, terutama pada usia bayi dan balita.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, keperawatan keluarga memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan kesehatan yang berkelanjutan. Buku ini menguraikan beberapa aspek penting terkait keperawatan keluarga dan peranannya dalam mendukung kesehatan anak, mulai dari pengenalan peran keperawatan keluarga dalam asuhan balita, pentingnya pendidikan kesehatan untuk mencegah kecelakaan dan cedera, hingga manajemen gizi yang tepat dalam lingkungan keluarga.

Pembahasan juga mencakup bagaimana keluarga berkontribusi dalam menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini serta bagaimana pendekatan ethno-agronursing dapat dimanfaatkan dalam pemberian asupan gizi yang sesuai dengan budaya dan potensi lokal. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada pemberian nutrisi yang tepat, namun juga memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dalam praktik keperawatan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum, khususnya keluarga yang memiliki anak usia dini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan anak melalui pendekatan keperawatan keluarga yang holistik dan berbasis budaya.

Mei, 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
----------------------	------------

Daftar Isi.....	iv
------------------------	-----------

BAB 1 Peran Keperawatan Keluarga dalam Asuhan Kesehatan Anak

Balita

Ns. Liza Putri, M.Kep.....	1
Pendahuluan.....	1
Balita	3
Karakteristik Balita.....	3
Paradigma Keperawatan Anak	4
Keluarga.....	6
Klasifikasi Keluarga.....	7
Fungsi Keluarga.....	8
Tugas Keluarga Dalam Bidang Keluarga.....	9
Tahap-Tahap Perkembangan Keluarga	10
Tugas Keluarga Dalam Bidang Kesehatan.....	11
Keperawatan Keluarga.....	11
Tujuan Keperawatan Keluarga.....	12
Peran Perawat Dalam Keperawatan Keluarga.....	14
Proses Keperawatan Keluarga	14
Hambatan Dalam Keperawatan Keluarga.....	15
Perspektif Keperawatan Keluarga	15
Referensi.....	17

BAB 2 Pendidikan Kesehatan Anak: Pencegahan Kecelakaan dan Cedera

Yupi Supartini, S.Kp. M.Sc.....	19
Pendahuluan.....	19
Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Dalam Konteks Upaya Pencegahan Kecelakaan	21
Pengertian <i>Anticipatory Guidance</i>	22
Pencegahan Kecelakaan Pada Anak	23
Potensi Bahaya Yang Harus Dikenali Pada Anak Remaja.....	29
Simpulan	32
Referensi.....	32
Glosarium.....	33

BAB 3 Manajemen Gizi Balita Dalam Keperawatan Keluarga

Rina Nur Hidayati, S.Kep.Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom.....	35
Pendahuluan.....	35
Balita Sebagai Kelompok At Risk Masalah Gizi	37
Masalah Dalam Pemenuhan Gizi Balita Di Keluarga	38
Manajemen Gizi Balita Dengan Pendekatan Keperawatan Keluarga	40
Simpulan	46
Referensi.....	48
Glosarium.....	51

BAB 4 Peran Keluarga dalam Meningkatkan Kebiasaan Hidup Sehat pada Anak

Helena Kidi Labot, SST., M.Kes.....	55
Pendahuluan.....	55
Peran Orang tua Terhadap Anak.....	57
Tugas Keluarga dalam Pemeliharaan Kesehatan.....	57
Kebiasaan Hidup Sehat Anak.....	58
Peran Orang Tua Terhadap Kebiasaan Sehat pada Anak.....	62
Cara Memberi Pola Hidup Sehat pada Anak.....	63
Simpulan	66
Referensi.....	66

BAB 5 Asuhan Keperawatan Keluarga: Peran Orangtua Dalam Pemberian Asupan Gizi Pada Anak Di Usia Bayi Dan Balita Dengan Pendekatan Ethno - Agronursing

Hanny Rasni, S.Kp.,M.Kep.....	69
Pendahuluan.....	69
Kebutuhan Gizi Pada Bayi dan Balita.....	71
Peran Orangtua dalam Pemenuhan Gizi dengan Pendekatan Ethno-Agronursing.....	78
Referensi.....	94

Profil Penulis.....	95
----------------------------	-----------

BAB 1

Peran Keperawatan Keluarga dalam Asuhan Kesehatan Anak Balita

Ns. Liza Putri, M.Kep.

Pendahuluan

Anak merupakan aset penting bagi masa depan suatu bangsa dan negara. Keberhasilan mereka kelak yang akan memiliki pengaruh besar baik bagi dirinya sendiri ataupun bangsa dan Negara. Anak adalah sebagai individu yang unik dan mempunyai kebutuhan sesuai tahap perkembangannya. Anak juga merupakan generasi muda sebagai sumber daya manusia penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam pembangunan nasional. Generasi muda diharapkan menjadi manusia berkualitas, mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Usaha yang dapat dilakukan salah satunya yaitu mensejahterakan kesehatan anak.

Masalah kesehatan anak merupakan salah satu masalah utama yang saat ini terjadi dibidang kesehatan, derajat kesehatan anak mencerminkan derajat kesehatan bangsa sebab anak sebagai generasi penerus memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dalam meneruskan pembangunan bangsa berdasarkan alasan tersebut masalah kesehatan anak diprioritaskan dalam perencanaan dan penataan pembangunan bangsa (Suryaningsih *et al.*, 2019).

Anak yang sehat adalah anak yang sehat secara fisik dan psikis. Kesehatan seorang anak dimulai dari pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat dapat diterapkan dari yang terkecil mulai dari menjaga kebersihan diri, lingkungan hingga pola makan yang sehat dan teratur. Masa tumbuh kembang anak merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang manusia dikarenakan tumbuh kembang berlangsung cepat. Perkembangan dan pertumbuhan di masa anak menjadi faktor keberhasilan

pertumbuhan dan perkembangan di masa mendatang Anak sedang mengalami masa tumbuh kembang yang amat sangat cepat dan pesat. Pada masa ini, proses perubahan fisik, emosi dan sosial anak berlangsung dengan cepat. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari diri anak itu sendiri, gizi, maupun pengaruh ibu. Tumbuh kembang anak dapat dipantau melalui pengukuran fisiknya dan melalui pengamatan sikap atau perilaku anak (Hapsari, 2019).

Keperawatan anak muncul dan berkembang dalam upaya memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, intelektual, dan spiritual yang difokuskan menurut dengan tahap tumbuh kembang anak, menggunakan cara promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif (Wulandari & Erawati, 2016).

Pemberian asuhan keperawatan pada anak tentunya berbeda dibandingkan dengan pemberian asuhan keperawatan pada orang dewasa. Beberapa perbedaan yang mesti dicermati yaitu ketika dalam melakukan proses perawatan harus disesuaikan dengan usia dan keadaan tumbuh kembang anak. Hal ini bermaksud dikarenakan jika perawatan yang dilakukan tidak maksimal maka tentunya akan berdampak pada kondisi fisik dan psikologis anak (Yuliastati & Arnis, 2016).

Perawat merupakan anggota dari tim kesehatan dan pemberi asuhan keperawatan anak yang mana dapat berkontribusi dalam berbagai aspek untuk memberikan pelayanan kesehatan dan berkoordinasi dengan anggota tim lain, terutama dengan keluarga dalam membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peran perawat anak (Yuliastati & Arnis, 2016).

Tujuan perawatan anak sesuai dengan perspektif perawatan anak menurut Wulandari & Erawati adalah "Untuk meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh serta menanggung proses perkembangan anak secara optimal" (Wulandari & Erawati, 2016).

Seperti yang diketahui, seorang perawat khususnya perawat anak dalam memberikan rencana tindakan atau asuhan keperawatan tentunya memiliki landasan fokus, yang diantaranya adalah berfokus pada keluarga, memberikan asuhan atraumatic yang terapeutik, dan melakukan praktik berbasis bukti (evidence based) (Kyle & Carman, 2015).

Masalah penyakit khususnya pada anak secara garis besar seperti yang tercantum dalam pedoman Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) terdiri atas ISPA, Diare, Demam, Masalah telinga, Gizi buruk, Anemia, dan HIV. Salah satu kategori penyakit yang sering dialami anak diantaranya yaitu penyakit dengan gangguan pernapasan. Klasifikasi penyakit pada kategori penyakit gangguan pernapasan diantaranya adalah ISPA, TBC, Asma, dan lain-lain. Masalah keperawatan yang sering muncul pada kasus

gangguan sistem pernapasan ini diantaranya terdiri atas ketidakefektifan bersihan jalan nafas, gangguan pertukaran gas, risiko infeksi (penyebaran), intoleran aktivitas, nyeri akut, risiko ketidakseimbangan nutrisi: kurang dari kebutuhan, risiko kekurangan volume cairan, defisiensi pengetahuan (kebutuhan pembelajaran) mengenai kondisi, terapi, perawatan diri, dan kebutuhan pemulangan (Doenges, 2018; SDKI PPNI, 2017).

Balita

Toddler atau batita merupakan anak usia 12-36 bulan (1-3 tahun), dimana pada periode ini anak berusaha mencari tahu bagaimana sesuatu bekerja dan mengontrol orang lain melalui penolakan, kemarahan, dan tindakan keras kepala. Pada periode ini adalah periode pertumbuhan dan perkembangan anak berkembang secara optimal (Hidayat, 2008).

Pada periode anak usia batita terdapat beberapa ciri-ciri perkembangan yaitu anak selalu ingin mencoba hal yang diinginkannya dan rasa ingin tahu tentang sesuatu lebih tinggi, anak usia toddler menolak atau menuntut apa yang dia inginkan atau yang tidak diinginkan, dan didalam anak usia batita sudah tertanam rasa otonomi. Laju pertumbuhan batita lebih besar dibandingkan usia prasekolah sehingga memerlukan jumlah makanan yang relatif besar dengan pola makan yang diberikan dalam porsi kecil, Saat usia batita anak masih tergantung penuh kepada orang tuanya untuk melakukan kegiatan yang penting seperti mandi, buang air besar dan kecil, dan makan. Perkembangan berbicara dan berjalan sudah baik tetapi kemampuan lain masih terbatas.

Karakteristik Balita

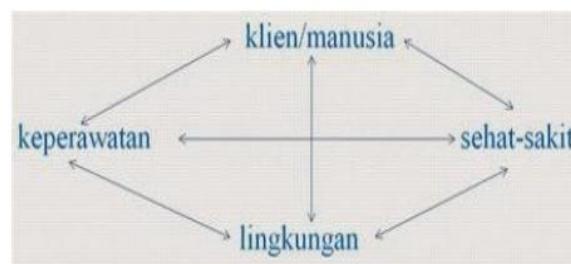
Perkembangan pada anak usia 1-3 tahun ditandai dengan peningkatan dalam gerakan motorik kasar dan halus yang cepat. Khusus anak usia 12-24 bulan perkembangan yang penting yaitu antara lain adalah berjalan, mengeksplorasi rumah dan sekeliling, menyusun 2-3 kotak, mengatakan 5-10 kata, naik turun tangga, menunjukan mata dan hidungnya, dan menyusun kata. Sedangkan pertumbuhan pada anak usia batita menjadi lebih lambat karena rata rata berat badannya hanya bertambah 0,23 kg perbulan dan pertambahan tinggi badan 1 cm perbulan. Pertumbuhan batita seperti ini hal normal, namun asupan energi dan zat-zat lain yang adekuat yang sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Anak usia 1-3 tahun merupakan konsumen pasif, artinya anak menerima makanan dari apa yang disediakan oleh ibunya. Laju pertumbuhan masa batita lebih besar dari masa usia pra sekolah sehingga diperlukan jumlah makanan yang relatif besar. Pola makan yang diberikan sebaiknya dalam porsi kecil dengan frekuensi sering karena perut batita masih kecil sehingga tidak mampu menerima jumlah makanan dalam sekali makan (Irianto, 2014).

Paradigma Keperawatan Anak

Filosofi merupakan pandangan atau keyakinan yang dimiliki perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan pada anak. Tujuannya adalah pencapaian derajat kesehatan bagi anak sebagai suatu bagian dari sistem pelayanan kesehatan di keluarga. Keberhasilan pelayanan kesehatan dan kunci filosofi keperawatan anak, meliputi family center care (FCC) dan Atraumatic care (Damanik & Sitorus, 2019).

Paradigma keperawatan anak merupakan suatu landasan berpikir dalam penerapan ilmu keperawatan anak. Landasan berpikir tersebut terdiri dari empat komponen, diantaranya manusia dalam hal ini anak, keperawatan, sehat-sakit dan lingkungan yang dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 1.1 Komponen Landasan Berpikir Paradigma Keperawatan Anak

Empat komponen landasan berpikir paradigma keperawatan anak:

1. Manusia (Anak)

Dalam keperawatan anak yang menjadi individu (klien) adalah anak yang diartikan sebagai seseorang yang usianya kurang dari 18 tahun dalam masa tumbuh kembang, dengan kebutuhan khusus yaitu kebutuhan fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Dalam proses berkembang anak memiliki ciri fisik, kognitif, konsep diri, pola koping dan perilaku sosial.

Ciri fisik pada semua anak tidak mungkin pertumbuhan fisiknya sama, demikian pula pada perkembangan kognitif adakalanya cepat atau lambat.

Perkembangan konsep diri sudah ada sejak bayi akan tetapi belum terbentuk sempurna dan akan mengalami perkembangan seiring bertambahnya usia anak. Pola koping juga sudah terbentuk sejak bayi di mana bayi akan menangis saat lapar.

Perilaku sosial anak juga mengalami perkembangan yang terbentuk mulai bayi seperti anak mau diajak orang lain. Sedangkan respons emosi terhadap penyakit bervariasi tergantung pada usia dan pencapaian tugas perkembangan anak, seperti pada bayi saat perpisahan dengan orang tua maka responsnya akan menangis, berteriak, menarik diri dan menyerah pada situasi yaitu diam.

Dalam memberikan pelayanan keperawatan anak selalu diutamakan, mengingat kemampuan dalam mengatasi masalah masih dalam proses kematangan yang berbeda dibanding orang dewasa karena struktur fisik anak dan dewasa berbeda mulai dari besarnya ukuran hingga aspek kematangan fisiko. Proses fisiologis anak dengan dewasa mempunyai perbedaan dalam hal fungsi tubuh dimana orang dewasa cenderung sudah mencapai kematangan. Kemampuan berpikir anak dengan dewasa berbeda dimana fungsi otak dewasa sudah matang.

Sedangkan anak masih dalam proses perkembangan. Demikian pula dalam hal tanggapan terhadap pengalaman masa lalu berbeda, pada anak cenderung kepada dampak psikologis yang apabila kurang mendukung maka akan berdampak pada tumbuh kembang anak sedangkan pada dewasa cenderung sudah mempunyai mekanisme koping yang baik dan matang.

2. Sehat-sakit

Rentang sehat-sakit merupakan batasan yang dapat diberikan bantuan pelayanan keperawatan pada anak adalah suatu kondisi anak berada dalam status kesehatan yang meliputi sejahtera, sehat optimal, sehat, sakit, sakit kronis dan meninggal. Rentang ini suatu alat ukur dalam menilai status kesehatan yang bersifat dinamis dalam setiap waktu. Selama dalam batas rentang tersebut anak membutuhkan bantuan perawat baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti apabila anak dalam rentang sehat maka upaya perawat untuk meningkatkan derajat kesehatan sampai mencapai taraf kesejahteraan baik fisik, sosial maupun spiritual. Demikian sebaliknya apabila anak dalam kondisi kritis atau meninggal maka perawat selalu memberikan bantuan dan dukungan pada keluarga. Jadi batasan sehat secara umum dapat diartikan suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan.

3. Lingkungan

Lingkungan dalam paradigma keperawatan anak yang dimaksud adalah lingkungan eksternal maupun internal yang berperan dalam perubahan status kesehatan anak. Lingkungan internal seperti anak lahir dengan kelainan bawaan maka di kemudian hari akan terjadi perubahan status kesehatan yang cenderung sakit, sedang lingkungan eksternal seperti gizi buruk, peran orang tua, saudara, teman sebaya dan masyarakat akan mempengaruhi status kesehatan anak.

4. Keperawatan

Bentuk pelayanan keperawatan yang diberikan kepada anak bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dengan melibatkan keluarga. Upaya tersebut dapat tercapai dengan keterlibatan langsung pada keluarga mengingat keluarga merupakan sistem terbuka yang anggotanya dapat dirawat secara efektif dan keluarga sangat berperan dalam menentukan keberhasilan asuhan keperawatan, di samping keluarga mempunyai peran sangat penting dalam perlindungan anak dan mempunyai peran memenuhi kebutuhan anak. Peran lainnya adalah mempertahankan kelangsungan hidup bagi anak dan keluarga, menjaga keselamatan anak dan mensejahterakan anak untuk mencapai masa depan anak yang lebih baik, melalui interaksi tersebut dalam terwujud kesejahteraan anak.

Keluarga

Keluarga merupakan perkumpulan dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan tiap-tiap anggota keluarga selalu berinteraksi satu dengan yang lain. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan ((Mubarak, 2011; Setiadi, 2012). Sedangkan menurut Friedman keluarga adalah unit dari masyarakat dan merupakan lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat, hubungan yang erat antara anggotanya dengan keluarga sangat menonjol sehingga keluarga sebagai lembaga atau unit layanan perlu di perhitungkan.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Sulistyo, 2012; Padila, 2012).

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan secara umum bahwa keluarga itu terjadi jika ada:

1. Ikatan atau persekutuan (perkawinan atau kesepakatan)
2. Hubungan (darah/adopsi/kesepakatan)
3. Tinggal bersama dalam satu atap (serumah)
4. Ada peran masing-masing anggota keluarga
5. Ikatan emosional

Klasifikasi Keluarga

Klasifikasi keluarga dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Keluarga inti (*nuclear family*) Keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak yang di peroleh dari keturunannya atau keduanya.
2. Keluarga besar (*extended family*) Keluarga inti ditambah anggota keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah (kakek-nenek, paman-bibi).

Secara Modern Perkembangannya individu dan meningkatnya rasa individualisme maka pengelompokan tipe keluarga selain keluarga diatas adalah:

1. *Tradisional Nuclear* Keluarga inti (ayah, ibu dan anak) tinggal dalam satu rumah ditetapkan oleh sanksi-sanksi legal dalam suatu ikatan perkawinan, satu atau keduanya dapat bekerja di luar rumah.
2. *Reconstituted Nuclear* Pembentukan baru dari keluarga inti melalui perkawinan kembali suami/istri, tinggal dalam pembentukan suatu rumah dengan anak-anaknya, baik itu bawaan dari perkawinan lama maupun hasil dari perkawinan baru, satu/keduanya dapat bekerja diluar rumah.
3. *Niddle Age/ Aging Couple* Suami sebagai pencari uangistri dirumah/keduanya bekerja dirumah, anak-anak sudah meninggalkan rumah karena sekolah/perkawinan/meniti karier.
4. *Dyadic Nuclear* Suami istri yang sudah berumur dan tidak mempunyai anak yang keduanya atau salah satu bekerja diluar rumah.
5. *Single Parent* Satu orang tua sebagai akibat perceraian atau kematian pasangannya dan anak-anaknya dapat tinggal dirumah atau diluar rumah.
6. *Dual Carier* Yaitu suami istri atau keduanya orang karir dan tanpa anak.
7. *Commuter Married* Suami istri atau keduanya orang karier dan tinggal terpisah pada jarak tertentu. Keduanya saling mencari pada waktu-waktu tertentu.
8. *Single Adult* Wanita atau Pria dewasa yang tinggal sendiri dan tidak adanya keinginan untuk kawin.
9. *Three Generation* Yaitu generasi atau lebih tinggal dalam satu rumah.

10. *Institutional* Yaitu anak-anak atau orang-orang dewasa tinggal dalam suatu panti-panti.
11. *Communal* Yaitu suatu rumah terdiri dari dua atau lebih pasangan yang monogami dengan anak-anaknya dan bersama-sama dalam penyediaan fasilitas.
12. *Group Marriager* Yaitu suatu perumahan yang terdiri dari orang tua dan keturunannya di dalam satu kesatuan keluarga dan tiap individu adalah kawin dengan yang lain dan semua adalah orang tua dari anak-anak.
13. *Unmarried Parent and Child* Yaitu ibu dan anak dimana perkawinan tidak dikehendaki, anaknya diadopsi.
14. *Cohibing couple* Yaitu dua orang atau satu pasangan yang tinggal bersama tanpa kawin.
15. *Gay and Lesbian Family* Yaitu keluarga yang dibentuk oleh pasangan yang sejenis kelamin sama.

Fungsi Keluarga

Fungsi Keluarga Keluarga memiliki 5 fungsi yaitu:

1. Fungsi Afektif Fungsi afektif berhubungan erat dengan fungsi internal keluarga yang merupakan basis kekuatan keluarga. Fungsi afektif berguna untuk pemenuhan kebutuhan psikososial. Keberhasilan fungsi afektif tampak pada kebahagiaan dan kegembiraan dari seluruh anggota keluarga. Komponen yang perlu dipenuhi oleh keluarga dalam melaksanakan fungsi afektif adalah (Friedman, M.M *et al.*, 2014):
 - a. Saling mengasuh yaitu memberikan cinta kasih, kehangatan, saling menerima, saling mendukung antar anggota keluarga.
 - b. Saling menghargai, bila anggota keluarga saling menghargai dan mengakui keberadaan dan hak setiap anggota keluarga serta selalu mempertahankan iklim positif maka fungsi afektif akan tercapai.
 - c. Ikatan dan identifikasi ikatan keluarga di mulai sejak pasangan sepakat memulai hidup baru.
2. Fungsi Sosialisasi di mulai sejak manusia lahir. Keluarga merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi, misalnya anak yang baru lahir dia akan menatap ayah, ibu dan orang-orang yang ada disekitarnya. Dalam hal ini keluarga dapat Membina hubungan sosial pada anak, Membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, dan Menaruh nilai-nilai budaya keluarga.

3. Fungsi Reproduksi untuk meneruskan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Maka dengan ikatan suatu perkawinan yang sah, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis pada pasangan tujuan untuk membentuk keluarga adalah meneruskan keturunan.
4. Fungsi Ekonomi Merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga seperti memenuhi kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal.
5. Fungsi Perawatan Kesehatan Keluarga juga berperan untuk melaksanakan praktik asuhan keperawatan, yaitu untuk mencegah gangguan kesehatan atau merawat anggota keluarga yang sakit. Keluarga yang dapat melaksanakan tugas kesehatan berarti sanggup menyelesaikan masalah kesehatan.

Tugas Keluarga Dalam Bidang Keluarga

Sesuai dengan fungsi pemeliharaan kesehatan, keluarga mempunyai tugas dibidang kesehatan yang perlu dipahami dan dilakukan. Freeman membagi 5 tugas keluarga dalam bidang kesehatan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Mengenal masalah kesehatan
Perubahan sekecil apapun yang dialami anggota keluarga secara tidak langsung menjadi perhatian dan tanggung jawab keluarga, maka apabila menyadari adanya perubahan perlu segera dicatat kapan terjadinya, perubahan apa yang terjadi dan seberapa besar perubahannya.
2. Mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat bagi keluarga.
Tugas ini merupakan upaya keluarga yang utama untuk mencari pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan pertimbangan siapa keluarga yang mempunyai kemampuan memutuskan untuk menentukan tindakan keluarga maka segera melakukan tindakan yang tepat agar masalah kesehatan dapat dikurangi atau bahkan teratasi. Jika keluarga mempunyai keterbatasan sebaiknya meminta bantuan orang lain disekitar lingkungan keluarga.
3. Memberikan keperawatan anggotanya yang sakit atau yang tidak dapat membantu dirinya sendiri karena cacat atau usianya yang terlalu muda. Perawatan ini dapat dilakukan dirumah apabila keluarga memiliki kemampuan melakukan tindakan untuk pertolongan pertama atau pelayanan kesehatan untuk memperoleh tindakan lanjut agar masalah yang lebih parah tidak terjadi.
4. Mempertahankan suasana dirumah yang menguntungkan kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga.

5. Mempertimbangkan hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga kesehatan (permanfaatan fasilitas kesehatan yang ada).

Tahap-Tahap Perkembangan Keluarga

Berdasarkan konsep Duvall dan Miller, tahapan perkembangan keluarga dibagi menjadi 8 (delapan):

1. Keluarga Baru (*Bergannning Family*)
Pasangan baru nikah yang belum mempunyai anak. Tugas perkembangan keluarga dalam tahap ini antara lain yaitu membina hubungan intim yang memuaskan, menetapkan tujuan bersama, membina hubungan dengan keluarga lain, mendiskusikan rencana memiliki anak atau KB, persiapan menjadi orangtua dan memahami prenatal care (pengertian kehamilan, persalinan dan menjadi orangtua).
2. Keluarga Dengan anak Pertama < 30 bulan (*child bearing*)
Masa ini merupakan transisi menjadi orangtua yang akan menimbulkan krisis keluarga. Tugas perkembangan keluarga pada tahapan ini antara lain yaitu adaptasi perubahan anggota keluarga, mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan, membagi peran dan tanggung jawab, bimbingan orangtua tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, serta konseling KB post partum 6 minggu.
3. Keluarga dengan anak pra sekolah
Tugas perkembangan dalam tahap ini adalah menyesuaikan kebutuhan pada anak pra sekolah (sesuai dengan tumbuh kembang, proses belajar dan kontak sosial) dan merencanakan kelahiran berikutnya.
4. Keluarga dengan anak sekolah (6-13 tahun)
Keluarga dengan anak sekolah mempunyai tugas perkembangan keluarga seperti membantu sosialisasi anak terhadap lingkungan luar rumah, mendorong anak untuk mencapai pengembangan daya intelektual, dan menyediakan aktivitas anak.
5. Keluarga dengan anak remaja (13-20 tahun)
Tugas perkembangan keluarga pada saat ini adalah pengembangan terhadap remaja, memelihara komunikasi terbuka, mempersiapkan perubahan sistem peran dan peraturan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anggota keluarga.

6. Keluarga dengan anak dewasa

Tugas perkembangan keluarga mempersiapkan anak untuk hidup mandiri dan menerima kepergian anaknya, menata kembali fasilitas dan sumber yang ada dalam keluarganya.

7. Keluarga usia pertengahan (*middle age family*)

Tugas perkembangan keluarga pada saat ini yaitu mempunyai lebih banyak waktu dan kebebasan dalam mengolah minat sosial, dan waktu santai, memulihkan hubungan antara generasi muda-tua, serta persiapan masa tua.

8. Keluarga lanjut usia

Dalam perkembangan ini keluarga memiliki tugas seperti penyesuaian tahap masa pensiun dengan cara merubah cara hidup, menerima kematian pasangan, dan mempersiapkan kematian, serta melakukan life review masa lalu.

Tugas Keluarga Dalam Bidang Kesehatan

Berikut adalah tugas keluarga dalam bidang kesehatan:

1. Keluarga mampu mengenal masalah kesehatan.
2. Keluarga mampu mengambil keputusan untuk melakukan tindakan.
3. Keluarga mampu melakukan perawatan terhadap anggota keluarga yang sakit.
4. Keluarga mampu menciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan kesehatan.
5. Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang terdapat dilingkungan setempat.

Keperawatan Keluarga

Keperawatan keluarga adalah sebuah pelayanan secara holistik di mana keluarga serta bagian-bagiannya menjadi pusat pelayanan yang tahap pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi hingga evaluasi melibatkan seluruh anggota keluarga di dalamnya (Kholifah & Widagdo, 2016). Keperawatan keluarga merupakan proses asuhan keperawatan yang diberikan dalam kondisi sehat maupun sakit pada seluruh anggota keluarga untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi (Friedman et al., 2014).

Menurut Potter *et al.*, (2020), keperawatan keluarga ialah pemberian layanan kesehatan dengan membantu anggota keluarga mempertahankan kesehatan yang setinggi-tingginya melewati dari pengalaman sakit yang sebelumnya. Keperawatan keluarga yaitu pemberian layanan kesehatan secara holistik mulai dari pengkajian,

diagnosis, intervensi, implementasi hingga evaluasi terhadap seluruh anggota keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan semaksimal mungkin.

Keperawatan keluarga memiliki aspek unik karena proses pelayanan diberikan secara keseluruhan anggota keluarga sebagai suatu sistem yang saling mempengaruhi. Keperawatan keluarga dapat diberikan pada semua bentuk keluarga dengan berbagai kondisi kesehatan serta kondisi lainnya tempat pemberian layanan keperawatan keluarga. Praktik keperawatan keluarga menekankan keluarga yang berorientasi kesehatan mencakup perspektif holistik, sistemik dan interaksional dalam rangka meningkatkan kekuatan keluarga tersebut.

Tujuan Keperawatan Keluarga

Menurut Ali (2010), keperawatan keluarga secara umum bertujuan meningkatkan kesadaran, keinginan dan kemampuan keluarga dalam menambah, mencegah, memelihara kesehatan hingga mencapai tahap seoptimal mungkin, sehingga dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan produktif. Tujuan khusus dari keperawatan keluarga yaitu meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan keluarga dalam hal:

1. Mengidentifikasi masalah kesehatan yang tengah dihadapi keluarga.
2. Memutuskan tentang pemecahan masalah yang dihadapi
(sebagai contoh, masalah akan diselesaikan sendiri dengan cara berobat ke pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau praktik keperawatan/kedokteran).
3. Peningkatan mutu kesehatan keluarga.
4. Pencegahan munculnya penyakit /masalah kesehatan pada keluarga.
5. Melaksanakan upaya penyembuhan atau pemecahan masalah kesehatan keluarga melalui asuhan keperawatan di rumah.
6. Melaksanakan upaya rehabilitasi pasien melalui asuhan keperawatan di rumah.
7. Membantu tenaga profesional kesehatan/keperawatan dalam penanggulangan penyakit atau masalah kesehatan mereka di rumah, rujukan kesehatan dan rujukan medik.

Tujuan keperawatan keluarga yang dikemukakan Leavell dalam Friedman et al. (2014) menggunakan kerangka yang dibuat sebagai tingkat pencegahan dan berfungsi sebagai dasar praktik kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan komunitas. Tingkat pencegahan yang dimaksud telah mencakup seluruh kondisi sehat dan sakit dan tujuan sesuai dengan tingkatan.

Tingkatan pencegahan yang dimaksud yaitu:

1. Pencegahan primer

Pencegahan ini melibatkan promosi kesehatan dan tindakan pencegahan yang spesifik yang direncanakan untuk menjaga individu terbebas dari penyakit ataupun cedera. Faktor lain yang mengarahkan perhatian pada promosi kesehatan yaitu peningkatan kesadaran tentang pikiran dan tubuh adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Integrasi tubuh dan pikiran dibutuhkan dengan adanya pemulihan dan kesejahteraan. Pencegahan ini juga mempunyai hambatan, yaitu dana untuk mendapatkan bantuan perawatan secara profesional atau akses ke penyuluhan kesehatan dan kebutuhan untuk konseling. Hambatan selanjutnya ialah banyaknya profesional yang menampilkan contoh buruk bagi pasien, sehingga keluarga yang terlibat tidak cukup mendapat perhatian. Kemudian hambatan lainnya lagi yaitu nilai sistem nilai yang materialistis, permasalahan sosial terkait pelayanan kesehatan, pekerjaan, pendidikan yang tidak adekuat bagi masyarakat.

2. Pencegahan sekunder

Tingkatan pencegahan ini terdiri dari deteksi dini, diagnosis dan juga terapi. Kunci dari pencegahan sekunder ini melibatkan diagnosis dini dan terapi secepatnya. Apabila penyakit menghalangi penyembuhan, maka pencegahan primer ini bertujuan untuk mengurangi penyakit semakin memburuk atau mencegah kecatatan pasien. Perawat memiliki peran penting yaitu melakukan pengkajian terhadap anggota keluarga agar mendapat pelayanan. Pencegahan ini melibatkan deteksi mengenai patologi atau disfungsi keluarga. Pendidikan kesehatan sering diperlukan untuk meningkatkan pemahaman seluruh anggota keluarga tentang manfaat dari pengkajian tertentu. Rujukan dan tindak lanjut yang seksama menjadi bagian dari pencegahan ini.

3. Pencegahan tersier

Pencegahan ini mencakup pemulihan dan rehabilitasi, direncanakan untuk meminimalkan kecacatan pasien dan memaksimalkan tingkatan fungsi dirinya. Perawatan untuk pemeliharaan individu yang mengalami sakit kronis menjadi bagian dari rubrik ini. Tujuan klinik perawat dengan keluarga termasuk penyembuhan penderitaan secara emosional, fisik, atau spiritual. Proses belajar menjalani kehidupan dengan kecacatan permanen, pasien dan keluarga butuh dukungan yang sangat besar dan penyuluhan yang ekstensif tentang perawatan mandiri dan perawatan yang bergantung dengan orang lain. Selain langsung berperan, perawat keluarga yang paling signifikan ialah sebagai penemu kasus, advokat, pendidik dan konselor bagi pasien atau keluarga.

Peran Perawat Dalam Keperawatan Keluarga

Dalam memberikan asuhan keperawatan kesehatan keluarga ada beberapa peranan yang dapat dilakukan oleh perawat antara lain:

1. Pengenal kesehatan Perawat membantu keluarga untuk menganalisis penyimpangan dari keadaan normal tentang kesehatannya dengan menganalisis data secara obyektif serta membuat keluarga sadar akan akibat masalah tersebut dalam perkembangan keluarga.
2. Pemberi pelayanan pada anggota keluarga yang sakit Sering kali kontak pertama kali dengan keluarga dimulai dengan adanya anggota keluarga yang sakit baik pertemuan langsung maupun rujukan.
3. Koordinator pelayanan kesehatan dan keperawatan kesehatan keluarga Yaitu berperan dalam mengkoordinasi pelayanan kesehatan keluarga baik secara berkelompok maupun individu.
4. Fasilitator Yaitu dengan cara menjadikan pelayanan kesehatan itu mudah dijangkau oleh keluarga dan membantu mencari jalan pemecahannya.
5. Pendidik kesehatan Yaitu merubah perilaku keluarga dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku yang sehat.
6. Penyuluh dan konsultan Yang berperan dalam memberikan petunjuk tentang asuhan keperawatan dasar dalam keluarga.

Proses Keperawatan Keluarga

Proses keperawatan menggunakan perawatan untuk individu dalam keluarga (keluarga sebagai konteks) atau seluruh keluarga (keluarga sebagai pasien). Untuk melakukan proses asuhan keluarga, perawat dapat menggunakan pendekatan: Kaji semua anggota dalam konteks keluarga secara individual, kaji keluarga sebagai pasien, dan kaji keluarga sebagai sistem (Potter et al., 2020). Memberikan perawatan dan dukungan secara cukup bagi keluarga merupakan hal utama dalam pengkajian keluarga. Perawat memiliki peran penting dalam membantu keluarga beradaptasi dengan penyakit akut, kronis, dan terminal.

Perawat perlu memahami unit keluarga dan makna sakit bagi pasien dan fungsi keluarganya. Selanjutnya perawat perlu mengkaji dampak penyakit pada struktur keluarga dan dukungan yang dibutuhkan oleh keluarga. Perawat juga dapat menggabungkan pengetahuan penyakit dan kaji pasien serta keluarganya dan perilaku yang ditampilkan. Perawat mengkaji bentuk dan keanggotaan keluarga, tempat bercerita jika anggota keluarga tersebut sakit. Perawat menanyakan konsep keluarga, tempat tinggal, struktur keluarga, yang menentukan kekuatan

struktur di dalam keluarga itu, serta pola peran dan pembagian tugas dalam keluarga. Perawat juga perlu mengkaji kemampuan beradaptasi terhadap masalah yang sedang dihadapi pasien dan keluarganya, capaian tugas perkembangannya. Selain itu, juga penting mengkaji dukungan ekonomi baik dari anggota keluarga tersebut maupun lingkungan sosialnya (Potter *et al.*, 2020).

Hambatan Dalam Keperawatan Keluarga

Praktik keperawatan keluarga memiliki hambatan dalam prosesnya. Hambatan tersebut yaitu:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana dari perawat.
2. Perawat kebanyakan berorientasi pada individu dan tidak ditujukan kepada seluruh anggota keluarga.
3. Pendidikan keluarga yang rendah.
4. Terbatasnya sumber daya keluarga.
5. Kebiasaan yang telah lama melekat dan dipakai
6. Sosial budaya yang tidak mendukung.

Perspektif Keperawatan Keluarga

Menurut Potter *et al.*, (2020), Keperawatan keluarga merupakan tidak memandang ciri khas dan latar usia, berapapun usianya, merupakan anggota dari berbagai macam tipe bentuk keluarga. Keperawatan keluarga memiliki beberapa pendekatan menurut Potter *et al.* (2020), yaitu:

1. Keluarga sebagai konteks

Kesehatan dan perkembangan anggota keluarga dalam bertahan terhadap lingkungan tertentu menjadi sebuah fokus pada pendekatan ini. Pengkajian dilakukan terhadap seberapa banyak keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar pasien yang juga anggota keluarganya. Kebutuhan yang dipenuhi bervariasi bergantung pada tingkatan dan situasi perkembangan individu. Perawat juga perlu memperhatikan kemampuan mereka dalam pemenuhan kebutuhan psikologis pasien.

Keluarga dilibatkan oleh perawat dalam berbagai tingkatan. Pada kasus-kasus tertentu, perawat melakukan pengkajian sebagai bagian dari sistem pendukung sosial pasien, namun sedikit saja keterlibatan keluarga dalam pelaksanaan asuhan keperawatan pada klien. Kasus yang lain, perawat banyak melibatkan keluarga dalam proses perawatan klien. Pengkajian

memperhatikan pengaruh nyata dan sosio emosional keluarga terhadap klien dan dimasukkan dalam rencana terapi pasien. Bidang spesialisasi lain juga memandang keluarga sebagai lingkungan sosial yang penting bagi pasien dan sumber dukungan sosial utama.

2. Keluarga sebagai pasien

Fokus utama asuhan keperawatan bergantung dari perawat memandang keluarga sebagai pasien, proses dan hubungan keluarga seperti pola pengasuhan keluarga. Keluarga menjadi bagian yang terdepan dan anggota keluarga atau pasien berada pada konteks. Pengkajian keperawatan menitikberatkan pada pola dan proses yang menetap dengan pencapaian serta pemeliharaan kesehatan individu. Misalnya pada kasus perawatan keluarga, perawat mengkaji orang yang akan menjadi pengasuh pasien dalam keluarga tersebut, perbedaan peran keduanya, hingga cara berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien. Perencanaan perawatan yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan pasien, tetapi juga kebutuhan keluarga. Masalah keluarga yang kompleks membutuhkan pendekatan yang lebih luas dan memerlukan rujukan jika memang diperlukan. Hubungan antara penyakit, anggota keluarga, dan keluarga dalam keperawatan sistem keluarga dikaji menggunakan perspektif ini lalu dimasukkan dalam rencana terapi. Keperawatan sistem keluarga menggunakan pengkajian klinis lanjut dan skill intervensi berdasarkan bauran keperawatan, terapi dan teori sistem keluarga. Berdasarkan hal tersebut, ini menunjukkan bahwa praktik keperawatan ini tidak hanya ditujukan pada keseluruhan keluarga, namun juga individu, keluarga hingga sistem yang lebih besar lagi.

3. Keluarga sebagai sistem

Keluarga sebagai sebuah sistem menunjukkan bahwa keperawatan akan dilakukan pada semua anggota keluarga (keluarga sebagai konteks) dan unit keluarga (keluarga sebagai pasien) menggunakan segala sumber daya yang ada di lingkungan, sosial dan psikologis. Keluarga sebagai sistem menggunakan dua perspektif sebelumnya (keluarga sebagai konteks dan keluarga sebagai pasien), namun tetap memperhatikan sumber daya keluarga yang tersedia. Keluarga juga dipandang sebagai subsistem dan sistem yang lebih besar (komunitas), sebagai lembaga dasar di masyarakat seperti pendidikan, kesejahteraan atau agama.

Referensi

- Ali, Z. (2010). Pengantar Keperawatan Keluarga. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- A Potter & Perry, A.G. (2020) Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep,Proses, dan Praktik, edisi 4, Volume.2. Jakarta.
- Ali, (2010). Konsep dukungan keluarga. Jakarta: salemba medika
- Alligood, M. R. (2017). Pakar Teori Keperawatan dan Karya Mereka. Elsevier Ltd.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2014). Buku Ajar Keperawatan Keluarga Riset, Teori, & Praktik (E. Tiar (ed.); 5th ed.). Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Gusti, S. (2013). Buku Ajar Asuhan Keperawatan Keluarga. CV. Trans Info Media.
- Hapsari, E. D. (2019). "Penerapan Membaca Permulaan untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa". AKSARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra, 20(1), 10–24. <https://doi.org/10.23960/aksara/v20i1.pp10-24>
- Kholifah, S. N., & Widagdo, W. (2016). Keperawatan Keluarga dan Komunitas. Pusdik SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., Hall, A. M., Crisp, J., Douglas, C., Rebeiro, G., & Waters, D. (2020). Dasar-Dasar Keperawatan Volume 1, Edisi Indonesia ke-9. Elsevier Ltd.
- Susilaningrum dkk. (2013). Asuhan Keperawatan Bayi Dan Anak. Jogjakarta: Mediacion .
- Suryaningsih, I. B., L. Farida, O. Revanica, and A. A. K. M. 2019. The Effect Of Coupon Sales Promotion, Online Customer Review And Perceived Enjoyment On Repurchase Intention In eCommerce Shopee. International Journal Of Scientific & Technology Research 8(8):435-440.
- Siregar, D., Manurung, E. I., Sihombing, R. M., Pakpahan, M., Sitanggang, Y. F., Rumerung, C. L., Arkianti, M. M. Y., Tompunu, M. R. G., Trisnadewi, N. W., Tambunan, E. H., Simbolon, I., Kartika, L., & Triwahyuni, P. (2020). Keperawatan Keluarga. Yayasan Kita Menulis.
- Wulandari dan Erawati, (2016) Buku Ajar Keperawatan Anak.Yogyakarta : Pustaka pelajar

BAB 2

Pendidikan Kesehatan Anak: Pencegahan Kecelakaan dan Cedera

Yupi Supartini, S.Kp. M.Sc.

Pendahuluan

Keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal bersama dan memiliki hubungan kekerabatan baik itu melalui perkawinan, kelahiran atau adopsi. Keluarga merupakan sistem terbuka dimana satu dengan yang lainnya saling berhubungan, saling mempengaruhi dan memberi dampak, serta memberikan dan menerima feedback atau umpan balik dari lingkungannya (Kaakinen, et al. 2018). Keluarga adalah tempat dimana anak bernaung, terdiri dari ayah, ibu dan anak sebagai keluarga inti. Pada masyarakat Asia seperti Indonesia, Sebagian besar bentuk keluarga adalah keluarga luas (extended family, dimana selain ayah, ibu dan anak juga tinggal bersama mereka yaitu kakek, nenek atau saudara ayah atau saudara ibu. Budaya masyarakat Indonesia seperti di daerah Minang (Sumatra Barat), keluarga luas dapat terdiri dari 3 (tiga) generasi tinggal bersama dalam satu rumah, yang mereka kenal dengan *Rumah Gadang*. Tentunya luas ukuran keluarga ini akan memberi dampak pada pola komunikasi dan pola asuh orang tua kepada anaknya.

Orang tua anak (ayah dan atau ibu), kandung atau angkat, memiliki peran penting dalam pengasuhan pada anak, selama proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Berikut ini adalah peran orang tua terhadap anaknya:

1. Memberikan kasih sayang dan dorongan pada anak untuk meningkatkan kemampuannya.
2. Memberikan pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti sandang, pangan dan papan (makan, minum, pakaian dan tempat tinggal untuk keluarga).

3. Memfasilitasi perkembangan anak sesuai dengan tahapannya.
4. Mengajarkan nilai-nilai etika dan budi pekerti untuk memiliki akhlak yang baik.
5. Memberi contoh suri tauladan (role model).
6. Memberikan pengawasan terhadap perkembangan anak.
7. Mengajarkan keterampilan dasar seperti membaca, berhitung, menulis dan menggambar.

Dalam melaksanakan perannya, orang tua mengikuti tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak, mulai sejak dilahirkan, masa bayi, masa toddler, masa pra sekolah, masa sekolah dan sampai pada masa remaja. Di setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut ada tugas-tugas perkembangan yang harus dijalankan oleh anak, dengan bantuan dan bimbingan dari orang tuanya. Tantangan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang dihadapi anak seringkali juga menjadi tantangan bagi orang tua nya, dan dengan komunikasi yang baik antara anak dan orang tuanya akan membawa anak pada keberhasilan dalam melalui semua tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Engan demikian peran orang tua dalam membantu anak melewati semua tugas perkembangannya menjadi sangat penting, karena dapat membantu anak untuk belajar menjadi cerdas dan tumbuh menjadi anak yang memiliki rasa percaya diri dan siap menjadi bagian dari anggota masyarakat di kelak kemudian hari.

Dalam perkembangan anak, orang tua dapat berperan sebagai berikut:

1. Membimbing anak untuk dapat belajar secara mandiri, dengan mengatur waktu kegiatan dalam kesehariannya dan menyelesaikan tugas-tugasnya yang diberikan dari sekolah.
2. Memfasilitasi anak untuk dapat belajar di rumah dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang tersedia.
3. Memberikan perhatian dan kasih sayang sesuai dengan kebutuhan anak di setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya yang dapat berbeda dari satu tahap ke tahap lainnya.
4. Memberikan pemantauan dan pengawasan pertumbuhan dan perkembangan anak, dan memintakan konsultasi kepada ahli jika diperlukan oleh anak sesuai kondisinya.
5. Mendidik anak dengan etika dan nilai-nilai sehingga anak dapat membentuk kepribadian yang baik dan matang sesuai dengan capaian perkembangannya.

Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Dalam Konteks Upaya Pencegahan Kecelakaan

Masa kanak-kanak merupakan masa dimana mereka berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, dicirikan dengan adanya rasa ingin tahu mereka terhadap lingkungan sekitar yang sangat tinggi, keinginan mengeksplorasi dan mengembangkan kemampuannya untuk meningkatkan maturasi atau kematangan baik secara fisik, psikologis, sosial dan spiritual dalam konteks keluarga dan berada dalam sistem lingkungan masyarakat. Hal ini terutama terkait dengan kematangan perkembangan motorik kasar ataupun halus. Eksplorasi yang dilakukan anak menggunakan seluruh panca indra mereka dan seringkali tidak memperhatikan potensi bahaya yang dapat terjadi dan menimbulkan kecelakaan. Cedera atau luka seringkali terjadi sebagai dampak kecelakaan tersebut dan jika menimbulkan bekas maka hal ini akan berdampak pada '*gangguan body image*' terutama kelak ditahapan usia lebih besar, remaja atau dewasa muda. Kecelakaan yang dialami anak dapat terjadi karena jatuh, tertabrak, tenggelam, luka bakar, keracunan dan kondisi serius lainnya yang dapat menyebabkan cedera hebat atau bahkan akan berakhir dengan kecacatan dan kematian.

Perawat anak sebagai salah satu anggota tim kesehatan yang bekerja dengan anak dan orang tuanya, memiliki peran penting yaitu sebagai pembela (advocacy), pendidik, konselor, kordinator, pembuat keputusan etik, perencana kesehatan, pembina hubungan terapeutik, pemantau, evaluator dan peneliti (Supartini, 2003). Dengan pendekatan interdisiplin, perawat anak melakukan kordinasi dan kolaborasi dengan tim kesehatan lain, dengan tujuan agar dapat melaksanakan asuhan yang komprehensif dan holistik, karena perawat anak memiliki posisi kunci untuk menjadi kordinator pelayanan kesehatan selama 24 jam berada di samping pasien.

Terkait dengan upaya pendidikan keluarga dan pencegahan kecelakaan, peran penting yang dimiliki perawat anak adalah untuk membantu orang tua dan anak menghadapi tugas-tugas perkembangan anak, sehingga dapat melalui semua tahapan perkembangan dengan optimal tanpa mengalami trauma atau cedera. Peran tersebut terutama dalam rangka pemberian advokasi dengan memberikan pembekalan pada orang tua berupa petunjuk antisipasi atau ***anticipatory guidance***

Selanjutnya mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan bimbingan antisipasi atau ***anticipatory guidance***.

Pengertian *Anticipatory Guidance*

Petunjuk antisipasi atau *Anticipatory guidance* secara harfiah berasal dari Bahasa Inggris *Anticipatory* yang artinya lebih dahulu dan *guidance* artinya petunjuk. *Anticipatory guidance* artinya petunjuk yang perlu diketahui terlebih dahulu oleh orang tua agar dapat mengarahkan dan membimbing anak dengan bijaksana sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai tahapannya (Nursalam, 2025).

Susilaningrum dkk, (2013) menjelaskan tentang *Anticipatory Guidance* adalah penjelasan atau petunjuk bagi orang tua yang perlu diketahui lebih dahulu sehingga dapat membimbing, mengarahkan anak dengan bijak, agar pertumbuhan dan perkembangannya tercapai secara optimal. Ada beberapa petunjuk yang perlu dipahami bagi orang tua untuk membantu, mengasuh mengatasi masalah pada anak dalam fase pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar dan benar.

Pengertian lain dari *Anticipatory guidance* adalah petunjuk atau penjelasan Doloksaribu, T.M dkk, yang diberikan kepada orang tua untuk membantu membimbing anak dalam tumbuh kembangnya. Petunjuk ini dapat menjadi pedoman dalam memberikan asuhan kepada anak dan membantu orang tua menghadapi tantangan yang mungkin terjadi pada anak (Marrilyn, 2022). Petunjuk antisipasi dibuat oleh perawat terkait tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga orang tua dapat memahami kondisi pertumbuhan dan perkembangannya serta apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anak.

Bimbingan antisipasi atau *anticipatory guidance* ini merupakan bantuan dari perawat terhadap orang tua dalam mempertahankan dan meningkatkan Kesehatan melalui Upaya pertahanan nutrisi yang adekwat, pencegahan kecelakaan dan supervise Kesehatan (Marlow, 1988). Manfaat dari bimbingan antisipasi bagi orang tua terutama untuk membantu orang tua menghadapi masalah dan tantangan yang mungkin terjadi pada anak dan membantu mereka membimbing anak secara bijak.

Perawat memiliki peran penting dalam memberikan arahan kepada orang tua untuk dapat membimbing anaknya sesuai tugas perkembangannya dengan baik, dengan menyadari kemampuan apa yang akan dicapai anak di tahapan yang akan dilaluinya termasuk bahaya kecelakaan (cedera) yang mungkin dapat terjadi dalam proses pencapaian kemampuan perkembangan di tahapan tersebut.

Peran penting diatas tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab perawat anak untuk membantu orang tua memahami tumbuh kembang anak dan melakukan berbagai Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan anak melalui Upaya pertahanan fisik, psikologis, mental dan sosial spiritual. Bimbingan antisipasi

yang telah diuraikan diatas adalah bantuan perawat terhadap orang tua dalam mempertahankan dan meningkatkan Kesehatan melalui Upaya pertahanan nutrisi yang adekwat, pencegahan kecelakaan dan supervisi Kesehatan (Supartini, 2003).

Dengan demikian, petunjuk antisipasi merupakan strategi yang tepat bagi perawat untuk meyakinkan kepada orang tua bahwa penting bagi mereka untuk menyadari adanya kebutuhan perkembangan spesifik pada anak di setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya sehingga orang tua dapat membantu anaknya untuk menyelesaikan tugas perkembangannya secara optimal tanpa mengalami kecelakaan atau cedera, sekalipun ada dapat diminimalkan (Marilyn, et al, 2022).

Pencegahan Kecelakaan Pada Anak

Kecelakaan merupakan peristiwa yang seringkali terjadi pada anak dan dapat menimbulkan kondisi yang fatal bahkan dapat berakhir dengan kematian. Proses tumbuh kembang pada anak berjalan sangat dinamis pada setiap tahapan perkembangannya. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau hal hal yang tidak diinginkan pada anak, perawat penting memberikan bimbingan atau petunjuk antisipasi pada orang tua, sehingga mereka memahami apa yang akan dialami anak atau apa yang akan terjadi pada tahapan perkembangan anak yang akan datang. Diharapkan disaat anak masuk pada periode pertumbuhan dan perkembangan di usia tertentu, maka orang tua sudah dapat membimbing anak dengan baik sesuai dengan harapan dari capaian tugas perkembangan anak. Bimbingan antisipasi yang dapat diberikan perawat pada orang tua berbeda setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dan upaya pencegahan kecelakaan tentunya disesuaikan dengan masa pertumbuhan dan perkembangan pada anak.

Pada semua tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak itu, orang tua lah yang bertanggung jawab untuk menjaga anaknya untuk tidak mengalami hal hal yang tidak diinginkan seperti cedera atau kecelakaan, dan orang tua lah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal dengan selamat. Dengan demikian orang tua harus memahami sikap dan perilaku anak yang ditunjukkan serta dapat menyadari adanya bahaya kecelakaan yang ada.

Sepertiga kasus kecelakaan pada anak terjadi di rumah dan lingkungan sekitarnya sehingga sangat penting bagi orang tua memahami bahaya kecelakaan/cedera pada anak di setiap tahapan perkembangannya (Doloksaribu, T.M dkk, 2023).

Melihat karakteristiknya, anak laki laki lebih aktif secara fisik, dibanding anak perempuan, sehingga akan lebih memiliki potensi untuk terjadi kecelakaan ketika

melakukan aktivitas bermain. Anak laki laki akan lebih banyak menggunakan kemampuan motorik kasarnya untuk permainan seperti main bola, bersepeda, memanjat pohon, perosotan, lari dan permainan lainnya. dibandingkan perempuan yang lebih banyak menggunakan motorik halus misalnya main boneka, masak masak an, menggambar, main halma, ular tangga, bekel, congklak dan permainan lainnya yang lebih banyak dilakukan secara statis dengan duduk bersama teman atau bermain sendiri saja.

Jika diantisipasi oleh orang tua, kecelakaan pada anak dapat dicegah atau diminimalisir. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memodifikasi lingkungan atau alat permainan yang aman bagi anak. Perawat harus memberikan dukungan kepada orang tua dalam memahami pertumbuhan dan perkembangannya termasuk potensi bahaya yg mengancam keamanan dan keselamatan anak, sehingga Petunjuk Antisipasi harus diberikan pada orang tua (Hockenberry et al, 2024).

Beberapa kecelakaan yang dapat terjadi pada anak dapat diuraikan sebagai berikut (Wong, 2004)

1. Masa Bayi

Kecelakaan yang dapat dialami oleh anak usia bayi diantaranya:

- a. Aspirasi benda asing yang berukuran kecil, seperti kacang kacangan, biji bijian, uang logam, kancing baju, permen.
- b. Jatuh/ cidera dari tempat tidur yang tidak menggunakan penghalang.
- c. Kepala terbentur tempat tidur atau meja /kursi ketika anak sudah mulai bisa merangkak tidak dalam pengawasan.
- d. Luka bakar karena tersiram air panas atau minyak panas ketika orang tua atau pegasuh menggendong bayi sambil bekerja atau bayi merangkak mendekati api.
- e. Tersedak oleh minuman susu dan minuman lainnya.
- f. Kecelakaan di kursi roda berjalan ketika anak sedang belajar berjalan menggunakan kursi roda.

Pencegahan kecelakaan dan upaya untuk menghindarinya yang dapat dilakukan oleh orang tua atau pengasuh adalah sebagai berikut

- a. Untuk menghindari aspirasi
Jauhkan benda benda kecil seperti kacang kacangan, permen, uang logam, kancing baju dari jangkauan anak dan simpan pada tempatnya yang tertutup dan aman serta tidak dapat dijangkau anak bayi. Ketika memberi makan atau minum susu, lakukan dengan posisi bayi di gendong atau duduk jika sudah bisa duduk dengan tetap dalam bantuan orang tua (digendong)

b. Untuk mencegah jatuh

Pasang pengaman tempat tidur anak terutama disaat bayi sedang tidur. Jika sedang makan usahakan anak duduk di kursi nya, jika ada tangga di dalam rumah, maka harus dipasang pintu penghalang terutama disaat anak sudah bisa merangkak, tutupi ujung meja atau kursi yang tajam dengan kain supaya tidak teraba tajam oleh anak, Tempatkan bayi atau anak di tempat tidur yang rendah (tidak tinggi) jika perlu tidurkan anak dibawah dengan alas karpet dan kasur bayi/anak.

c. Untuk mencegah luka bakar

Jauhkan anak dari api (lilin yang menyala ketika sedang mati lampu) dan jaga anak jangan sampai berjalan atau pergi ke dapur ketika kompor sedang menyala. Awasi anak ketika sedang bermain. Orang tua atau pengasuh tidak melakukan kegiatan lain ketika anak sedang bermain karena harus dalam pengawasan penuh, terlebih jika anak dalam pengawasan pengasuh. Dharus diingatkan pada pengasuh untuk tidak lengah memperhatikan anak. Selain itu tidak menggendong anak jika akan memasak atau membuat minuman/makanan panas karena diawatirkan bisa tersiram air panas dari minuman atau makanan.

d. Untuk mencegah keracunan

Tempatkan zat zat berbahaya seperti baygon atau Hits/obat nyamuk atau obat obat berbahaya lainnya di lemari, atau di tempat tinggi yang tidak bisa terjangkau anak, selain itu cermati makanan atau minuman yang diberikan pada bayi/anak jangan sampai sudah kadaluarsa, perhatikan tanggal kadaluarsanya.

e. Untuk mencegah kena sengatan listrik

Tempatkan alat alat listrik di tempat tinggi yang tidak terjangkau anak/bayi. Tutup saklar listrik jika posisinya rendah dan jika saklar sedang dipakai hati hati bayi/anak yang sudah bisa merangkak bisa mendapati benda itu. Jadi berikan penghalang agar bayi/anak tidak mendekat ke arah saklar Listrik dan atau tutup saklar listrik dengan penutupnya yang tepat. Akan lebih baik jika saklar Listrik posisinya diatas setinggi jangkauan orang dewasa.

Bagi anak yang berada di usia akhir masa bayi, lakukan edukasi pada orang tua tentang keterampilan yang akan dicapai anak di masa toddler, sebagai langkah antisipasi bagi orang tua pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak berikutnya.

2. Masa Toddler

Anak usia toddler adalah masa dimana anak sedang mengembangkan keterampilan motorik kasarnya, yang membuat mereka akan lebih banyak bergerak terus, berjalan mondar mandir, berjinjit, berlari, naik turun tangga, keluar masuk pintu kamar atau pintu pagar, bersepeda, main perosotan dan permainan lainnya yang menggunakan banyak kaki untuk bergerak atau motorik kasar. Kondisi anak yang terus bergerak dan seringkali tidak bisa diam ini merupakan karakteristik khas dari perkembangan anak di masa toddler.

Disamping pengembangan motorik kasar, anak usia toddler juga mengembangkan kemampuan motorik halusnya ketika mereka melakukan permainan. Misalnya menggenggam bola ketika bermain bola, menggenggam mainan atau alat tulis, menggenggam dan melempar benda kecil, membuka dan menutup lemari pakaian, lemari buku atau lemari lainnya. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar tanpa mengetahui adanya bahaya di dekatnya atau bahaya dari apa yang dia pegang, tetapi rasa ingin tahunya yang menuntun anak toddler untuk terus bergerak dan melakukan aktivitas bermainnya. Sementara itu kemampuan membaca dan mengenali tulisan belum dicapainya sehingga belum bisa mengenali bahaya dari apa yang dilihat. Melihat karakteristiknya, anak laki laki akan lebih banyak bergerak dari pada anak perempuan karena lebih aktif bergerak.

Sebagaimana karakteristiknya, anak toddler banyak memiliki potensi bahaya cedera/luka sebagai berikut:

- a. Jatuh atau cedera akibat mengendarai sepeda atau kena benda tajam.
- b. Keracunan dari makanan atau minuman kadaluarsa.
- c. Tertabrak kendaraan ketika lari mengejar bola keluar rumah yang kebetulan pagarnya terbuka.
- d. Luka bakar baik karena tersiram air panas, bermain korek api atau lilin.
- e. Tenggelam, ketika asyik berlari keluar rumah dan menemui selokan atau kolam di sekitar halaman rumah anak.
- f. Resiko kecelakaan akan lebih besar ketika anak lapar dan letih.
- g. Rasa ingin tau dan eksplorasi lingkungan, menyebabkan anak ingin mengetahui semua benda baru dan menarik nya untuk diamati dan dipelajarinya dengan seksama sehingga terkadang ini menjadi potensi bahaya bagi anak.

Untuk itu ada beberapa tindakan yang harus dilakukan agar bahaya tersebut diatas tidak terjadi atau dapat diminimalisir

- a. Lakukan pengawasan pada saat anak bermain terutama jika di dekat tangga, di dekat kolam, di halaman rumah.

- b. Simpanlah benda2 berbahaya seperti baygon atau pembunuh serangga di lemari ditempat yang tidak bisa dijangkau anak.
- c. Ajarkan anak untuk berenang.
- d. Ajarkan anak bermain sepeda dengan benar.
- e. Jauhkan anak dari kompor dan benda listrik berbahaya seperti setrikaan dan stop kontak, rapikan jika ada kabel listrik yang melintang atau menjuntai tdk pada tempatnya.
- f. Jka terlalu banyak bergerak, maka dapat menyebabkan anak kelelahan.Oleh karena itu diberikan waktu tidur siang untuk memberikan kesempatan istirahat.
- g. Jaga lantai untuk tidak basah, jaga anak ketika lantai sedang di pel.
- h. Jaga kamar mandi untuk tidak licin yang memungkinkan anak untuk jatuh.
- i. Perhatikan alat alat atau furnitur di kamar tidur ank, hindarkan juga anak agar tidak kena benturan benda benda yang ada di sekitar kamar tidur anak.
- j. Jika posisi rumah dipinggir jalan, buatlah pagar dan pintu harus selalu terkunci.
- k. Jika ada parit atau selokan disekitar rumah, tutuplah dengan papan atau dengan semen.
- l. Jangan meninggalkan anak disaat tidur tanpa memasang papan penghalang tempat tidur.
- m. Bagi anak yang berada di usia akhir masa toddler, penting edukasi pada orang tua tentang keterampilan yang akan dicapai anak di masa pra sekolah.

3. Masa Pra Sekolah

Pada anak di masa pra sekolah potensi bahaya yang dapat terjadi seringkali dilatar belakangi oleh karena anak belum menyadari adanya bahaya didekatnya, sementara kemampuan motorik anak akan semakin meningkat. Anak semakin trampil melakukan kegiatan fisik dan bermain tidak hanya di dalam rumah tapi mulai mengenal lingkungan di luar rumah. Anak mungkin juga sudah mengikuti Pendidikan anak usia dini (PAUD) dan mulai bertambah teman bermain serta pergaulan di luar rumah nya sendiri. Potensi bahaya tidak hanya di dalam rumah tetapi juga diluar rumah terutama di lingkungan sekolah PAUD

Orang tua harus bekerja sama dengan guru pembimbing atau pengasuh di PAUD tempat anak belajar untuk menjaga lingkungan yang aman bagi anak terutama selama anak belajar dan bermain di PAUD. Orang tua harus dapat memastikan keamanan area dan semua fasilitas yang ada di lembaga PAUD, sehingga hal ini akan mencegah terjadinya kecelakaan pada anak. Orang tua maupun guru pembimbing harus waspada dengan bahaya di sekitar yang dapat terjadi pada anak. Oleh karena itu harus selalu melakukan pengawasan penuh pada anak

karena kecelakaan juga bisa ditimbulkan oleh hal lain seperti interaksi antar anak yang satu dengan yang lain atau karena gerakan anak yang berlebihan.

Selain orang tuanya, anak juga harus mengenal lingkungan dengan semua fasilitas yang ada di PAUD, dengan penjelasan yang diberikan pada orang tua dan anaknya dan diingatkan bahwa setiap benda dan kejadian-kejadian di PAUD yang berpeluang dapat menyebabkan mencelakakan pada anak. Anak perlu dididik untuk disiplin memenuhi aturan yang berlaku di PAUD dan secara bertahap anak harus ditingkatkan kesadarannya bahwa disiplin mematuhi aturan akan menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.

Berikut ini adalah upaya pencegahan yang dapat dilakukan pada anak usia pra sekolah:

- a. Mengendalikan lingkungan di sekitar rumah maupun luar rumah yang aman
- b. Jaga lantai rumah jangan basah pada saat di pel atau ada air tumpah di lantai.
- c. Rumah dengan tangga yang curam dan tidak ada pegangan.
- d. Alat makan dan minum yang terbuat dari bahan yang dapat pecah.
- e. Adanya sumur air (sumur gali selongsong) yang terbuka.
- f. Adanya parit di depan atau di samping rumah yang tidak tertutup.
- g. Kompor atau alat memasak yang letaknya rendah dan dapat dijangkau anak.
- h. Rumah yang letaknya di pinggir jalan raya, terutama jika tidak ada pagar pengaman.
- i. Adanya kabel listrik yang berantakan/menjuntai.
- j. Stop kontak yang tidak tertutup dan dapat dijangkau anak.
- k. Penyimpanan obat-obatan (P3K) yang terbuka dan dapat dijangkau anak.
- l. Mendidik anak untuk mengenal potensi bahaya seperti menyebrang jalan, berlari atau melakukan permainan fisik di sekolah tanpa pengawasan.
- m. Menjauhkan benda-benda berbahaya dari anak seperti korek api atau pemantik dan benda berbahaya lainnya.
- n. Bagi anak yang berada di usia akhir masa pra sekolah, lakukan edukasi orang tua tentang keterampilan yang akan dicapai anak di masa sekolah.

4. Masa Sekolah

Di masa sekolah lingkungan anak semakin bertambah karena anak tidak hanya berada di lingkungan rumah tetapi di lingkungan luar rumah juga akan memakan waktu lebih lama karena kegiatan di sekolah tidak hanya belajar, anak juga dapat mengikuti kegiatan seperti PRAMUKA dan kegiatan pengembangan minat dan bakat seperti olah raga dan seni.

Ketika anak mengikuti kegiatan tersebut ada beberapa bahaya fisik yang harus dikenali anak, misalnya jatuh atau cidera ketika camping atau berkemah, dan mengikuti perlombaan kegiatan PRAMUKA, jatuh dari sepeda atau ketika menyeberang jalan.

Untuk itu pencegahan yang dapat dilakukan adalah

- a. Ajarkan anak untuk mengenali bahaya ketika mengikuti kegiatan camping, mencari jejak dan lomba pada kegiatan pramuka.
- b. Ajarkan anak untuk mengendarai sepeda dengan aman.
- c. Ajarkan anak untuk tidak menggunakan alat yang dapat meledak atau terbakar.
- d. Ingatkan anak untuk selalu patuh pada guru pembimbing di sekolah maupun pada aktifitas diluar sekolah seperti PRAMUKA.
- e. Ajarkan orang tua untuk memahami keterlibatan anak dalam kelompok teman sebaya di lingkungan rumah dan sekolah serta bantu untuk identifikasi kegiatan konstruktif yang dapat dipilih anak bersama temannya terutama untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kegiatan berkelompok diluar rumah (Hockenbery et al. 2024).
- f. Bagi anak yang berada di usia akhir masa sekolah, edukasi orang tua tentang keterampilan yang akan dicapai anak di masa remaja.

5. Masa Remaja

Tahapan usia remaja adalah masa kritis bagi anak, dikarenakan anak mulai mencari identitas dirinya dan terbentuk citra diri serta gambaran dirinya (body image), masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Karakteristik yang khas pada anak remaja yang penting dikenali adalah sebagai berikut:

- a. Kematangan organ dan fungsi tubuh termasuk organ reproduksi.
- b. Sangat berfokus pada dirinya sendiri.
- c. Pergaulan anak akan lebih luas dan bahkan bisa mengikuti banyak kegiatan diluar sekolah, Misalnya OSIS, PRAMUKA, Palang Merah Remaja (PMR) yang memungkinkan anak dapat secara aktif terlibat, dan hal ini melibatkan aktivitas fisik dan psikososial anak.

Potensi Bahaya Yang Harus Dikenali Pada Anak Remaja

Potensi bahaya pada anak remaja sesuai karakteristiknya berbeda dengan anak yang lebih muda, potensi bahaya fisik pada tingkatan cidera sedang atau berat karena kecelakaan kendaraan bermotor, atau potensi bahaya akibat pergaulan sosial anak dengan teman sebaya atau lingkungan kelompoknya bahkan dengan orang dewasa jika anak remaja bergaul bebas dengan orang dewasa tanpa pengawasan orang tua.

Anak remaja memiliki perilaku yang sering muncul tidak diduga, mereka menginginkan kebebasan bergerak dan bergaul dengan temannya, memiliki rasa yang sensitif terhadap perasaan dan perilaku yang diterima dari orang lain, dan sering mempertimbangkan pentingnya peran temannya secara ekstrim atau berlebihan serta memiliki rasa yang kuat untuk diperhatikan dan dicintai. Sehingga hal ini dapat menjadi sumber permasalahan yang timbul pada anak remaja (Hockenberry et al, 2024)

Berikut ini adalah potensi bahaya pada anak remaja

1. Cidera/ jatuh pada saat mengikuti berbagai kegiatan PRAMUKA, PMR dan kegiatan OSIS di sekolah atau pun luar sekolah. Kegiatan PRAMUKA atau PMR pada anak remaja sangat banyak tantangan dan beberapa kegiatan mengandung unsur kompetisi sehingga akan menstimulasi anak untuk secara aktif terlibat mengejar capaian prestasinya
2. Cedera fisik anak mengikuti kegiatan olah raga, sepak bola, sepak takraw, baseball dan olah raga sejenisnya yang menggunakan keterampilan berlari serta mengejar capaian waktu dengan harus menghadapi lawan yang memungkinkan anak terstimulasi untuk berlari dan bergerak cepat dan memiliki potensi besar untuk jatuh. Cedera fisik lainnya dapat terjadi karena anak terlibat perkelahian antar pelajar, diluar pengawasan guru pembimbing dan orang tua
3. Cedera akibat kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan patah tulang dan cedera kepala dapat terjadi jika anak mengendarai motor atau mobil tanpa memperhatikan aturan lalu lintas
4. Penggunaan NAPZA (Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), yang bisa terjadi pada anak akibat salah pergaulan dan terlepas dari pengawasan orang tua

Untuk itu, upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut

1. Memberi pemahaman kepada anak tentang petunjuk penggunaan kendaraan bermotor yang aman sesuai aturan yang ada, penggunaan alat pengaman penggunaan kendaraan seperti sabuk pengaman, helm yang terstandar dan pentingnya tetap berolahraga untuk melatih fisik anak agar tetap sehat dengan aktivitas yang tinggi.
2. Mengingatkan anak dan orang tuanya disaat mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti PRAMUKA, OSIS, PMR terutama kegiatan yang dilakukan di luar gedung, di pinggir pantai, mendaki gunung atau berada di wilayah tertentu yang tidak dikenal anak untuk mencapai tujuan keterampilan dari OSIS, PRAMUKA atau PMR. Selain kegiatan tersebut, anak mungkin masih mengikuti berbagai kegiatan tambahan untuk mencapai kematangan kepribadian atau memiliki keterampilan tertentu sebagai langkah persiapan untuk belajar pada sekolah di tingkat

perguruan tinggi. Misalnya anak mengikuti bimbingan belajar, les bahasa, les musik, atau mengikuti kelompok olah raga tertentu seperti bola, taekwondo, dan lain sebagainya. Hal yang harus difahami orang tua adalah anak dapat kelelahan dan bisa mengganggu kesehatannya.

3. Memberi pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya komunikasi yang harus tetap dijalin dengan anak remaja sehingga orang tua dapat mengawasi anak walaupun tidak secara langsung tetapi tetap mengetahui pergaulan remaja di sekolah atau[pun diluar sekolah dan mengingatkan untuk tetap mengawasi pergaulan diluar rumah/diluar sekolah sehingga tidak terjerumus pada kenakalan remaja.
4. Ingatkan orang tua untuk menempatkan diri sebagai teman bagi anak remaja sehingga dapat menjalin komunikasi terbuka dan lebih intens dengan anak, dengan demikian anak akan terbuka pada orang tua jika mengalami permasalahan apapun yang dihadapinya terutama yang menekan psikologis anak. Tugas dari sekolah terkadang menjadi stresor bagi anak sebagaimana juga pergaulan dengan teman sebayanya. Jika ada komunikasi baik dengan anka, maka orang tus dapat dengan mudah mengenali kondisi psikologis anaknya.
5. Arahkan anak remaja pada kegiatan yang lebih konstruktif selain kegiatan sekolah yang dijalankannya karena anak remaja memiliki energi lebih banyak yang mungkin jika tidak tersalurkan secara sehat akan mereka gunakan untuk kegiatan yang tidak sehat (tidak konstruktif), sehingga dapat mengganggu semangat belajar atau menghambat pencapain prestasi belajar anak.
6. Ingatkan orang tua untuk membina hubungan baik dengan guru BP di sekolah sehingga jika ada permasalahan yang dialami anak, maka orang tua akan dengan mudah meminta bantuan guru pembimbing atau bekerjasama dalam mencari jalan keluar dari masalah anak.
7. Ingatkan orang tua untuk meminta laporan prestasi belajar dari anak remaja selain mendapatkan informasi dari sekolah. Hal ini akan meningkatkan rasa tanggung jawab anak akan capaian prestasi sekolahnya dan perkembangan kemajuan belajar anak. Dengan demikian orang tua dapat menjadi pemberi informasi bagi sekolag dalam pemantauan kemajuan belajar anak.

Simpulan

Masa kanak-kanak merupakan masa dimana anak mengalami berbagai pengalaman belajar untuk tumbuh dan berkembang, dengan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Rasa ingin tau yang besar seringkali membuat anak sangat antusias dan tidak menyadari adanya bahaya yang dapat terjadi. Untuk itu orang tua punya kewajiban mengawasi dan membimbing anak melewati semua proses perkembangan dengan baik dan tetap dalam kondisi sehat serta terjaga keamanannya. Perawat berperan penting untuk menyiapkan orang tua agar memiliki kemampuan mendampingi anak selama proses perkembangan berjalan dan memberikan dukungan agar orang tua mampu menjaga anak dengan baik, aman dari segala bentuk kecelakaan yang dapat terjadi sesuai karakteristik perkembangan anak.

Referensi

- Black, B.P (2024). *Professional Nursing Concepts and Challenges*. St. Louis. Elsevier
- Doloksaribu, T.M (2023) *Paediatric Nursing*. Jogjakarta. Deepublish Publisher
- Kaakinen, J. R et al (2018). *Family Health Care Nursing*. Philadelphia. Davis Company
- Leifer, G. and Little, K.T. (2023). *Introduction to Maternity and Paediatric Nursing*. St. Louis. Elsevier
- Leifer and Fleck (2021). *Growth and Development. A Health Promotion Focus* 3rd. edition. St. Louis. Elsevier
- Marilyn J, Hockenberry. (2022). *Wong Essentials of Paediatric Nursing*. 7th edition. St. Louis. Elsevier
- Marilyn J, Hockenberry. (2024). *Wong's Clinical Manual of Paediatric*. 9th edition. St. Louis. Elsevier
- Marlow, D.R. and Redding, B.A (1988). *The Textbook of Paediatric Nursing*. Philadelphia, WB. Saunders Co.
- Nursalam, dkk. (2005) *Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak*, Jakarta , Salemba Medika
- Ricci, S.S. et al (2021) *Maternity and Paediatric Nursing*. 4th edition. Philadelphia. Wolters Kluwer
- Supartini, Y. (2003) *Konsep Dasar Keperawatan Anak*. Jakarta : EGC
- Susilaningrum, Rekawati, dkk, (2013). *Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak. Untuk Perawat dan Bidan*. Edisi 2. Jakarta: salemba Medika
- Taylor, C. Lynn, P., Barlett, J. L (2018). *Fundamental of Nursing. The Art and Science of Person.-Family Centre*. 9th edition. St. Louis. Elsevier

Glosarium

1. Anticipatory guidance: petunjuk antisipasi: bimbingan atau arahan yang diberikan kepada orang tua tentang perkembangan yang akan dialami anak dan potensi bahaya apa yang dapat dialami anak.
2. Pertumbuhan anak: anak bertambah berat dan tingginya.
3. Perkembangan anak; proses perubahan yang dialami anak dari lahir sampai dewasa, meliputi aspek fisik, intelektual, Bahasa, emosional dan sosial.
4. Keamanan anak (safety): keadaan bebas dari bahaya yang dapat melindungi anak dari ancaman kecelakaan.
5. Keselamatan anak: kondisi aman pada anak yang didapat melalui upaya perlindungan pada anak dari bahaya yang mengancam.

BAB 3

Manajemen Gizi Balita Dalam Keperawatan Keluarga

Rina Nur Hidayati, S.Kep.Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom.

Pendahuluan

Balita merupakan kelompok umur yang paling sering dan rentan gizi kurang (Irianti, 2018). Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) berfokus pada peningkatan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan finansial, dan pemerataan layanan kesehatan sehingga diharapkan status gizi masyarakat juga ikut meningkat. Sasaran utama RPJMN 2020–2024 adalah mengurangi prevalensi wasting dan stunting pada balita. Kelompok gizi kurang termasuk berat badan kurang, wasting, stunting, dan kekurangan mikronutrien (Kemenkes, 2020b).

UNICEF mengklaim bahwa ada 148,1 juta anak (22,3 5) dari balita di seluruh dunia mengalami stunting (UNICEF et al., 2023). Gizi berkontribusi lebih dari sepertiga dari semua kematian pada balita di dunia. Gizi kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh anak terhadap serangan penyakit dan membuat penyakit lebih parah. UNICEF melaporkan status gizi balita pada tahun 2022 sebanyak (22,3%) diantaranya mengalami stunting, 13,7 juta anak mengalami gizi kurang, dan 5,6 % anak mengalami overweight atau kegemukan. Pada tahun 2022, diperkirakan terdapat 45 juta balita (6,8 persen) terkena dampak gizi kurang, dimana 13,6 juta (2,1 persen) menderita gizi buruk. Lebih dari tiga perempat (75%) dari seluruh anak dengan gizi buruk tinggal di Asia dan 22% lainnya tinggal di Afrika (UNICEF et al., 2023).

Dibandingkan beberapa negara tetangga, prevalensi balita pendek di Indonesia (36%) tertinggi 4 dari beberapa negara seperti Myanmar (35%), Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand (16%), dan Singapura (4%) sesuai dengan populasi anak tiap negara yang berbeda (Apriluana & Fikawati, 2018). Pencapaian tersebut gagal mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu pembangunan berkelanjutan kedua yang akan mengakhiri semua jenis malnutrisi pada tahun 2030 (Susanto, Yunanto, Rasny & Nur, 2019).

Gizi kurang pada akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan balita hingga dewasa dan tidak dapat diperbaiki (Sir et al., 2021). Balita yang mengalami gizi kurang dalam jangka pendek akan berdampak pada perkembangan otak, kecerdasan, pertumbuhan fisik, dan metabolisme dalam tubuh. Akibat gangguan gizi dalam jangka panjang akan menurunkan kemampuan kognitif, penurunan prestasi belajar, penurunan kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, peningkatan risiko diabetes, kegemukan, kanker, stroke, penyakit jantung dan pembuluh darah lainnya (Kemenkes, 2021).

Penanganan stunting pada anak harus berfokus pada peran orang tua dalam pengetahuan gizi dan pertumbuhan perkembangan anak (Masrikhiyah, 2020; Putri & Rong, 2021; Vaughn et al., 2016). Kekurangan gizi dan pertumbuhan balita yang buruk disebabkan oleh pengetahuan ibu yang rendah (Irianti, 2018). Keluarga yang melakukan tugas kesehatan keluarga dengan baik memiliki 81,9% balita dengan status gizi baik (Hidayati, 2011). Studi menemukan bahwa penerapan perilaku keluarga yang sadar gizi mempengaruhi status gizi balita yang lebih baik (Azrimaidaliza et al., 2022).

Upaya penanganan stunting pada anak hendaknya difokuskan pada peran orang tua dan pengetahuan gizi (Masrikhiyah, 2020; Putri & Rong, 2021; Vaughn et al., 2016). Pengetahuan ibu yang rendah mengakibatkan balita rentan kekurangan gizi (Irianti, 2018). Asuhan keperawatan Keluarga menjadi solusi strategis dalam program kesehatan masyarakat yang berfokus pada peningkatan status gizi balita (Hidayati RN, Ibnu F, 2025). Peran keluarga sangat penting dalam meningkatkan dan mengawasi status gizi balita. Perawat komunitas dapat mengajarkan keluarga tentang pilihan makanan, aktivitas, dan gaya hidup yang sehat (Moore, 2009).

Manajemen gizi balita dalam konteks keperawatan keluarga adalah pendekatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anggota keluarga untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan balita. Dalam praktik keperawatan, perawat berperan penting dalam mengedukasi, memantau, dan memberikan intervensi yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan asupan gizi yang

tepat. Manajemen gizi dalam keperawatan keluarga membutuhkan sinergi pemberdayaan keluarga dan pendampingan perawat dalam pembinaan keluarga, sehingga diharapkan dapat mencegah dan mengatasi masalah gizi. Perawat memberikan pelatihan dan pendampingan pada keluarga dalam merawat balita dengan masalah gizi. Keluarga bisa belajar tentang cara menangani gizi kurang, seperti memilih makanan yang tepat untuk balita mereka, mengolah makanan dengan benar, membuat menu yang seimbang untuk balita, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (Hidayati RN, 2025).

Balita Sebagai Kelompok At Risk Masalah Gizi

Anak Balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Masa ini sangat penting dalam proses tumbuh kembangnya sehingga disebut *golden period* yang di mana proses pertumbuhan dan perkembangan anak sangat cepat baik secara fisik, psikologis, mental dan sosialnya. Balita sebagai fase perkembangan anak yang sangat tidak berdaya melawan suatu penyakit, salah satu masalah dari penyakit tersebut adalah akibat dari kekurangan/kelebihan asupan gizi (Kemenkes, 2014a).

Balita merupakan kelompok risiko (At Risk). Kelompok risiko adalah sekumpulan orang yang memiliki kecenderungan mengalami gangguan kesehatan dan dapat berkembang dikarenakan ada faktor penyebabnya (Allender, Rector, 2010). Faktor risiko akan meningkatkan kemungkinan perkembangan penyakit atau masalah kesehatan. Kelompok balita dikategorikan dalam risiko tinggi karena beberapa dalam beberapa faktor, yaitu risiko biologi, risiko sosial ekonomi dan risiko ketersediaan makanan (Hitchcock, Schubert, 2003). Sedangkan Stanhope menyatakan faktor risiko meliputi usia dan biologi, lingkungan dan gaya hidup (Stanhope, 2016).

Risiko biologi masalah gizi pada balita terkait dengan faktor usia. Faktor risiko yaitu usia, usia 0-5 tahun merupakan kelompok umur yang berisiko terhadap masalah nutrisi dikarenakan pemasukan yang tidak seimbang (Allender, Rector, 2010). Faktor biologi yaitu genetik merupakan salah satu penyebab terjadinya gizi lebih (Hitchcock, Schubert, 2003; Kaakinen & Melissa, 2018). Faktor genetik merupakan bekal dasar dan memiliki kedudukan pertama untuk memperoleh hasil akhir proses tumbuh kembang anak (Soetjiningsih, 2016). Masa balita membutuhkan nutrisi dari berbagai sumber dan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Balita belum mampu mengonsumsi atau mencerna makanan yang tersedia dan mereka cenderung mengalami malnutrisi karena kebutuhan akan zat gizi yang sangat tinggi (Hockenberry, Wilson, 2016).

Risiko sosial ekonomi: risiko tinggi kurangnya nutrisi dalam dihubungkan dengan risiko ekonomi yaitu faktor kemiskinan. Penduduk miskin mempunyai resiko lebih besar untuk timbul permasalahan kesehatan. Ketidakmampuan keluarga terhadap sumber daya finansial akan berdampak tidak terpenuhi kebutuhan pokok kehidupan harian keluarga, dengan demikian permasalahan kesehatan akan mudah timbul pada balita. Anak yang hidup dalam kemiskinan mengalami nutrisi kurang sampai dengan buruk (Allender, Rector, 2010; Hitchcock, Schubert, 2003).

Risiko ketersediaan makanan: nutrisi di masyarakat dipengaruhi oleh keamanan makanan dan peraturan pemerintah. Keamanan makanan mengarah kepada kebebasan penyakit, investasi dan kontaminasi. Badan pemerintah bertanggung jawab terhadap pengawasan setiap aspek dari produksi makanan, namun masih ditemukan *outbreak escherichia coli* dan infeksi *salmonella* pada saat tertentu. Balita dengan gangguan atau kurang berkembangnya sistem imun memudahkan untuk mengalami penyakit akibat bawaan makanan (*foodborne disease*). Keluhan yang dirasakan akibat kontaminasi makanan atau minuman (produk susu) antara lain sakit perut, diare, muntah-muntah dan kelemahan (Hitchcock, Schubert, 2003)

Faktor gaya hidup, dimana keluarga merupakan unit dasar dalam berperilaku meliputi nilai kesehatan, kebiasaan hidup dan persepsi. Perilaku hidup sehat sangat dipengaruhi oleh keluarga seperti konsumsi makan yang sehat. (Kaakinen & Melissa, 2018). Masalah gizi terus merebak menjadi beban ganda. Dalam suatu rumah tangga, misalnya tidak hanya terdapat masalah kekurangan gizi, tetapi sekaligus masalah kegemukan. Keduanya disebabkan oleh asupan makanan yang salah atau tidak seimbang. Kekurangan gizi akibat serba kurang sedangkan kelebihan gizi akibat makan serba lebih dari kebutuhan (Kemenkes, 2014b).

Masalah Dalam Pemenuhan Gizi Balita Di Keluarga

Hasil penelitian masalah gizi yang paling sering terjadi pada balita adalah gizi kurang (Hidayati RN, Ibnu F, 2025; Irianti, 2018). Penelitian pada keluarga dengan balita gizi kurang menunjukkan bahwa keluarga menganggap anaknya kurus karena faktor keturunan. Mayoritas ibu mengatakan bahwa anak-anak mereka sulit makan. Mereka makan 3-4 suap dan lebih suka jajan. Mereka juga jarang makan buah atau susu. Anak sering sakit batuk, diare. Kalau sakit, makannya jadi rewel dan makannya sedikit. Berat badannya jadi turun. Menurut keluarga, anak-anak menyukai jajan chiki, permen, es, dan coklat. Setelah anak berusia 1 tahun dan mulai sekolah (PAUD, TK), keluarga jarang membawa balita ke posyandu karena anak sekolah di pagi hari. Selain itu, keluarga merasa segan dan terkadang kesal bila diingatkan oleh kader maupun petugas kesehatan tentang berat badan anak yang cenderung turun,

sehingga menjadikan mereka enggan untuk ke posyandu. Hasil study tersebut, menunjukkan keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi balita dan keluarga belum mampu melakukan upaya penanganan gizi kurang pada balita (Hidayati RN, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan masalah gizi balita dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, hal ini berkaitan dengan kemampuan pemahaman pengetahuan. Pengetahuan gizi nantinya dapat mempengaruhi konsumsi pangan pada balita yang berdampak pada status gizi balita (Purwanti dkk, 2016). Penelitian menunjukkan bahwa orang tua dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang perawatan gizi pada anaknya (Ghaida Yasmin dkk, 2014; Suratri dkk, 2023).

Penyebab terjadinya stunting di negara berkembang sering kali berkaitan dengan ketidakstabilan ekonomi (Bahar, 2023). Faktor sosial ekonomi terutama pendapatan rumah tangga merupakan faktor yang paling berperan dalam mempengaruhi kejadian stunting pada balita. Keluarga berpendapatan di bawah upah minimum regional memiliki kemungkinan 6,625 kali lebih besar untuk memiliki anak terhambat pertumbuhannya dibandingkan dengan keluarga berpendapatan di atas upah minimum regional (Utami et al., 2019).

Masalah pemenuhan gizi balita di keluarga sering dipengaruhi oleh akses layanan kesehatan yang terbatas dan peran petugas kesehatan. Petugas kesehatan sering kali memiliki beban kerja yang tinggi, sehingga mereka tidak dapat memberikan perhatian yang cukup kepada setiap keluarga. Tindakan pencegahan dapat dilakukan oleh petugas kesehatan untuk mengatasi masalah gizi balita melalui edukasi kepada orang tua mengenai pemenuhan gizi yang baik.

Hasil penelitian Hastuti et al., (2024) menunjukkan terdapat perbedaan kemampuan ibu dalam memenuhi gizi setelah diberikan intervensi pemberdayaan keluarga pada keluarga dengan anak stunting usia 6-24 bulan yaitu penyiapan dan pengolahan makanan ($p = 0.000$), pemberian makanan pendamping ASI ($p = 0.000$), dan pemberian makanan responsif ($p = 0.000$). Penelitian Heryyanoor et al., (2022) mengungkapkan melalui pembinaan keluarga dengan model *Family Centered Nursing* berhasil meningkatkan pengetahuan dan sikap keluarga tentang pencegahan malnutrisi balita. Penelitian Januarti et al., (2020) menyebutkan pemberdayaan keluarga berdasarkan model *Family Centered Care* dapat meningkatkan pencegahan balita stunting.

Friedman, Bowden (2010) mengungkapkan peran perawat komunitas diperlukan dalam menanamkan nilai-nilai pada keluarga meliputi pemilihan makanan, aktifitas,

dan pilihan gaya hidup sehat sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya masalah gizi pada balita. Penanaman nilai-nilai pelaksanaan tersebut dilaksanakan melalui tugas kesehatan keluarga dalam asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan model *Family Centered Nursing* (FCN).

Manajemen Gizi Balita Dengan Pendekatan Keperawatan Keluarga

Manajemen gizi dalam konteks keperawatan keluarga adalah pendekatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anggota keluarga untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dalam praktik keperawatan, perawat berperan penting dalam mengedukasi, memantau, dan memberikan intervensi yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan asupan gizi yang tepat. Berikut adalah tahapan dari manajemen gizi balita dengan pendekatan keperawatan keluarga (Friedman, Bowden, 2010; IPKKI, 2017; Kemenkes, 2020a; Kemenkes RI, 2020):

1. Pengkajian

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan pengukuran antropometri (pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan) untuk menilai status gizi setiap anggota keluarga. Adapun pengumpulan data asuhan keperawatan keluarga dengan balita gizi kurang sebagai berikut:

a. Data umum

Data umum dikaji meliputi identitas keluarga dan identitas balita. Identitas keluarga dikaji nama kepala keluarga, usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi. Sedangkan identitas balita dikaji nama, usia, jenis kelamin, urutan anak, dan kondisi kesehatan.

Sosial ekonomi dikaji tentang pendapatan keluarga dan alokasi anggaran untuk makanan. Akses terhadap makanan bergizi, seperti protein hewani, sayur, dan buah. Keluarga dengan pendapatan rendah lebih rentan memiliki anak dengan gizi kurang karena keterbatasan akses makanan bergizi. Pengetahuan ibu tentang gizi sangat memengaruhi pola pemberian makan. Pendidikan yang rendah dapat menyebabkan praktik makan yang kurang tepat.

b. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga

Riwayat kesehatan dikaji untuk mengumpulkan informasi tentang riwayat kesehatan keluarga, termasuk penyakit kronis, alergi makanan dan kebiasaan makan. Status gizi ibu saat hamil: dikaji apakah ibu mengalami kekurangan energi kronis (KEK) atau anemia selama kehamilan dan apakah ada komplikasi kehamilan seperti riwayat preeklamsia, perdarahan, atau

kelahiran prematur.

Riwayat kesehatan balita dikaji penyakit yang pernah atau sedang dialami, imunisasi, riwayat rawat inap, atau konsultasi kesehatan sebelumnya. Riwayat tumbuh kembang dikaji berat badan lahir, panjang lahir, dan pencapaian tumbuh kembang sesuai usia. Riwayat pemberian ASI dan MPASI dikaji durasi ASI eksklusif, jenis makanan pendamping, pola pemberian makan, dan frekuensi. Asupan makanan dikaji untuk menganalisis pola makan dan kebiasaan konsumsi makanan keluarga untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan gizi.

Perkembangan keluarga merupakan proses perubahan yg terjadi pada sistem keluarga meliputi; perubahan pola interaksi & hubungan antar anggota keluarga disepanjang waktu. Perubahan ini berlangsung melalui beberapa tahapan atau kurun waktu tertentu. Pada setiap tahapan memiliki tugas perkembangan yg mesti dipenuhi supaya tahapan tersebut bisa dilalui dengan berhasil.

Mengacu pada tahap perkembangan keluarga menurut Duvall, keluarga dengan balita berada pada tahap keluarga dengan anak prasekolah. Pada tahap ini, fokus utama keluarga adalah memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak, termasuk membangun kebiasaan makan sehat dan pola asuh yang mendukung tumbuh kembang optimal.

Tugas perkembangan pada tahap ini meliputi:

1. Memberikan nutrisi yang adekuat dan seimbang untuk mendukung pertumbuhan fisik anak;
2. Mengajarkan kebiasaan hidup sehat, termasuk kebiasaan makan yang baik;
3. Mengatasi tantangan pengasuhan, seperti pemilihan makanan balita yang sesuai kebutuhan;
4. Menyeimbangkan kebutuhan individu orang tua dan anak;
5. Meningkatkan interaksi sosial anak dengan lingkungan, seperti tetangga atau kelompok sebaya.

Hambatan dalam tahap Perkembangan pada keluarga dengan balita gizi kurang, hambatan dapat meliputi:

1. Pengetahuan keluarga yang terbatas tentang pola makan sehat;
2. Masalah ekonomi yang menghambat akses pada makanan bergizi;
3. Pengasuhan yang kurang konsisten atau tidak sesuai;
4. Adanya stres keluarga akibat masalah kesehatan atau keuangan.

Adapun pengaruh tahap dan riwayat perkembangan pada balita gizi kurang yaitu

1. Riwayat keluarga dengan pola makan tidak seimbang atau rendah asupan nutrisi esensial berkontribusi pada kondisi gizi kurang;
2. Stres keluarga akibat kondisi ekonomi dapat memengaruhi pengasuhan balita;
3. Kurangnya pemahaman tentang tumbuh kembang anak dapat memperburuk kondisi balita dengan gizi kurang.

c. Lingkungan

Lingkungan dikaji kebersihan lingkungan tempat tinggal, sumber air bersih dan sanitasi, pola pengelolaan limbah rumah tangga, dukungan masyarakat. Adanya dukungan dari pasangan, keluarga besar, atau masyarakat dalam pengasuhan. Partisipasi keluarga dalam program kesehatan masyarakat, seperti Posyandu. Keluarga dengan akses terbatas ke Posyandu, Puskesmas, atau program kesehatan cenderung mengalami kesulitan memantau pertumbuhan dan perkembangan balita.

d. Struktur keluarga

Struktur keluarga balita dengan gizi kurang mencakup pola komunikasi, struktur kekuatan, struktur peran, serta nilai dan norma budaya yang memengaruhi kesejahteraan balita. Keluarga dengan struktur yang mendukung (misalnya, ayah yang terlibat dan lingkungan yang harmonis) cenderung lebih baik dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Sebaliknya, konflik dalam keluarga, peran ganda ibu, atau pengasuhan yang kurang optimal dapat memperburuk kondisi gizi balita. Struktur keluarga dengan keterbatasan ekonomi atau kurangnya pendidikan orang tua cenderung memiliki risiko tinggi anak gizi kurang. Nilai-nilai tradisional keluarga dalam pemberian makan, seperti keyakinan bahwa makanan tertentu tidak cocok untuk anak, dapat memengaruhi struktur dan pola makan balita.

e. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga memainkan peran sentral dalam pemulihan balita dengan gizi kurang. Keperawatan keluarga bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi afektif, sosialisasi, reproduksi, ekonomi, dan perawatan kesehatan agar keluarga dapat mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal. Fungsi perawatan kesehatan merupakan fungsi yang mendasar dan vital, dan menjadi fokus sentral dalam keluarga yang sehat dan berfungsi dengan baik. Keluarga berperan mengajarkan dan membantu balita makan makanan bervariasi dengan gizi seimbang, mengatur jadwal makan balita,

membatasi asupan gula, memotivasi balita dengan aktifitas-aktifitas yang melibatkan banyak gerakan, membantu hygiene gigi, dan mengontrol berat badan balita agar seimbang. Kesanggupan keluarga melaksanakan pemeliharaan kesehatan dapat dilihat dari tugas kesehatan keluarga (Friedman, Bowden, 2010).

Tugas kesehatan keluarga terkait gizi meliputi:

- 1) Mengetahui masalah: apa yang keluarga ketahui tentang gizi, triguna makanan dan manfaatnya, penyebab dan tanda-tanda masalah gizi.
- 2) Mengambil keputusan: menurut keluarga apa akibat masalah gizi bila tidak seimbang, apakah menurut keluarga sangat penting melakukan penanggulangan masalah gizi.
- 3) Kemampuan memberikan perawatan anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan: apa yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah gizi, bagaimana cara memilih, mengolah dan menyimpan makanan, apakah keluarga mengetahui alternatif perawatan anggota dengan masalah gizi, hambatan apa dalam penanggulangan masalah gizi di rumah.
- 4) Kemampuan memodifikasi lingkungan: bagaimana keluarga mengatur lingkungan (fisik, psikologis, sosial) yang dapat menunjang keberhasilan penanggulangan masalah gizi, apa yang keluarga ketahui alasan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan.
- 5) Kemampuan memanfaatkan fasilitas kesehatan: apa saja yang diperoleh di Polindes/Pustu/Puskesmas/Rumah Sakit, adakah hambatan yang dihadapi untuk memanfaatkan sarana/fasilitas kesehatan (Hidayati, 2011).

f. Stres, koping dan adaptasi keluarga

Keluarga dengan balita gizi kurang sering menghadapi tekanan emosional, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Dalam asuhan keperawatan, penting untuk memahami bagaimana keluarga merespons stres, strategi koping yang mereka gunakan, dan kemampuan adaptasi mereka terhadap kondisi tersebut. Dengan mendukung fungsi koping dan adaptasi keluarga secara optimal, asuhan keperawatan dapat membantu keluarga mengatasi stres dan mendukung pemulihan balita dengan gizi kurang.

g. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik adalah dasar penting untuk menilai kondisi fisik dan status gizi balita serta menentukan langkah intervensi yang sesuai. Hal ini juga membantu keluarga memahami kondisi anak dan mendorong mereka untuk

lebih aktif dalam perawatan. Pemeriksaan antropometri meliputi berat badan, tinggi badan atau panjang badan, lingkaran kepala dan lingkaran lengan atas (LILA). Indeks antropometri (BB/U, TB/U, dan BB/TB, IMT/U) untuk menilai status gizi. TTV dengan pengukuran suhu tubuh, nadi, pernapasan, dan tekanan darah untuk mendeteksi adanya infeksi atau dehidrasi.

Balita dengan gizi kurang menunjukkan tanda-tanda yang dapat dikenali secara fisik, perilaku, dan perkembangan. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara asupan gizi dan kebutuhan tubuh untuk tumbuh, berkembang, serta menjalankan fungsi metabolik. Tanda fisik diantaranya berat badan anak berada di bawah -2 Standar Deviasi (SD) pada grafik pertumbuhan WHO., tinggi badan tidak sesuai usia, dapat disertai stunting (TB/U < -2SD), atrofi otot, kulit bersisik atau berwarna gelap akibat hiperpigmentasi. Rambut tipis, mudah rontok, dan bisa berubah warna menjadi kemerahan atau pirang. Wajah terlihat lebih tirus karena hilangnya jaringan lemak subkutan, mata cekung, edema, perut buncit. Tanda perilaku yaitu lemas, lesu, rewel atau mudah menangis, anak menjadi lebih sensitif, anak cenderung menolak makanan atau hanya mau makan dalam jumlah sedikit. Tanda perkembangan diantaranya anak terlambat mencapai berjalan, berbicara, atau kemampuan motorik halus.

2. Diagnosis Keperawatan Keluarga

Defisit nutrisi pada keluarga Bpk A khususnya An. T berhubungan ketidakmampuan keluarga merawat balita dengan gizi kurang.

3. Perencanaan

Perencanaan keperawatan pada diagnosis keperawatan defisit nutrisi berfokus pada manajemen nutrisi dan promosi berat badan. Manajemen nutrisi adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk mengidentifikasi dan mengelola asupan nutrisi yang seimbang. Promosi berat badan adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk memfasilitasi peningkatan berat badan. Luaran ditujukan agar status nutrisi membaik. Status nutrisi membaik berarti keadekuatan asupan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme membaik.

4. Implementasi

a. Edukasi Gizi

- 1) Pendidikan kesehatan: memberikan informasi tentang pentingnya gizi seimbang, termasuk makronutrien (karbohidrat, protein, lemak) dan mikronutrien (vitamin dan mineral).
- 2) Pola makan sehat: mengajarkan keluarga tentang cara memilih makanan sehat, merencanakan menu, dan memasak dengan cara yang bergizi.

- 3) Kesadaran gizi: mendorong keluarga untuk lebih sadar akan label makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan.

b. Pembinaan Keluarga

- 1) Perencanaan diet: membantu keluarga merencanakan diet yang sesuai dengan kebutuhan gizi masing-masing anggota, termasuk anak-anak, remaja, orang dewasa, dan lansia.
- 2) Suplementasi: jika diperlukan, merekomendasikan penggunaan suplemen gizi untuk mengatasi kekurangan tertentu, seperti zat besi atau vitamin D.
- 3) Modifikasi Kebiasaan: membantu keluarga mengubah kebiasaan makan yang tidak sehat, seperti mengurangi konsumsi makanan olahan atau tinggi gula.

c. Pemberdayaan keluarga

- 1) Keterlibatan keluarga: mendorong anggota keluarga untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait gizi dan kesehatan mereka.
- 2) Pengembangan keterampilan: mengajarkan keterampilan memasak dan memilih makanan yang sehat untuk meningkatkan kemandirian keluarga dalam mengelola gizi.

d. Kolaborasi dengan Tim Kesehatan

- 1) Kerjasama multidisipliner: bekerja sama dengan ahli gizi, dokter, dan profesional kesehatan lainnya untuk memberikan pendekatan yang komprehensif dalam manajemen gizi.
- 2) Rujukan: jika diperlukan, merujuk anggota keluarga ke ahli gizi atau spesialis lain untuk penanganan lebih lanjut.

5. Evaluasi

Edukasi, perencanaan, pembinaan, supervisi dan dukungan yang berkelanjutan adalah kunci keberhasilan intervensi ini. Selain itu, sumber-sumber pendukung dalam keluarga merupakan faktor yang meningkatkan kemandirian dalam keluarga, sehingga perawat perlu memaksimalkan potensi positif dalam keluarga dengan memperhatikan kearifan lokal. Adapun evaluasi meliputi:

- a. Monitoring berkala: melakukan pemantauan berkala terhadap status gizi dan kesehatan anggota keluarga untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan.
- b. Evaluasi hasil: menggunakan data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi kemajuan dan membuat penyesuaian pada rencana intervensi jika diperlukan.

- c. Dukungan berkelanjutan: memberikan dukungan dan motivasi kepada keluarga untuk mempertahankan pola makan sehat dan gaya hidup aktif.

Keluarga memainkan peran penting dalam meningkatkan dan mengawasi status gizi balita. Penelitian Hidayati RN, Ibnu F, (2025) mengemukakan terdapat perbedaan status gizi balita setelah diberikan intervensi tugas kesehatan keluarga dengan pendekatan model *Family Centered Nursing* (FCN). Tugas kesehatan keluarga efektif meningkatkan status gizi balita ($P < 0.025$). Optimalisasi tugas kesehatan keluarga dengan pendekatan model FCN menjadi solusi strategis dalam program kesehatan masyarakat yang berfokus pada peningkatan status gizi balita.

Hidayati RN, (2025) mengemukakan ada pengaruh Gerakan PELITA “Peduli Gizi Balita” dalam meningkatkan kemampuan keluarga mengatasi gizi kurang balita ($P\text{-value } 0,001 < 0,05$). Pemberian edukasi kelompok dan pembinaan keluarga efektif meningkatkan kemampuan keluarga. Gerakan PELITA dapat menjadi solusi strategis dalam program kesehatan masyarakat yang berfokus pada peningkatan status gizi balita dengan mendukung pembiasaan makan sehat, mengoptimalkan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya terbatas keluarga dengan melalui pembimbingan dan pendampingan petugas kesehatan. Perawat kesehatan masyarakat dapat menggunakan pendekatan gerakan PELITA “Peduli Gizi Balita” untuk percepatan penanganan dan penurunan masalah gizi balita. Hal ini senada dengan Penelitian Anna et al., (2019) mengemukakan mendukung kebiasaan makan sehat dalam keluarga dan mengelola sumber daya terbatas digunakan sebagai alat dalam menurunkan malnutrisi di Vietnam. Tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan dengan balita stunting sangat diperlukan agar balita mendapatkan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi antara tenaga kesehatan dan keluarga (Nuraeni & Rosiah, 2023).

Simpulan

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) berfokus pada peningkatan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan finansial, dan pemerataan layanan kesehatan sehingga diharapkan status gizi masyarakat juga ikut meningkat. Sasaran utama RPJMN 2020–2024 adalah mengurangi gizi kurang yaitu prevalensi wasting dan stunting pada balita. Masalah gizi yang paling sering terjadi pada keluarga adalah gizi kurang pada balita, sehingga diperlukan upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah gizi kurang secara komprehensif dengan pendekatan dan pemberian intervensi yang tepat.

Penelitian pada keluarga dengan balita gizi kurang menunjukkan bahwa keluarga menganggap anaknya kurus karena faktor keturunan. Mayoritas ibu mengatakan bahwa anak-anak mereka sulit makan. Mereka makan 3-4 suap dan lebih suka jajan. Mereka juga jarang makan buah atau susu. Anak sering sakit batuk, diare. Kalau sakit, makannya jadi rewel dan makannya sedikit. Berat badannya jadi turun. Menurut keluarga, anak-anak menyukai jajan chiki, permen, es, dan coklat. Setelah anak berusia 1 tahun dan mulai sekolah (PAUD, TK), keluarga jarang membawa balita ke posyandu karena anak sekolah di pagi hari. Selain itu, keluarga merasa segan dan terkadang kesal bila diingatkan oleh kader maupun petugas kesehatan tentang berat badan anak yang cenderung turun, sehingga menjadikan mereka enggan untuk datang ke posyandu. Hasil study tersebut, menunjukkan keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi balita dan keluarga belum mampu melakukan upaya penanganan gizi kurang pada balita. Faktor pendidikan keluarga, pendapatan keluarga dan akses layanan dari petugas kesehatan juga berkontribusi pada masalah gizi kurang balita.

Manajemen gizi balita dalam konteks keperawatan keluarga adalah pendekatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anggota keluarga untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan balita dalam konteks keperawatan keluarga. Dalam praktik keperawatan, perawat berperan penting dalam mengedukasi, memantau, dan memberikan intervensi yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan asupan gizi yang tepat.

Mengatasi gizi kurang pada balita memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Pemberian asuhan keperawatan pada keluarga dengan balita gizi kurang perlu dilakukan secara kontinue melalui kunjungan rumah. Petugas kesehatan perlu dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang memadai untuk dapat memberikan intervensi yang efektif. Selain itu, penting untuk melibatkan keluarga dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi untuk kesehatan anak. Upaya kolaboratif antara berbagai sektor juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perbaikan status gizi balita. Edukasi, perencanaan, pembinaan, supervisi dan dukungan yang berkelanjutan adalah kunci keberhasilan intervensi ini. Selain itu, sumber-sumber pendukung dalam keluarga merupakan faktor yang meningkatkan kemandirian dalam keluarga, sehingga perawat perlu memaksimalkan potensi positif dalam keluarga dengan memperhatikan kearifan lokal.

Penelitian lebih lanjut kearah *action research* terkait dengan model intervensi yang dapat dipraktikkan pada keluarga dengan masalah gizi balita perlu dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan seperti pemberdayaan keluarga,

pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi peran perawat komunitas. Pengembangan model ini dapat digunakan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga sehingga diharapkan berdampak pada pemecahan masalah kelompok balita dengan risiko tinggi masalah gizi.

Referensi

- Allender, Rector, W. (2010). *Community health nursing: promoting and protecting the public health* (7th Editio). Lippincott Williams & Wilkins.
- Anna, H., Hedvig, F., & Kristina, R. (2019). Family-centered care - a tool to decrease malnutrition among children in Vietnam. *International Archives of Nursing and Health Care*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.23937/2469-5823/1510116>
- Apriluana, G., & Fikawati, S. (2018). Analisis faktor-faktor risiko terhadap kejadian stunting pada balita (0-59 bulan) di negara berkembang dan asia tenggara. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 28(4), 247–256.
- Azrimaidaliza, Syarif, L., & Resmiati. (2022). Hubungan antara Pendapatan, Penyakit Infeksi dan Pola Makan terhadap Kejadian Gizi Kurang pada Balita. *Amerta Nutrition*, 6(1SP), 259–265. <https://doi.org/10.20473/amnt.v6i1sp.2022.259-265>
- Friedman, Bowden, & J. (2010). *Family nursing: research, theory and practice*. (5 th ed). Prentice Hall.
- Hastuti, A. P., Suprawoto, D. N., Roesardhyati, R., Kurniawan, A. W., Soares, D., & Fani, R. (2024). Family empowerment to fullfillment nutrition in stunted children. *Babali Nursing Research*, 5(1), 54–66. <https://doi.org/10.37363/bnr.2024.51337>
- Heryyanoor, H., Hardiyanti, D., & Pertiwi, M. R. (2022). Improving family knowledge and attitudes on malnutrition through family centered nursing-based modules and videos. *DINAMISA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(2), 190–200.
- Hidayati, R. N. (2011). *Hubungan tugas kesehatan keluarga, karakteristik keluarga dan anak dengan status gizi balita di Puskesmas Pancoran Mas Kota Depok*. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20282242>
- Hidayati RN, Ibnu F, S. (2025). The Effect Of Family Health Tasks On The Nutritional Status Of Children Under Five Years Old With The Family Centered Nursing (FCN) Model Approach. *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta Yogyakarta*, 14(1).
- Hidayati RN, I. F. (2025). Gerakan PELITA di Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Wilayah UPT Puskesmas Gayaman Kab. Mojokerto. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUDIMAS)*, 3(1).
- Hitchcock, Schubert, T. (2003). *Community Health Nursing: Caring in Action*. Thomson/Delmar Learning, 2003.
- Hockenberry, Wilson, W. (2016). *Wong's essentials of pediatric nursing*. (10 th edit). Mosby Inc. St. Louis.

- IPKKI. (2017). *Panduan Asuhan Keperawatan Individu,. Keluarga, Kelompok, dan Komunitas dengan Modifikasi NANDA, ICNP,. NOC dan NIC di Puskesmas dan Masyarakat*. UI Press.
- Irianti, B. (2018). Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Status Gizi Kurang Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Sail Pekanbaru Tahun 2016. *Midwifery Journal: Jurnal Kebidanan UM. Mataram*, 3(2), 95. <https://doi.org/10.31764/mj.v3i2.478>
- Januarti, L. F., Abdillah, A., & Priyanto, A. (2020). Family empowerment model in stunting prevention based on family centered nursing. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9(2), 1797–1806. <https://doi.org/10.30994/sjik.v9i2.536>
- Kaakinen, J. R., & Melissa, R. (2018). Family Health Care Nursing Sixth Edition. In *F.A. Davis Company*.
- Kemendes. (2014a). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak*. Kemendes. <https://regulasi.bkpk.kemkes.go.id/detail/ffb9b802-9f1b-4d14-a945-2fa830ac0db0/unduh/>
- Kemendes. (2014b). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang*. Kemendes.
- Kemendes. (2020a). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak*. Kemendes RI. https://yankes.kemkes.go.id/unduhuan/fileunduhuan_1660187306_961415.pdf
- Kemendes. (2020b). *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024*. Kemendes.
- Kemendes. (2021). Profil Kesehatan Indonesia 2020. In Sekretariat Jenderal (Ed.), *Science as Culture*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kemendes RI. (2020). Buku Saku Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk Pada Balita di Layanan Rawat Jalan Bagi Tenaga Kesehatan. In *Kemendes RI: Jakarta*.
- Masrikhiyah, R. (2020). Peningkatan Pengetahuan Ibu Mengenai Gizi Seimbang Dalam Pemenuhan Gizi Keluarga. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 476–481. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i3.4378>
- Moore, M. C. (2009). *Pocket Guide To Nutritional Care* (Sixth edit). St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier.
- Nuraeni, A., & Rosiah, R. (2023). Tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan dan pencegahan stunting pada balita di Subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Dan Teknologi Rekayasa*, 5(1), 46–51. <https://doi.org/10.31962/jiitr.v5i1.149>
- Putri, A. P., & Rong, J. R. (2021). Parenting functioning in stunting management: A concept analysis. *Journal of Public Health Research*, 10(2), 213–219. <https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2160>
- Sir, S. G., Aritonang, E. Y., & Jumirah, J. (2021). Praktik Pemberian Makanan dan Praktik

- Kesehatan dengan Kejadian Balita dengan Gizi Kurang. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 3(1), 37–42. <https://doi.org/10.31539/joting.v3i1.2091>
- Soetjiningsih. (2016). *Tumbuh Kembang Anak*. EGC.
- Stanhope, L. (2016). *Public Health Nursing: Population Centered Health Care In The Community*.
- Susanto, Yunanto, Rasny, S., & Nur. (2019). Promoting children growth and development: a community-based cluster randomized controlled trial in rural areas of Indonesia. In *Jurnal Public Health Nursing* (Issue March).
- UNICEF, WHO, & World Bank. (2023). Level and trend in child malnutrition. *World Health Organization*.
- Vaughn, A. E., Ward, D. S., Fisher, J. O., Faith, M. S., Hughes, S. O., Kremers, S. P. J., Musher-Eizenman, D. R., O'Connor, T. M., Patrick, H., & Power, T. G. (2016). Fundamental constructs in food parenting practices: A content map to guide future research. *Nutrition Reviews*, 74(2), 98–117. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuv061>

Glosarium

Absorpsi : penyerapan
Afektif : berkenaan dengan perasaan, mempengaruhi keadaan perasaan dan emosi

B

Budaya : sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah

D

Diet : aturan makanan khusus untuk kesehatan dan sebagainya

E

Eksternal : menyangkut bagian luar (tubuh, diri, mobil, dan sebagainya)
Energi : daya (kekuatan) yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, tenaga

G

Gizi : zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan
Genetik : keadaan unggul suatu sifat keturunan yang tampak di dalam penampilan
Gaya hidup : pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat;

H

Hiperkoles-
terolemia : keadaan terlalu tingginya kandungan kolesterol di dalam darah
Hipertensi : Tekanan darah atau denyut jantung yang lebih tinggi daripada normal karena penyempitan pembuluh darah atau gangguan lainnya;

I

Internal : menyangkut bagian dalam (tubuh, diri, mobil, dan sebagainya)
Imunitas : keimunan; kekebalan;

K

Komplikasi	: penyakit yang baru timbul kemudian sebagai tambahan pada penyakit yang sudah ada
Karbohidrat	: senyawa organik karbon, hidrogen, dan oksigen, terdiri atas satu molekul gula sederhana atau lebih yang merupakan bahan makanan penting dan sumber tenaga (banyak terdapat dalam tumbuhan dan hewan)
Kecerdasan	: perihal cerdas
Klinis	: bersangkutan atau berdasarkan pengamatan klinik
Konsumtif	: bersifat konsumsi (hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri)
Keterampilan sosial	: kemampuan berinteraksi dengan orang lain
Kualitas	: derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya)
Kuantitas	: banyaknya (benda dan sebagainya); jumlah (sesuatu)
Krisis	: keadaan yang berbahaya (dalam menderita sakit)

L

Lemak	: zat minyak yang melekat pada daging
-------	---------------------------------------

M

Massa tubuh	: besar tubuh
Malnutrisi	: kekurangan gizi
Mineral	: zat organik yang dalam jumlah tertentu diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme normal yang diperoleh melalui makanan sehari-hari
Metabolisme	: pertukaran zat pada organisme yang meliputi proses fisika dan kimia, pembentukan dan penguraian zat di dalam badan yang memungkinkan berlangsungnya hidup

N

Nutrisi	: proses pemasukan dan pengolahan zat makanan oleh tubuh; makanan bergizi;
Nilai kesehatan	: variable yang membantu untuk mengukur status kesehatan

P

Pelayanan kesehatan	: sarana yang menyediakan bentuk pelayanan yang sifatnya lebih luas daripada bidang klinik, bersifat preventif, promotif, dan rehabilitatif
---------------------	---

Protein hewani	: protein yang dihasilkan dari hewan
Protein nabati	: protein yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan
Pendapatan	: perhitungan banyaknya uang yang akan diterima
Perawatan	: proses, cara, merawat, pemeliharaan
Peran	: perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat;
Prevalensi	: jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi; pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah
Pola makan	: cara mengatur jumlah porsi atau jenis makanan yang dikonsumsi tiap hari
Pola asuh	: cara mendidik, membimbing, mendisiplinkan anak dan memperlakukan anak.
Pertumbuhan	: hal (keadaan) tumbuh
Persepsi	: anggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu;
Penyakit kronis	: Penyakit yang telah berlangsung dalam waktu yang lama; menahun/ yang tidak sembuh-sembuh
Perilaku	: tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan;

S

Sosialisasi	: proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya
Sikap	: perilaku
Sosiokultural	: berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat
Status gizi	: keadaan nutrisi

V

Vitamin	: zat yang sangat penting bagi tubuh manusia dan hewan untuk pertumbuhan dan perkembangan
---------	---

BAB 4

Peran Keluarga dalam Meningkatkan Kebiasaan Hidup Sehat pada Anak

Helena Kidi Labot, SST., M.Kes.

Pendahuluan

Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak, semua tingkah laku yang muncul pada anak adalah hasil dari mencontoh perilaku dari orang tua. Orang tua adalah orang yang lebih tua atau dituakan yang terdiri dari ayah, ibu, kakek dan nenek, orang tua memiliki kewajiban mengasuh dan mendidik anak. Menurut Rizki & Hanik (2021: 19) mengartikan secara khusus orang tua adalah ayah dan ibu. Diperjelas oleh Ruli (2020: 144) orang tua adalah komponen keluarga terdiri dari ayah dan ibu yang merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah, orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam mengasuh, mendidik, membimbing dan membina anak-anaknya untuk mencapai tahap perkembangan agar anak siap untuk memasuki kehidupan bermasyarakat. Peran orang tua terhadap anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap, dan keterampilan. Menurut (Istiadaningsih et al., 2021: 26) peran orang tua adalah tugas atau kewajiban orang tua dalam menjalankan tugas mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya merupakan bentuk tanggung jawab dari orang tua. Jadi orang tua mempunyai peran menjalankan tugas dalam meningkatkan kesehatan anak.

Keluarga memegang peranan penting dalam perawatan dan merupakan elemen krusial. Sebagai unit terkecil keluarga berperan menjadi elemen dasar dalam masyarakat, menjadi titik awal dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Untuk mencapai tujuan bersama keluarga juga dianggap sebagai sistem sosial karena terdiri dari individu yang bergabung dan berinteraksi secara

teratur, saling ketergantungan dan berhubungan satu sama lain. Dalam konteks ini, struktur keluarga melibatkan individu seperti bapak, ibu, serta anak-anak, atau orang lain yang tinggal bersama dalam satu rumah.(Enisah, 2024)

Duvall dan Logan (1986) menunjukkan dalam Setyowati dan Murwani (2018) bahwa keluarga adalah sekumpulan orang yang memiliki hubungan perkawinan, kelahiran, dan adopsi, bertujuan untuk menciptakan, memelihara budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, emosional dan sosialnya dalam setiap anggota keluarga. Menurut Friedman (2003), dalam Nadirawati (2018) keluarga adalah dua orang atau lebih yang dipersatukan melalui kesatuan emosional dan keintiman serta memandang dirinya sebagai bagian dari keluarga. Whall (1986) mengemukakan dalam Nadirawati (2018) bahwa keluarga yaitu sekelompok dua orang atau lebih yang disatukan oleh persatuan dan ikatan emosional tidak hanya berdasarkan keturunan atau hukum, tetapi mungkin atau mungkin tidak. Dengan cara ini, mereka menganggap diri mereka sebagai keluarga dan mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari keluarga.

Keluarga sebagai fondasi utama kebiasaan hidup sehat. Keluarga adalah tempat pertama di mana anak-anak belajar tentang nilai-nilai dan kebiasaan. Dalam konteks hidup sehat, keluarga menjadi fondasi yang sangat penting untuk menanamkan nilai kebersihan, gizi seimbang, olahraga, serta pola tidur yang baik. Misalnya, kebiasaan makan bersama di meja makan tidak hanya memberikan kesempatan bagi orang tua untuk memastikan anak-anak mengonsumsi makanan bergizi, tetapi juga menciptakan momen interaksi yang memperkuat ikatan keluarga.

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Dalam proses berkembang anak memiliki ciri fisik, kognitif, konsep diri, pola koping dan perilaku sosial. Ciri fisik pada semua anak tidak mungkin pertumbuhan fisiknya sama, demikian pula pada perkembangan kognitif adakalanya cepat atau lambat. Perkembangan konsep diri sudah ada sejak bayi akan tetapi belum terbentuk sempurna dan akan mengalami perkembangan seiring bertambahnya usia anak. Pola koping juga sudah terbentuk sejak bayi di mana bayi akan menangis saat lapar. (Sri Melfa Damanik, Erita Sitorus, 2019)

Melindungi dan meningkatkan kesehatan anak merupakan hal yang sangat penting. Anak-anak perlu diberikan lingkungan yang stabil untuk berkembang, termasuk kesehatan dan gizi yang baik, perlindungan dari risiko ketiadaan akses ke pelayanan kesehatan, serta kesempatan untuk belajar dan tumbuh-berkembang. Pendidikan kesehatan pada anak perlu dilakukan sejak dini, dimulai dari rumah, agar anak terbiasa hidup sehat hingga dewasa.

Berkaitan dengan itu orang tua ditantang untuk berperan dalam kesehatan anak terutama dalam era digitalisasi ini. Menurut hasil penelitian (Berliana, 2016), analisis sebaran responden didasarkan pada analisis peran orang tua dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Dari 50 responden dengan peran orang tua rendah, 41 siswa (75,9%) memiliki gaya hidup bersih dan sehat diklasifikasikan sebagai rendah. Kemudian menurut hasil penelitian (Wulandari 2018), orang tua sebagian besar siswa di SD Margasana Kecamatan Karamatwatu tidak berperan dalam pengajaran PHBS (47,6%).

Peran Orang tua Terhadap Anak

1. Mengurus keperluan material anak-anak

Tugas ini merupakan tugas pertama dimana orang tua harus memberi makanan, tempat perlindungan dan pakaian kepada anak-anaknya. Anak-anak sepenuhnya tergantung kepada orang tuanya karena anak belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.

2. Menciptakan suasana "home" bagi anak-anaknya

"Home" di sini berarti bahwa di dalam keluarga anak-anak dapat berkembang dengan baik, merasakan kemesraan, kasih sayang, keramahtamahan merasa aman, terlindungi, dan lain-lain. Di rumahlah anak merasa tenteram, tidak kesepian dan selalu gembira.

3. Tugas Pendidikan

Tugas mendidik merupakan tugas terpenting dari orang tua terhadap anak-anaknya, karena orangtua lah yang memberikan pendidikan pertama kali pada anak.

(Yasin, 2008)

Tugas Keluarga dalam Pemeliharaan Kesehatan

Menurut (Fridman dalam JASMINE, 2014)) fungsi pelayanan kesehatan, keluarga mempunyai tanggung jawab yang harus dipahami dan dilaksanakan. Tanggung jawab keluarga harus dipenuhi dalam bidang kesehatan.

1. Mengenal masalah kesehatan masing-masing anggota keluarga;
2. Buat keputusan untuk mengambil tindakan yang tepat untuk keluarga;
3. Mudah untuk merawat anggota keluarga yang sakit atau tidak bisa mengurus dirinya sendiri karena cacat atau usia;
4. Mengubah lingkungan keluarga;
5. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

Kebiasaan Hidup Sehat Anak

1. Mandi untuk Menjaga Kebersihan Tubuh

Dengan mandi dan keramas maka tubuh dan rambut kita akan bersih dari kotoran, debu dan keringat, setelah kita beraktivitas. Mandi akan membuat peredaran darah di tubuh dan kepala menjadi lancar dan membuat kita semakin santai setelah beraktivitas. Biasakan mandi dan keramas dapat membuat tubuh menjadi rileks.

2. Menjaga Kebersihan dan Kesehatan Telinga

Telinga memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri. Adanya bulu-bulu halus serta bentuknya yang bersudut mampu menjaga telinga dari masuknya kotoran berlebih. Kelembaban berlebih pada telinga bisa menyebabkan bakteri masuk ke saluran telinga. Situasi ini secara tidak sadar dapat memicu infeksi dan iritasi pada telinga. Yang harus diajarkan pada anak yaitu:

a. Bersihkan Telinga dengan Benar

Saat membersihkan telinga, ada baiknya untuk membersihkan pada bagian luar atau daun telinga saja.

b. Hindari penggunaan cotton bud

Membersihkan telinga dengan cotton bud bisa membuat kotoran telinga terdorong ke bagian dalam telinga, sehingga membuatnya semakin masuk ke dalam dan mengendap.

c. Jaga Telinga Agar Tetap Kering.

Jagalah telinga agar kondisinya tetap kering.

d. Menutup telinga ketika mendengar suara yang keras.

e. Tidak memasukan apa pun ke dalam telinga.

3. Menjaga Kebersihan Hidung

Selain berfungsi sebagai alat pernafasan dan penciuman, hidung juga menjadi jalur pertahanan pertama dalam mencegah serta melawan bakteri dan racun di udara yang kita hirup. Jika hidung anak bermasalah, akan terjadi gangguan di saluran pernapasan yang dapat menimbulkan penyakit, menghambat fungsi indra penciuman, serta mengganggu aktivitas anak sehari-hari dan pada saat anak istirahat tidur. Yang harus diajarkan pada anak yaitu:

a. Menggunakan masker ketika berada di tempat yang berdebu atau berpolusi.

b. Tidak mengorek hidung.

c. Membersihkan hidung pada saat mandi.

d. Tidak memasukan apapun dalam hidung.

4. Menjaga Kebersihan Gigi dan Mulut

Di dalam mulut terdapat 2 golongan bakteri, yaitu bakteri jahat dan baik.

Bakteri baik bertugas menjaga keseimbangan jumlah bakteri jahat di dalam rongga mulut. Bakteri jahat sangat merugikan karena jika berinteraksi dengan makanan atau minuman yang manis maka bakteri tersebut dapat mengikis lapisan email gigi. Jika dibiarkan maka akan menyebabkan gigi berlubang. Yang harus diajarkan pada anak yaitu:

- a. Bawalah anak ke dokter gigi untuk pemeriksaan rutin setiap 6 bulan.
- b. Sikat gigi 2x sehari, pagi hari dan malam hari sebelum tidur.
- c. Biasakan anak untuk membersihkan lidah pada saat sikat gigi.
- d. Sikat gigi setelah makan makanan yang manis, seperti permen, coklat, dan es krim.

5. Menjaga Kebersihan Tangan dan Kuku

Kuman yang menempel di tangan dapat berpindah ke benda yang kita pegang atau sentuh; ke makanan yang dipegang atau langsung ke mulut ketika menyuap; ke mulut, ketika kita meletakkan tangan ke mulut; ke mata ketika kita menggosok-gosok mata; ke saluran pernapasan karena terhisap waktu kita memegang hidung atau mengupil; ke orang lain ketika kita bersentuhan atau bersalaman.

Untuk itu orang tua harus mengajarkan anak untuk:

- a. Cuci tangan harus menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir karena:
 - 1) Sabun dapat membersihkan kotoran dan kuman, tanpa sabun kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan;
 - 2) Air mengalir untuk membilas busa sabun beserta kotoran dan kuman yang ada di dalamnya; kuku yang kotor menyimpan banyak kuman penyakit dan telur cacing yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang dikonsumsi;
 - 3) Memotong kuku dapat mencegah menempelnya kuman dan telur cacing di sela-sela kuku.
- b. Ajari dan berikan contoh cara mencuci tangan yang benar
 - 1) Basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar
 - 2) Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian
 - 3) Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih
 - 4) Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci
 - 5) Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian

- 6) Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air jernih dan keringkan
 - c. Ajak anak untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang bersih dan mengalir, pada saat-saat penting
 - 1) Setelah buang air besar dan kencing
 - 2) Sebelum makan
 - 3) Setelah memegang hewan
 - 4) Setelah bermain
6. Menjaga Kebersihan Tubuh Setelah Buang Air Besar dan Buang Air Kecil
- Bagian kemaluan (genital) anak sangat rentan menjadi tempat kuman dan bakteri berkembang biak. Setelah BAB, ajari anak :
- a. Cebok menggunakan sabun dan air yang bersih dari arah depan ke belakang. Setelah BAK, ajari anak :
 - b. Laki-laki: Membersihkan ujung penis dan area di dalam kulit kulup secara lembut dengan air yang bersih tanpa menggunakan sabun, karena sisa air kencing yang menempel bisa menjadi sarang kuman.
 - c. Perempuan:
 - 1) Membersihkan bagian luar vagina dengan air bersih, karena bagian dalam vagina memiliki kemampuan untuk membersihkan sendiri.
 - 2) Mencuci dari bagian depan ke belakang adalah prinsip yang juga harus diajarkan. Cara ini untuk mencegah kuman dari dubur masuk ke dalam vagina.
7. Ajarkan anak untuk higiene pangan :
- a. Setiap hari, membawal botol berisi air minum yang aman dari rumah. Volume air minum yang dianjurkan adalah minimal sebanyak 300 ml.
 - b. Tidak boleh minum air langsung dari sumbernya (keran, sumur, air hujan).
8. Membentuk kebiasaan makan pada anak
- Anak kecil meniru apa pun yang dilakukan orang dewasa, termasuk pada waktu makan. Orang tua bisa menjadi contoh dengan memperlihatkan pilihan makanan, minuman, dan kudapan sehat serta rajin beraktivitas fisik yang menyenangkan. Sajian berupa makanan sehat dan segar adalah contoh terbaik bagi anak. Orang tua juga bisa melibatkan anak berbelanja dan menyiapkan makanan. Anak-anak biasanya senang diajak memasak makanan lezat dan sehat untuk keluarga. Gunakan waktu makan sebagai kesempatan belajar. Ajak anak untuk mengenal kelompok-kelompok makanan dan kandungan gizi dan vitamin yang dibutuhkan tubuh.

9. Menjaga hubungan yang sehat dengan makanan

Pola pikir yang sehat terkait makanan sangat penting bagi kesehatan seseorang di sepanjang hidupnya. Bantu anak membangun pola pikir ini dengan:

- a. Membantu mereka mengenal rasa lapar secara fisik. Dengan begitu, anak menjadi tahu kebutuhan tubuhnya.
- b. Menghindari menggunakan makanan sebagai hadiah atau hukuman. Cara ini justru membuat anak memiliki hubungan yang tidak sehat dengan makanan.
- c. Menghindari melarang makanan tertentu, seperti permen. Hal ini bisa membuat anak justru makin menginginkan makanan itu.

10. Jangan paksa anak menghabiskan makanan

Bagi orang tua, menghabiskan makanan mungkin sama dengan meningkatkan asupan gizi anak. Akan tetapi, memaksa anak untuk selalu menghabiskan makanannya bisa membuat mereka tidak menyukai makanan itu atau memiliki asosiasi negatif dengan waktu makan. Jika anak menolak makan sayur, contohkan bahwa anak suka dan menikmati sayur. Anak mempelajari pilihan makanan dari orang tuanya, jadi berikan contoh dan tularkan kebiasaan baik sebanyak mungkin. Mulailah dengan menawarkan buah atau sayur sedikit demi sedikit, kombinasikan dengan makanan sehat lainnya, atau meminta anak yang memilih agar makanan bisa dicicipi bersama-sama. Agar makanan tampak menarik, tata buah dan sayur dengan mengombinasikan bentuk dan warna. Ingat, anak mungkin perlu beberapa kali dibujuk hingga mau mencoba dan menyukai makanan baru.

11. Utamakan mengatur porsi

Porsi yang terlalu besar bisa menyebabkan kenaikan berat badan, jadi sangat penting anak-anak tahu porsi makan yang ideal. Cara termudah untuk mengajarkan mereka adalah dengan menggunakan petunjuk visual seperti satu kepal tangan untuk porsi nasi, pasta, atau sereal; ukuran telapak tangan mereka untuk porsi daging; dan lemak seperti mentega hanya sebesar ujung ibu jari mereka.

12. Mengawali hari dengan sarapan sehat

Pagi hari adalah waktu yang sibuk untuk banyak keluarga. Namun, sarapan seimbang akan memberikan asupan penting, seperti kalsium dan serat, yang dibutuhkan anak untuk tumbuh kembangnya. Daripada sarapan dengan sereal atau roti-rotian yang cenderung tinggi kalori namun rendah nilai gizi, lebih baik menyajikan menu sarapan khas Indonesia, seperti nasi uduk dan gado-

gado yang merupakan makanan padat gizi, atau, sajikan buah. Dengan makanan sehat, anak akan merasa lebih kenyang untuk waktu yang lebih panjang.

13. Buat kegiatan yang menyenangkan

Anak-anak perlu melakukan aktivitas fisik selama minimal 60 menit per hari. Kenapa tidak dijadikan aktivitas keluarga? Aktivitas yang bisa dilakukan semua anggota keluarga, misalnya, berjalan kaki setelah makan malam atau berenang. Anda juga bisa lakukan kegiatan spontan, misalnya menari saat mendengar lagu kesukaan di radio. Selain itu, penggunaan gawai, yang membuat anak sedikit bergerak, perlu dibatasi waktunya (rekomendasi WHO adalah tidak lebih dari satu jam per hari untuk anak usia 2-4 tahun). Anak perlu diarahkan agar lebih banyak melakukan kegiatan yang menuntut gerakan.

Peran Orang Tua Terhadap Kebiasaan Sehat pada Anak

Struktur Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari posisi tertentu. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai daerah domestik keluarga, dan anak memiliki perannya masing-masing dan berharap dapat saling memahami dan mendukung. Selain peran utama terdapat peran informal, peran tersebut dilakukan dalam kondisi tertentu atau sudah menjadi kesepakatan antar anggota keluarga. Misalnya, jika suami mengizinkan istrinya bekerja di luar rumah, maka istri akan berperan informal. Begitu pula suami akan melakukan tugas informal tanpa sungkan dengan membantu istrinya mengurus rumah.

Menurut Augustin (2015: 52), keluarga memiliki peranan penting dalam semua norma dan etika yang berlaku pada masyarakat dalam mengasuh anak, dan budaya ini dapat diwariskan dari orang tua kepada keturunan yang menyesuaikan dan mengembangkan masyarakat. Keluarga memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu ditanamkan pendidikan moral keluarga pada setiap orang sejak dini. Namun, selain tingkat pendidikan, moral pribadi juga menjadi standar untuk mengukur sukses tidaknya pembangunan.

Menurut Widiyaningsih dalam Rompas (2018: 2), peran orang tua bagi anak adalah selalu mengingatkan mereka akan kebiasaan hidup bersih dan sehat, dan orang tua harus memiliki kemampuan menjadi panutan atau panutan yang baik. Cara terbaik untuk mengajari anak dalam menerapkan hidup sehat adalah dengan memberikan contoh atau panutan kepada mereka. Tidak mudah bagi orangtua untuk menyuruh anak menerapkan pola hidup sehat tanpa memberikan contoh konkrit kepada mereka. Memulai pola hidup sehat harus dimulai dari orangtua. Tanpa disuruh pun jika Anda sudah memberikan contoh nyata, mereka akan mengikuti apa yang Anda

lakukan. Selain berperan sebagai panutan, orang tua juga harus mengawasi dan memastikan agar anaknya dapat menggunakan PHBS dengan benar. Hal ini karena semakin baik orang tua memperlakukan anaknya maka kehidupan anaknya akan semakin bersih dan sehat.

Cara Memberi Pola Hidup Sehat pada Anak

1. Memberi Contoh

Cara terbaik untuk mengajari anak dalam menerapkan hidup sehat adalah dengan memberikan contoh kepada mereka. Tidak mudah bagi orangtua untuk menyuruh anak menerapkan pola hidup sehat tanpa memberikan contoh konkrit kepada mereka. Memulai pola hidup sehat harus dimulai dari orangtua.

2. Menyiapkan Makan Bersama

Menyiapkan makan bersama juga menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan orangtua untuk menerapkan pola hidup sehat. Konkritnya, coba libatkan anak-anak – laki-laki dan perempuan semua bergerak – untuk memasak makanan sehat di dapur. Dengan begitu, bisa mengarahkan anak untuk memilih bahan makanan yang bersih dan sehat. Selain membiarkan anak-anak memilih sendiri makanan yang akan dimakan, orang tua juga bisa menjelaskan secara perlahan tentang kandungan gizi yang terkandung dalam makanan yang hendak dikonsumsi. Tidak hanya kandungan gizi, Anda juga perlu memberitahu kepada anak-anak tentang bahaya suatu makanan. Misalnya, makanan yang banyak mengandung gula tidak baik jika terlalu sering dikonsumsi karena bisa memicu penyakit diabetes, dsb.

3. Sarapan Bersama

Menerapkan pola hidup sehat juga bisa dilakukan dengan cara mengajak anak untuk menikmati sarapan bersama. Sarapan bersama bisa menjadi media untuk saling berbagi dan bercerita tentang makanan yang sedang dikonsumsi. Sarapan bersama tidak hanya untuk mencegah lapar. Lebih dari itu, bisa mengurangi stress karena seluruh anggota keluarga berkumpul dalam satu meja.

4. Santai Di Meja Makan

Meja makan merupakan tempat paling cocok untuk santai bersama keluarga. Sambil menikmati hidangan favorit. Sebagai orangtua bisa bercerita tentang pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Salah satunya dengan mengonsumsi makan makanan yang sehat dan bergizi. Kehangatan bersama keluarga akan terus terjaga dengan makan bersama. Hal itu secara tidak langsung Anda telah mengajarkan kepada mereka tentang hidup sehat.

5. Hindari Makanan Tidak Sehat

Mengajak anak-anak makan bersama di dalam satu meja juga dapat menghindarkan mereka dari makan makanan yang tidak sehat dan higienis. Meja makan juga bisa menjadi tempat untuk menjaga anak-anak dari kebiasaan hidup tidak sehat. Anda secara tidak langsung akan menjadi anak-anak lebih suka makan di rumah ketimbang beli makanan di luar yang belum terjamin kebersihannya. Kesehatan anak harus menjadi prioritas, sehingga menghindarkan anak dari makanan tidak sehat menjadi suatu keniscayaan.

6. Pola Makan Yang Baik

Berada satu meja makan merupakan saat yang paling tepat untuk mengatur pola makan agar anak-anak tetap terjaga kesehatannya. Anak harus diajarkan bagaimana hidup sehat dengan menerapkan pola makan yang baik dan seimbang. Mengonsumsi makanan yang baik sangat penting bagi tumbuh kembangnya seorang anak. Pola hidup sehat melalui makanan sehat tidak hanya menjaga pertumbuhan anak namun dapat juga mencegah suatu penyakit.

Ada banyak manfaat dari penerapan pola makan yang baik, diantaranya dapat menjaga berat badan. Hal ini sekaligus untuk menghindari anak mengalami obesitas. Dan, dalam jangka panjang, imunitas anak pun akan semakin baik.

7. Konsumsi Air Putih Yang Cukup

Sebagai orangtua, Anda harus memberikan pemahaman kepada anak tentang pentingnya mengonsumsi air putih yang cukup bagi tubuh. Setiap tubuh membutuhkan cairan yang cukup dan itu hanya bisa dipenuhi dengan minum air putih secukupnya. Anak yang kekurangan air putih akan mengalami dehidrasi, yang bisa mempengaruhi fungsi organ tubuh serta mengurangi kemampuan untuk berkonsentrasi. Yang paling penting dari kecukupan cairan dalam tubuh akan menjadikan anak mudah menerima pelajaran di sekolah karena bisa berkonsentrasi dengan baik.

8. Jaga Anak Tetap Aktif

Setelah selesai menikmati hidangan makan bersama di meja makan keluarga. Kini saatnya anda perlu mengajak anak-anak untuk menjaga tubuh tetap aktif. Ini adalah cara efektif untuk menerapkan pola hidup sehat. Beberapa kegiatan yang cocok untuk menjaga anak tetap aktif seperti bernyanyi, menari, berlari, hingga kegiatan melompat-lompat. Dengan melakukan kegiatan tersebut, membuat anak terbiasa untuk melakukan kegiatan yang bersifat latihan fisik dan mental sekaligus. Bahkan, untuk anak usia dini disarankan bisa melakukan kegiatan fisik minimal selama 2 jam dalam sehari.

9. Lakukan Olahraga Secara Teratur

Menjaga anak tetap aktif juga bisa dilakukan dengan beraktivitas olahraga secara teratur. Ada banyak jenis olahraga yang cocok untuk anak. Jadi olahraga tidak selalu diartikan sebagai kegiatan yang memerlukan tenaga berat. Ajak anak-anak untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan berolahraga yang menyenangkan. Sebut saja ada bersepeda, berenang, hingga jogging. Sisi positifnya mengajak anak berolahraga sejak kecil, anak akan terbiasa untuk hidup sehat sejak dini. Dia akan selalu menerapkan pola hidup sehat sehingga tidak mudah terserang suatu penyakit.

10. Istirahat Yang Cukup

Ini menjadi bagian paling sulit bagi orangtua untuk mengajak anak memulai hidup sehat. Mengajak anak untuk istirahat, misalnya tidur siang, itu tidak mudah. Apalagi, mengajak anak yang super aktif dan ingin selalu bermain-main. Untuk saat ini, tantangan paling berat bagi orangtua adalah penggunaan *handphone* dan peralatan gadget lainnya. Yang harus dilakukan orangtua adalah membatasi penggunaan *handphone* dan *gadget*. Sebagai orangtua, perlu mengatur waktu kapan waktunya bermain dan kapan waktunya tidur siang. Dengan jadwal itu anak akan terlatih menerapkan pola hidup sehat.

11. Lingkungan Sehat

Menerapkan pola hidup sehat juga bisa dimulai dari lingkungan yang sehat. Anak harus diajari untuk mulai hidup sehat dengan mengajak dia selalu membersihkan tempat bermain. Mengingat kesukaan anak yang suka bermain, jaga tempat di sekitar rumah selalu dalam keadaan bersih.

12. Minum Multivitamin

Beri vitamin pada anak sesuai kebutuhan untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Namun, dengan meminum vitamin, misalnya, nafsu makan anak umumnya akan bertambah.

13. Tips Hidup Sehat

- a. Anda harus peduli terhadap kondisi kesehatan anak sejak kecil. Ini memang tidak mudah namun Anda harus melakukannya demi pertumbuhannya.
- b. Sebaiknya Anda tidak terlalu memaksa anak untuk memakan habis seluruh isi di dalam piring ketika perut dia sudah kenyang.
- c. Anda harus mengajak anak melakukan aktivitas olahraga yang menyenangkan, seperti bermain bola, dsb.
- d. Sebaiknya sejak dini Anda tidak membiasakan anak makan sambil menonton televisi.
- e. Menjadi orangtua, Anda harus tegas, termasuk membatasi penggunaan peralatan elektronik, seperti *handphone*, *gadget*, dsb.

- f. Untuk menghindari anak bosan makanan, cobalah buat variasi makanan, seperti makan sayur dan buah. Ini cara hidup sehat yang bisa Anda lakukan bersama anak.
- g. Agar anak bisa tidur pulas, sebaiknya Anda mengamankan segala peralatan *gadget* di malam hari. Jangan biarkan tidur anak terganggu oleh HP.
- h. Anda harus bisa memilih makanan ringan yang sehat untuk anak Anda, misalnya dengan memperhitungkan jumlah kalori dalam makanan.
- i. Jangan terlalu sering memberi hadiah permen, karena hal itu bisa merusak kesehatan gigi anak Anda.
- j. Meski masih anak-anak, sebaiknya Anda melibatkan mereka dalam setiap kegiatan keluarga, misalnya dengan cara masak bersama di dapur.
- k. Sebaiknya Anda tidak melarang anak memakan makanan “junk food”. Yang bisa Anda lakukan adalah mengawasi dan membatasinya sehingga makanan itu tidak sampai mengganggu kesehatannya.
- l. Anda harus memberi contoh yang baik. Sebagai orangtua, Anda harus menjadi teladan tentang pentingnya menerapkan pola hidup sehat.

Simpulan

Ciri khas anak adalah menirukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya ataupun lingkungan disekitarnya. Untuk itu dalam hal kesehatan orang tua berperan untuk membentuk kebiasaan hidup sehat sejak usia dini. Karena kesehatan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Referensi

- Alkalah, C. (2016). *Kesehatan Dan Gizi Untu Anak* (Vol. 19).
- Cahyanti, A. (2020). Peran Keluarga dalam Membentuk Kesehatan Mental Remaja di Kelurahan Yosorejo 21 A Metro Timur. IAIN Metro.
- Carbines, M., Dickinson, A., & McKenzie-Green, B. (2017). The parenting journey: Daily parental management in families with young children. *Comprehensive Child and Adolescent Nursing*, 40(4), 223–239.
- Damanik, S. M., & Sitorus, E. (2020). *Buku Materi Pembelajaran Praktikum Keperawatan Anak*. Retrieved from <http://repository.uki.ac.id/2733/1/BukuMateriPembelajaranPraktikumKeperawatanAnak.pdf>
- Dianti, Y. (2017). *Konsep Ilmu Kesehatan Anak. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Retrieved from [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%20.pdf)

- Faidzin, S. (2022). PERAN DAN FUNGSI KELUARGA DALAM MEMBANGUN KEPRIBADIAN REMAJA YANG BAIK DAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN LITERATUR: THE ROLE AND FUNCTIONS OF THE FAMILY IN BUILDING GOOD AND SUSTAINABLE PERSONALITY OF YOUTH IN INDONESIA: A LITERATURE REVIEW. *Journal of Sustainable Development Issues*, 1(1), 1–13.
- Frosch, C. A., Schoppe-Sullivan, S. J., & O'Banion, D. D. (2021). Parenting and child development: A relational health perspective. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 15(1), 45–59.
- Hartati, S., & Wahyuni, S. (2023). *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*.
- Himawati, L., Sahara, R., & Kumalasari, N. (2016). Hubungan Antara Pola Asuh Ibu Dengan Keberhasilan Toilet Training Pada Anak Usia Toddler (1-3 Tahun) Di Posyandu Desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan. *The Shine Cahaya Dunia Kebidanan*, 1(2).
- Hyoscyamina, D. E. (2011). Peran keluarga dalam membangun karakter anak. *Jurnal Psikologi*, 10(2), 144–152.
- Iskandar, H., & Hasbi, M. (2020). Buku Saku Program PHBS Di Layanan PAUD, 54. Retrieved from <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/18983>
- JASMINE, K. (2014). *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Kemenkes RI. (2011). *Penuntun Hidup Sehat Edisi Keempat*, 106.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (021).
- Kone, J., Bartels, I.-M., Valkenburg-van Roon, A. A., & Visscher, T. L. S. (2022). Parents' perception of health promotion: What do parents think of a healthy lifestyle in parenting and the impact of the school environment? A qualitative research in the Netherlands. *Journal of Pediatric Nursing*, 62, e148–e155.
- Kurniati, I. D., Setiawan, R., Rohmani, A., Lahdji, A., Tajally, A., Ratnaningrum, K., ... Wahab, Z. (2015). *Buku Ajar*.
- Munifa, M., Ramadhani, J., & Yusup, A. (2022). Peran Keluarga Terhadap Pemenuhan Gizi Anak Usia Sekolah. In *Jurnal Forum Kesehatan: Media Publikasi Kesehatan Ilmiah* (Vol. 12, pp. 26–32).
- Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*. (2016). Prenada Media. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=4VDODwAAQBAJ>

- Rahayu, F. (2024). Peran Keluarga dan Sekolah dalam Membangun Kesehatan Mental Anak. *Jurnal Sublimapsi*, 5(1), 165. <https://doi.org/10.36709/sublimapsi.v5i1.46507>
- Ramadhani, T. A., & Muniroh, L. (2023). Hubungan Perilaku Makan dan Status Gizi Anak Usia Prasekolah. *Media Gizi Kesmas*, 12(2), 753–757. <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i2.2023.753-757>
- Rexmawati, S., & Santi, A. U. P. (2021). Pengaruh Peran Keluarga Terhadap Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Anak Sekolah Dasar Usia 10 Sampai 12 Tahun Di Kampung Baru Pondok Cabe Udik. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 5(2), 1–12. Retrieved from <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit>
- Siti Nurislamiah. (2024). Pengaruh Psikologi Agama Dan Kesehatan Mental Dalam Kesejahteraan Keluarga. *Journal of Islamic Education Studies*, 2(2), 114–121. <https://doi.org/10.58569/jies.v2i2.751>
- Subianto, J. (2013). Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 8(2), 331–354. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v8i2.757>
- Sutriyawan, A., DIAN KURNIAWATI, R., Rahayu, S. R. I., & Habibi, J. (2020). Hubungan status imunisasi dan riwayat penyakit infeksi dengan kejadian stunting pada balita: studi retrospektif.
- Syofyanengsih, S., Fajar, N. A., & Novrikasari, N. (2022). Hubungan Peran Keluarga terhadap Kejadian Stunting: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1167–1171.
- Tim Adaptasi Indonesia. (2009). Pelayanan Kesehatan Anak Di Rumah Sakit.
- Yahya, S. (2021). BAB I, (December).
- Yulianti, Y., Fadila, N., Nisa, C., Cahyani, I. M., putri Zaliani, S. C., Riyani, D. O., & Sari, D. P. (2024). PERAN LINGKUNGAN KELUARGA DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN MENTAL REMAJA. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 10(1), 144–152.

BAB 5

Asuhan Keperawatan Keluarga: Peran Orangtua Dalam Pemberian Asupan Gizi Pada Anak Di Usia Bayi Dan Balita Dengan Pendekatan Ethno- Agronursing

Hanny Rasni, S.Kp.,M.Kep.

Pendahuluan

Pada tahun 2020, situasi gizi anak-anak di dunia anak-anak ditandai dengan penurunan yang signifikan dalam jumlah anak yang mengalami kekurangan gizi, menunjukkan bahwa perubahan positif untuk gizi anak sedang terjadi dalam skala besar. Namun, penurunan ini masih masih belum cukup untuk mencapai target global untuk mengatasi tiga beban malnutrisi pada anak: kekurangan gizi, baik stunting maupun wasting; kekurangan zat gizi mikro; dan kelebihan berat badan dan obesitas (White et al., n.d.)

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan salah satu program yang sedang dijalankan pemerintah secara nasional. Salah satu sasarannya adalah kecukupan gizi yang dikonsumsi oleh masyarakat termasuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Anak usia di bawah lima tahun (balita) merupakan anak yang membutuhkan kecukupan gizi sebagai bekal untuk tumbuh dan berkembang optimal menuju masa depan yang sehat.

Permasalahan gizi pada anak menjadi program prioritas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK). Kekurangan gizi pada masa balita dapat menyebabkan permasalahan kesehatan yang kompleks, termasuk menyebabkan

penurunan kekebalan sehingga meningkatkan risiko mengalami penyakit infeksi (Rasni et al., 2019).

Pada umumnya keluarga telah memiliki pengetahuan dasar mengenai gizi. Namun demikian, sikap dan keterampilan serta kemauan untuk bertindak memperbaiki gizi keluarga masih rendah. Sebagian keluarga menganggap asupan makanannya selama ini cukup memadai karena tidak ada dampak buruk yang mereka rasakan. Sebagian keluarga juga mengetahui bahwa ada jenis makanan yang lebih berkualitas, namun mereka tidak ada kemauan dan tidak mempunyai keterampilan untuk penyiapannya. Gambaran perilaku gizi yang belum baik juga ditunjukkan dengan masih rendahnya pemanfaatan fasilitas pelayanan oleh masyarakat. Saat ini baru sekitar 50% anak balita yang dibawa ke Posyandu untuk ditimbang sebagai upaya deteksi dini gangguan pertumbuhan. Bayi dan balita yang telah mendapat Kapsul Vitamin A baru mencapai 74% dan ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) baru mencapai 60%. Sementara itu perilaku gizi lain yang belum baik adalah masih rendahnya ibu yang menyusui bayi 0-6 bulan secara eksklusif yang baru mencapai 39%, sekitar 28% rumah tangga belum menggunakan garam beryodium yang memenuhi syarat dan pola makan yang belum beraneka ragam. Masalah lain yang menghambat penerapan perilaku KADARZI adalah adanya kepercayaan, adat kebiasaan dan mitos negatif pada keluarga. Sebagai contoh masih banyak keluarga yang mempunyai anggapan negatif dan pantangan terhadap beberapa jenis makanan yang justru sangat bermanfaat bagi asupan gizi (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas, n.d.).

Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung. Keluarga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan identitas individu, status kesehatan dan perasaan harga diri individu. Sistem pendukung yang vital bagi individu adalah keluarga, dimana keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarga dengan menjalankan fungsi biologi, fungsi pendidikan, fungsi psikis, fungsi sosiokultural, serta fungsi kesehatan.

Aktivitas-aktivitas keluarga dalam menjalankan fungsi kesehatan dan keseimbangan antara anggota keluarga tidak terlepas dari lima tugas dalam perawatan kesehatan keluarga yaitu; mampu mengenal masalah kesehatannya, mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi kesehatannya, mampu melakukan tindakan keperawatan untuk anggota keluarga yang memerlukan bantuan keperawatan, mampu memodifikasi lingkungan sehingga menunjang upaya peningkatan kesehatan, mampu memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yang ada.

Keluarga menjadi faktor utama dalam upaya mencapai kesehatan masyarakat secara optimal karena memiliki keterkaitan dengan masalah kesehatan, memiliki fungsi utama dalam masyarakat dan lembaga yang menyangkut kehidupan masyarakat. Peran keluarga sebagai kelompok dapat melakukan aktivitas pencegahan, memelihara, menimbulkan, memperbaiki ataupun mengabaikan masalah kesehatan yang ada di dalam kelompok /keluarga. Keluarga berperan sebagai pengambil keputusan dalam memelihara kesehatan anggota keluarganya, yang berarti keluarga menjadi faktor penentu sehat-sakitnya anggota keluarga, yang akan berdampak pada munculnya berbagai masalah kesehatan anggota keluarga (Rasni, 2017).

Kebutuhan Gizi Pada Bayi dan Balita

Gizi adalah suatu proses penggunaan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Balita adalah anak usia kurang dari lima tahun termasuk bayi usia di bawah satu tahun juga termasuk dalam golongan ini. Sesuai dengan pertumbuhan badan dan perkembangan kecerdasannya, balita mengalami perkembangan sehingga jenis makanan dan cara pemberiannya harus disesuaikan dengan keadaannya.

Gizi dan Nutrisi ibu hamil merupakan hal penting yang harus dipenuhi selama kehamilan berlangsung. Resiko akan kesehatan janin yang sedang dikandung dan ibu yang mengandung akan berkurang jika ibu hamil mendapatkan gizi dan nutrisi yang seimbang. Oleh karena itu, keluarga dan ibu hamil haruslah memperhatikan mengenai hal ini. Gizi atau nutrisi ibu hamil kondisinya sama saja dengan pengaturan gizi mengenai pola makan yang sehat. Selama kehamilan, anda memasok semua nutrisi untuk bayi anda yang sedang berkembang, yang beratnya kira-kira mencapai 3,5-3,75 kg pada saat lahir. Sistem pendukung kehidupan bayi anda (plasenta, rahim, membran cairan, dan pemasok darah ibu) bertumbuh selama kehamilan, berkembang sesuai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya yang meningkat. Sehingga sang ibu harus memenuhi nutrisinya sesuai dengan kebutuhannya dan sang bayi Status gizi merupakan keadaan keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi yang diperlukan tubuh untuk tumbuh kembang terutama untuk anak balita, aktivitas, pemeliharaan kesehatan, penyembuhan bagi mereka yang menderita sakit dan proses biologis lainnya di dalam tubuh (Depkes RI, 2008). Kebutuhan bahan makanan pada setiap individu berbeda karena adanya variasi genetik yang akan mengakibatkan perbedaan dalam proses metabolisme. Sasaran yang dituju yaitu pertumbuhan yang optimal tanpa disertai oleh keadaan defisiensi gizi. Status gizi

yang baik akan turut berperan dalam pencegahan terjadinya berbagai penyakit, khususnya penyakit infeksi dan dalam tercapainya tumbuh kembang anak yang optimal. Kelompok umur yang rentan terhadap penyakit-penyakit kekurangan gizi adalah kelompok bayi dan anak balita. Oleh sebab itu, indikator yang paling baik untuk mengukur status gizi masyarakat adalah melalui status gizi balita. Gizi balita adalah hal paling utama yang harus diperhatikan oleh orang tua jika ingin tumbuh kembang putra putrinya maksimal. Pemenuhan gizi pada setiap balita merupakan suatu keharusan karena hal ini sangat berpengaruh pada masa depan si buah hati, terutama pada 5 tahun pertama, karena apa yang terjadi selama 5 tahun pertama tersebut sangat menentukan tahun demi tahun pertumbuhan dan perkembangannya. Hal inilah yang seharusnya mendasari setiap orang tua untuk berusaha agar gizi anaknya terpenuhi semaksimal mungkin.

Kebutuhan Gizi Ibu hamil dan Balita, yang paling dasar adalah kebutuhan energi. Ibu hamil dan balita membutuhkan energi (sebagai kalori) untuk memungkinkan mereka untuk beraktivitas serta untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh mereka. Tubuh mendapatkan energi terutama dari lemak dan karbohidrat tetapi juga beberapa dari protein. Asupan kalori dibutuhkan oleh semua manusia termasuk ibu hamil, bayi dan balita. Anak-anak usia balita membutuhkan kalori yang cukup banyak disebabkan Bergeraknya cukup aktif pula. Mereka membutuhkan setidaknya 1500 kalori setiap harinya. Dan balita bisa mendapatkan kalori yang dibutuhkan pada makanan-makanan yang mengandung protein, lemak dan gula.

Protein menjadi satu kebutuhan vital selain dari kebutuhan kalori untuk menjadi sumber pembangun sebagai bahan utama pertumbuhan. Selain menjadi sumber bagi kalori dan zat pembangun, pembentukan darah dan sel merupakan salah satu fungsi protein. Protein dibutuhkan oleh ibu hamil dengan jumlah sekitar 60 gram setiap harinya atau 10 gram lebih banyak dari biasanya. Protein bisa didapatkan dari kacang-kacangan, tempe, putih telur, daging dan tahu. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan dan perbaikan jaringan tubuh, serta untuk membuat enzim pencernaan dan zat kekebalan yang bekerja untuk melindungi tubuh si kecil. Kebutuhan protein secara proporsional lebih tinggi untuk anak-anak daripada orang dewasa. Asupan gizi yang baik bagi balita juga terdapat pada makanan yang mengandung protein. Karena protein sendiri bermanfaat sebagai prekursor untuk neurotransmitter demi perkembangan otak yang baik nantinya. Protein bisa didapatkan pada makanan-makanan seperti ikan, susu, telur 2 butir, daging 2 ons dan sebagainya. Sumber protein ikan, susu, daging, telur, kacang-kacangan dapat ditunda pemberiannya bila timbul alergi atau ganti dengan sumber protein lain. Untuk

vegetarian, gabungkan konsumsi susu dengan minuman berkadar vitamin C tinggi untuk membantu penyerapan zat besi.

Kebutuhan lemak menjadi satu unsur gizi penting yang juga dibutuhkan saat masa pertumbuhan. Beberapa lemak dalam makanan sangat penting dan menyediakan asam lemak esensial, yaitu jenis lemak yang tidak tersedia di dalam tubuh. Lemak dalam makanan juga berfungsi untuk melarutkan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E dan K. Anak-anak membutuhkan lebih banyak lemak dibandingkan orang dewasa karena tubuh mereka menggunakan energi yang lebih secara proporsional selama masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Namun, Anjuran makanan sehat untuk anak usia lebih dari 5 tahun adalah asupan lemak total sebaiknya tidak lebih dari 35% dari total energi. Sumber lemak dalam makanan bisa di dapat dalam: mentega, susu, daging, ikan, minyak nabati.

Tentunya sumber tenaga didapatkan dari karbohidrat yang menjadi unsur gizi penting untuk masa pertumbuhan. Frekuensi glukosuria ibu hamil yang relatif tinggi dan adanya glukosuria pada kebanyakan wanita hamil setelah mendapat 100gram dextrose per oral. Normalnya, pada wanita hamil tidak glukosuria. Kebutuhan karbohidrat lebih kurang 65% dari total kalori sehingga perlu penambahan. Karbohidrat merupakan pati dan gula dari makanan, pati merupakan komponen utama dari sereal, kacang-kacangan, biji-bijian dan sayuran akar, karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi anak. Hampir separuh dari energi yang dibutuhkan seorang anak sebaiknya berasal dari sumber makanan kaya karbohidrat seperti roti, sereal, nasi, mi, kentang. Anjuran konsumsi karbohidrat sehari bagi anak usia 1 tahun ke atas antara 50-60%. Anak-anak tidak memerlukan 'gula pasir' sebagai energi serta madu harus dibatasi. Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan karbohidrat sebagai energi utama serta bermanfaat untuk perkembangan otak saat belajar dikarenakan karbohidrat di otak berupa Sialic Acid. Begitu juga dengan balita, mereka juga membutuhkan gizi tersebut yang bisa diperoleh pada makanan seperti roti, nasi kentang, roti, sereal, kentang, atau mie. Kenalkan beragam karbohidrat secara bergantian. Selain sebagai menu utama, karbohidrat bisa diolah sebagai makanan selingan atau bekal sekolah seperti puding roti atau donat kentang yang lezat.

Serat adalah bagian dari karbohidrat dan protein nabati yang tidak dipecah dalam usus kecil dan penting untuk mencegah sembelit serta gangguan usus lainnya. Serat dapat membuat perut anak menjadi cepat penuh dan terasa kenyang, menyisakan ruang untuk makanan lainnya sehingga sebaiknya tidak diberikan berlebih

Vitamin adalah zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil untuk banyak proses penting yang dilakukan dalam tubuh. Mineral adalah zat anorganik yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi. Makanan yang berbeda memberikan vitamin dan mineral yang berbeda dan memiliki diet yang bervariasi dan seimbang. Ini penting untuk menyediakan jumlah yang cukup dari semua zat gizi. Ada beberapa pertimbangan pemberian zat gizi untuk diingat, seperti pentingnya zat besi dan pemberian vitamin dalam bentuk suplemen.

Zat besi diperlukan untuk memproduksi hemoglobin (protein pembawa oksigen dalam darah). Karena volume darah meningkat 50% selama kehamilan, hemoglobin dan konstituen darah lainnya juga harus meningkat. Selama enam minggu terakhir kehamilan, janin akan menyimpan zat besi dalam jumlah yang memadai dalam harinya untuk memenuhi kebutuhannya pada tiga atau enam bulan pertama kehidupan. Usia balita merupakan usia yang cenderung kekurangan zat besi sehingga balita harus diberikan asupan makanan yang mengandung zat besi. Makanan atau minuman yang mengandung vitamin C seperti jeruk merupakan salah satu makanan yang mengandung gizi yang bermanfaat untuk penyerapan zat besi.

Kalsium meningkatkan mineralisasi rangka janin dan gigi-gigi. Janin membutuhkan kalsium 66% lebih besar selama trimester ketiga (saat gigi-gigi terbentuk dan pertumbuhan rangka terjadi paling cepat) dibanding pada awal perkembangannya. Kalsium juga disimpan dalam tulang-tulang ibu sebagai cadangan untuk memproduksi ASI.

Balita juga membutuhkan asupan kalsium secara teratur sebagai pertumbuhan tulang dan gigi balita. Salah satu pemberi kalsium terbaik adalah susu yang diminum secara teratur. Kebutuhan Zat Gizi Balita Usia 2-5 Tahun. Di usia ini anak memasuki usia pra sekolah dan mempunyai risiko besar terkena gizi kurang. Pada usia ini anak tumbuh dan berkembang dengan cepat sehingga membutuhkan zat gizi yang lebih banyak, sementara mereka mengalami penurunan nafsu makan dan daya tahan tubuhnya masih rentan sehingga lebih mudah terkena infeksi dibandingkan anak dengan usia lebih tua.

Zat gizi yang mereka perlukan adalah:

1. Karbohidrat berfungsi sebagai penghasil energi bagi tubuh dan menunjang aktivitas anak yang mulai aktif bergerak. Mereka biasanya membutuhkan sebesar 1300 kkal per hari.
2. Protein berfungsi untuk membangun dan memperbaiki sel tubuh dan menghasilkan energi. Mereka membutuhkan protein sebesar 35 gram per hari

3. Mineral dan vitamin yang penting pada makanan anak adalah yodium, kalsium, zinc, asam folat, asam folat, zat besi, vitamin A, B, C, D, E, dan K.

Mineral dan vitamin ini berperan dalam perkembangan motorik, pertumbuhan, dan kecerdasan anak serta menjaga kondisi tubuh anak agar tetap sehat. Sementara pertumbuhan fisik tubuh sedikit melambat, karenanya anak perlu makan makanan yang memberikan asupan gizi yang mendukung pertumbuhan otaknya. Balita yang makan makanan yang beragam dan seimbang nilai gizinya akan tumbuh sehat dan aktif. Agar kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh terpenuhi, anak perlu dibiasakan untuk makan makanan yang bergizi seimbang.

Pesan Gizi Seimbang untuk Anak Usia 2 – 5 Tahun:

1. Biasakan makan 3 kali sehari (pagi, siang dan malam) bersama keluarga Untuk memenuhi kebutuhan zat gizi selama sehari dianjurkan agar anak makan secara teratur 3 kali sehari dimulai dengan sarapan atau makan pagi, makan siang dan makan malam. Untuk menghindarkan/mengurangi anak-anak mengonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi dianjurkan agar selalu makan bersama keluarga. Sarapan setiap hari penting terutama bagi anak-anak oleh karena mereka sedang tumbuh dan mengalami perkembangan otak yang sangat tergantung pada asupan makanan secara teratur.
2. Perbanyak mengonsumsi makanan kaya protein seperti ikan, telur, tempe, susu dan tahu. Untuk pertumbuhan anak, dibutuhkan pangan sumber protein dan sumber lemak kaya akan Omega 3, DHA, EPA yang banyak terkandung dalam ikan. Anak-anak dianjurkan banyak mengonsumsi ikan dan telur karena kedua jenis pangan tersebut mempunyai kualitas protein yang bagus. Tempe dan tahu merupakan sumber protein nabati yang kualitasnya cukup baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika memberikan susu kepada anak, orang tua tidak perlu menambahkan gula pada saat menyiapkannya. Pemberian susu dengan kadar gula yang tinggi akan membuat selera anak terpaku pada kadar kemanisan yang tinggi. Pola makan yang terbiasa manis akan membahayakan kesehatannya di masa yang akan datang.
3. Perbanyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan adalah pangan sumber vitamin, mineral dan serat. Vitamin dan mineral merupakan senyawa bioaktif yang tergolong sebagai antioksidan, yang mempunyai fungsi antara lain untuk mencegah kerusakan sel. Serat berfungsi untuk memperlancar pencernaan dan dapat mencegah dan menghambat perkembangan sel kanker usus besar.
4. Batasi mengonsumsi makanan selingan yang terlalu manis, asin dan berlemak. Pangan manis, asin dan berlemak banyak berhubungan dengan penyakit kronis

tidak menular seperti diabetes mellitus, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung.

5. Minumlah air putih sesuai kebutuhan. Sangat dianjurkan agar anak-anak tidak membiasakan minum-minuman manis atau bersoda, karena jenis minuman tersebut kandungan gulanya tinggi. Untuk mencukupi kebutuhan cairan sehari hari dianjurkan agar anak-anak minum air sebanyak 1200 – 1500 mL air/hari.
6. Biasakan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik setiap hari, dengan semakin berkembangnya teknologi dan kemudahan akses permainan tanpa aktivitas fisik yang banyak ditawarkan permainan. Teknologi canggih (electronic game), menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi para orang tua akan perkembangan mental serta psikomotorik anak. Permainan tradisional dan bermain bersama teman penting untuk anak-anak karena dapat melatih kemampuan sosial dan mental anak. Permainan tradisional dan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik dalam bentuk permainan dapat mengusir rasa bosan pada anak dan merangsang perkembangan kreativitasnya. Hal ini akan mendukung tumbuh kembang dan kecerdasan anak.

Antropometri adalah ukuran tubuh manusia. Sedangkan antropometri gizi adalah berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dan tingkat umur dan tingkat gizi. WHO merekomendasikan pengukuran antropometri pada bayi dan balita menggunakan grafik yang dikembangkan oleh WHO dan Center for Disease Control and Prevention (CDC). Grafik yang digunakan adalah z-score sebagai standar deviasi rata-rata dan persentil median.

Tabel 5.1 Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak Berdasarkan Indeks

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Berat badan menurut umur (BB/U) Anak umur 0-60 bulan	Gizi Buruk	<-3 SD
	Gizi Kurang	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Gizi Baik	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Gizi Lebih	> 2 SD
Panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) Anak umur 0-60 bulan	Sangat pendek	<-3 SD
	Pendek	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Tinggi	> 2 SD
Berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) Anak umur 0-60 bulan	Sangat kurus	<-3 SD
	Kurus	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Gemuk	> 2 SD

Definisi menurut WHO

Underweight

- $BB/U < -2$ standard deviations (SD) of the WHO Child Growth Standards median

Stunting

- $TB/U < -2$ SD of the WHO Child Growth Standards median

Wasting

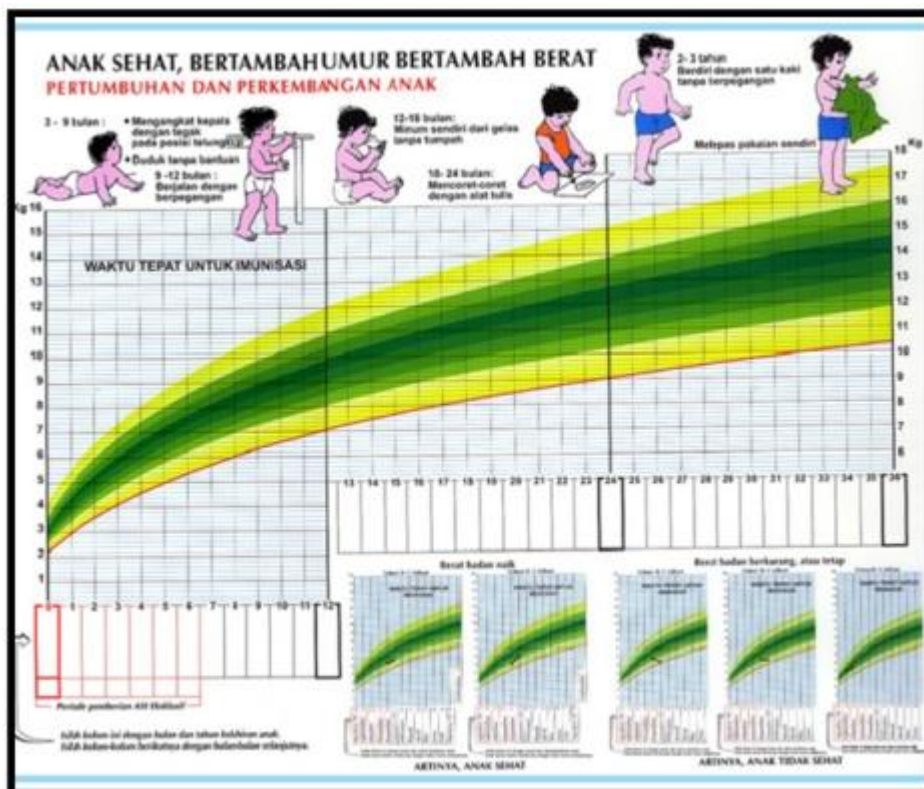
- $BB/TB < -2$ SD of the WHO Child Growth Standards median

Overweight

- $BB/TB > +2$ SD of the WHO Child Growth Standards median

Sumber: WHO 1994

Gambar 5.1 Pengertian Istilah menurut WHO



Gambar 5.2 KMS

Peran Orangtua dalam Pemenuhan Gizi dengan Pendekatan Ethno-Agronursing

Prinsip dalam mengasuh dan membimbing anak:

A. Penuh Kasih Sayang

Sejak kecil anak harus dapat merasakan bahwa ia disayangi, disenangi, diperhatikan, diterima, dan dihargai. Kasih sayang itu ditunjukkan secara wajar, sesuai dengan umur anak. Misalnya dengan mencium, membelai, memuji, menepuk bahunya, mengucapkan kata-kata yang menghiburkan atau meneguhkan. Kasih sayang orangtua harus ajek dan tulus, artinya tetap ada sepanjang masa, bahkan pada saat anak berbuat salahpun dia tetap merasa bahwa ia disayangi. Nyata, sehingga anak benar-benar merasakan adanya kasih sayang tersebut. Suasana kasih sayang penting dikembangkan di dalam keluarga, terutama dalam kehidupan orangtua sebagai suami isteri, sebagai contoh langsung kepada anak. Kasih sayang dan kesetiaan di antara suami-isteri akan menimbulkan perasaan aman di dalam keluarga, sehingga menjadi tempat berkembangnya anak-anak dengan subur. Hal ini akan mendorong terbentuknya kasih sayang di dalam jiwa dan sanubari anak-anak.

B. Penanaman disiplin yang konstruktif

Sebaiknya sediakan batasan dari tingkah laku anak yang merupakan tata tertib dalam keluarga. Hal ini akan merupakan pedoman bagi anak, sehingga ia dapat mengerti tingkah laku apa yang diperbolehkan dan tingkah laku mana yang tidak diperbolehkan. Dengan adanya tata tertib ini akan juga dilatih agar mengenal disiplin, sehingga ia dapat mengendalikan diri serta bertanggungjawab. Hal ini sangat penting bila anak sudah dewasa, agar ia dapat menyesuaikan diri dengan norma dan aturan di masyarakat.

Sepuluh cara dalam melaksanakan disiplin pada anak:

1. konsisten (tidak berubah)

ada kesepakatan antara ayah dan ibu, sehingga setiap tindakan dalam menanamkan disiplin tidak berubah-ubah/. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara ayah dan ibu agar diselesaikan berdua tanpa diketahui oleh anak.

2. jelas

berikan aturan yang sederhana dan jelas sehingga anak mudah melakukannya.

3. memperhatikan harga diri anak

bila memungkinkan, jangan menghukum anak di hadapan orang lain. Hal ini akan membuat anak merasa malu, sehingga tetap mempertahankan perilakunya yang salah tersebut (karena gengsi)

4. beralasan dan dapat dimengerti

alasan tata tertib yang dilakukan itu perlu dijelaskan kepada anak, sehingga anak melakukannya dengan penuh kesadaran. Namun, pada situasi tertentu orangtua perlu memahami posisi anak. Hal ini akan menambah dekatnya hubungan orangtua dan anak

5. memberikan hadiah

hadiah berupa pujian atau barang, diberikan apabila anak berbuat sesuai dengan yang diharapkan

6. hukuman

hukuman terutama dititikberatkan pada perbuatan anak yang salah, bukan pada diri anak sendiri, agar tidak timbul rasa dendam serta anak tidak kehilangan kepercayaan kepada dirinya. Bila mungkin, orangtua harus segera berbaik kembali dengan anak, tanpa rasa dendam. Dalam menegur anak bila berbuat salah, sebaiknya jangan lupa menyebutkan perbuatan yang baik terlebih dahulu sebelum menyebutkan perbuatan yang salah

7. luwes

jangan terlalu kaku dalam menegakkan disiplin, khususnya terhadap remaja. Sesuatu yang baik diterapkan pada seorang anak, belum tentu berlaku untuk anak yang lain. Jadi, sesuaikan dengan situasi dan kondisi anak.

8. keterlibatan anak

sebaiknya anak dilibatkan dalam membuat setiap tata tertib

9. bersikap tegas

apabila dianggap perlu memberikan hukuman, jangan terbawa arus bujuk rayu anak. Bersikap tegas bukan berarti bersikap kasar, baik dalam tindakan (fisik) maupun perkataan.

10. jangan emosional

dalam menghukum anak, hindari keterlibatan emosi orangtua. Misalnya jika orangtua dalam keadaan jengkel, dapat menghukum anak tidak sesuai dengan kesalahannya.

C. Meluangkan waktu kebersamaan

Meluangkan waktu bersama anak merupakan hal yang amat penting dalam pendidikan, sehingga terciptalah lingkungan dan suasana yang menunjang perkembangan mereka. Misalnya meluangkan waktu untuk:

1. bermain bersama dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan anak dan hindarkan sikap mengatur dan mempengaruhi mereka
2. berbincang-bincang dengan anak, saling mendengar dan saling menanggapi.
3. Melatih keterampilan sehari-hari, seperti memasak atau memperbaiki mainan, yang akan sangat berguna bagi mereka di kemudian hari
4. Melakukan kegiatan bersama secara teratur, seperti makan, menonton, atau berlibur bersama akan menambah semangat dan perasaan memiliki di dalam keluarga

D. Membedakan yang salah dan benar, yang baik dan yang buruk

Ajarkan kepada anak untuk membedakan yang salah dan yang benar, yang baik dan yang buruk. Hal-hal yang diajarkan ialah nilai-nilai yang berlaku di lingkungan keluarga, masyarakat sekitarnya, dan budaya bangsa, misalnya adat istiadat, norma, dan nilai yang berlaku. Hal itu diperlukan agar anak mudah menyesuaikan diri dengan masyarakat. Contoh: berlaku ramah dan jujur terhadap orang lain, menghargai orang lain beserta miliknya. Sikap dan perilaku hormat terhadap orang yang lebih tua. Cara yang paling baik yaitu orangtua langsung memberikan contoh dalam sikap dan perilakunya sehari-hari.

E. Mengembangkan sikap saling menghargai

Orangtua perlu menciptakan suasana saling menghargai satu sama lain, misalnya bila orangtua berbuat salah, jangan segan untuk segera meminta maaf. Tunjukkan perhatian terhadap kegiatan anak, berlaku jujur dan tulus setiap saat, jangan pilih kasih, selalu berusaha menepati janji, dan menunjukkan kepercayaan kepada anak. Disamping itu, orang tua juga perlu mendorong anak agar menghargai dan menghormati orangtua.

F. Memperhatikan dan mendengar pendapat anak

Orangtua memberi perhatian kepada anak sejak usia dini dan mencoba melihat segala sesuatu dari sisi anak. Dengarkan dan berusahalah untuk mengerti pendapat anak tanpa dipengaruhi oleh pendapat orangtua. Pakailah bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hal ini akan membuat hubungan orangtua dan anak menjadi lebih dekat, sehingga anak dapat menyatakan perasaannya, termasuk perasaan yang baik dan yang buruk seperti rasa marah dan tidak senang, tanpa takut kehilangan kasih sayang dari orangtua.

G. Membantu mengatasi masalah

Anak membutuhkan bimbingan bila ia terbentur pada suatu masalah, namun orangtua jangan memaksakan pendapatnya. Tawarkanlah pendapat anda kepada anak, namun bukan merupakan peraturan yang mutlak harus dijalankan. Berilah

kesempatan terlebih dahulu kepada mereka untuk menyelesaikan masalahnya sebelum anda memberikan bantuan sehingga mereka tidak menjadi malas dan selalu tergantung kepada orangtua.

H. Mengembangkan kemandirian

Rasanglah inisiatif anak dan berikan kebebasan kepada mereka untuk mengembangkan diri. Beri kesempatan kepada mereka untuk mengerjakan sesuatu menurut mereka sendiri, asal tidak bertentangan dengan norma masyarakat, untuk memupuk inisiatif dini, orangtua perlu memuji hasil karya anak. Bila hasil karya anak selalu dicela, maka hal tersebut akan bersarang terus dalam hatinya, sehingga kegairahan dan kepercayaan diri anak menjadi berkurang. Anak akan apatis, malas, sukar mengambil keputusan, dan selalu bergantung pada orang lain.

I. Memahami keterbatasan anak

Setiap anak mempunyai keterbatasan. Hendaknya orangtua jangan menuntut melebihi kemampuan anak, dan jangan membandingkan anak yang satu dengan yang lain. Santrock (2002) menuliskan mengenai gaya pengasuhan orangtua pada anak-anaknya, orang tua ingin anak bertumbuh menjadi individu-individu yang dewasa secara sosial, dan mereka mungkin merasa frustrasi dalam mencoba menemukan cara terbaik untuk mencapai pertumbuhan ini. Diana Baumrind (1971, dalam Santrock 2002) menekankan tiga tipe pengasuhan yang dikaitkan dengan aspek-aspek yang berbeda dalam perilaku sosial anak: otoriter, otoritatif (demokratik), dan *Laissez-faire* (permisif) dengan pengelompokan *permissive-indulgent* dan *permissive-indifferent*

1. Pengasuhan yang otoriter

Suatu gaya membatasi dan menghukum yang menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orangtua dan menghormati pekerjaan dan usaha. Orangtua yang otoriter menetapkan batas-batas yang tegas dan tidak memberi peluang yang besar kepada anak-anak untuk berbicara (bermusyawarah). Pengasuhan yang otoriter diasosiasikan dengan inkompetensi sosial anak-anak. Misalnya, seorang orangtua yang otoriter mungkin mengatakan: "Kau lakukan itu sesuai dengan perintahku atau tidak sama sekali. Tidak usah banyak bicara!" Anak-anak yang orangtuanya otoriter seringkali cemas akan perbandingan sosial, gagal memprakarsai kegiatan, dan memiliki keterampilan komunikasi yang rendah.

2. Pengasuhan yang otoritatif (demokratik)

Mendorong anak-anak agar mandiri tetapi masih menetapkan batas-batas dan pengendalian atas tindakan-tindakan mereka. Musyawarah verbal yang

ekstensif dimungkinkan, dan orangtua memperlihatkan kehangatan serta kasih sayang kepada anak. Pengasuhan yang otoritatif diasosiasikan dengan kompetensi sosial anak-anak. Orangtua yang otoritatif mungkin melingkarkan lengannya kepada anak dengan cara yang baik dan berkata: "Kau tahu kau seharusnya tidak boleh melakukan hal itu; ayo kita bicara bagaimana kau dapat mengatasi situasi seperti ini lebih baik di masa yang akan datang." Anak-anak yang mempunyai orangtua otoritatif berkompetensi secara sosial, percaya diri, dan bertanggungjawab sosial

3. Pengasuhan yang *permissive-indifferent*

Suatu gaya dimana orangtua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak; tipe pengasuhan ini diasosiasikan dengan inkompetensi sosial anak, khususnya kurang kendali diri. Orangtua ini tidak dapat menjawab pertanyaan: "ini sudah jam 10 malam. Kau tahu di mana anak kita?" anak-anak memiliki keinginan yang kuat agar orangtua mereka peduli terhadap mereka; anak-anak yang orangtuanya bergaya *permissive-indifferent* mengembangkan suatu perasaan bahwa aspek-aspek lain kehidupan orangtua lebih penting daripada mereka. Anak-anak yang orangtuanya bergaya *permissive-indifferent* menjadi inkompeten secara sosial, mereka memperlihatkan kendali diri yang buruk dan tidak membangun kemandirian dengan baik

4. Pengasuhan yang *permissive-indulgent*

Suatu gaya pengasuhan dimana orangtua sangat terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka tetapi menetapkan sedikit batas atau kendali terhadap mereka. Pengasuhan yang *permissive indulgent* diasosiasikan dengan inkompetensi sosial anak, khususnya kurang kendali diri. Orangtua seperti itu membiarkan anak-anak mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan, dan akibatnya ialah anak-anak tidak pernah belajar mengendalikan perilaku mereka sendiri dan selalu mengharapkan kemauan mereka dituruti. Beberapa orangtua dengan sengaja mengasuh anak-anak mereka dengan cara seperti ini karena mereka yakin kombinasi keterlibatan yang hangat dengan sedikit kekangan akan menghasilkan anak yang kreatif dan percaya diri.

Mengasuh dan membimbing anak sesuai tahap perkembangan. Mengasuh dan membimbing anak dalam keluarga yaitu melihat perkembangan anak dari bayi hingga dewasa yang terdiri dari lima tahap. Tahap ini akan dilalui secara berurutan. Setiap tahap mempunyai ciri dan tuntutan perkembangan tersendiri, untuk membantu perkembangan anak, orangtua harus memahami tahapan perkembangan tersebut dan memenuhi kebutuhan perkembangan anak pada tahap itu.

Pemenuhan kebutuhan perkembangan anak meliputi pemenuhan kebutuhan jasmani, sosial, dan mental-emosionalnya.

A. Tahap Pertama: Anak Usia 0 - 1,5 Tahun

Peranan ibu (tokoh ibu) dalam membantu perkembangan anak usia 0-3 tahun amat menonjol. Usia 3 tahun, anak mengenal tokoh ayah, dan di sini peranan ayah mulai penting. Bayi di dalam kandungan hidup serba teratur, hangat, dan penuh perlindungan. Setelah dilahirkan, ia sepenuhnya bergantung kepada orang lain. Bayi perlu dibantu untuk mempertahankan hidupnya dalam suatu lingkungan yang masih asing dan baru baginya. Jangan membiarkan bayi terlalu lama atau sering menangis, karena tangisan tersebut menunjukkan bahwa bayi dalam keadaan stres.

1. Ciri dan tuntutan perkembangan

Memperoleh rasa aman dan rasa percaya dari lingkungan merupakan dasar yang penting dalam hubungan anak dengan lingkungannya di kemudian hari. Rasa aman ini diperolehnya melalui sentuhan fisik yang menyenangkan dengan ibunya dan sesedikit mungkin mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan.

2. Sikap orangtua

- a. Penuh kasih sayang dalam merawat dan mengasuh akan menimbulkan perasaan aman serta percaya pada bayi.
- b. Kesiapan ibu pada setiap saat dibutuhkan oleh bayi, juga menimbulkan rasa aman dan percaya pada bayi.
- c. Pemberian ASI sesuai dengan kebutuhan bayi. Tidak terlalu ketat dengan jadwal pemberian makanan, karena setiap bayi mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.
- d. Bila ibu dalam keadaan terpaksa memberikan susu botol, perlakukanlah seperti bayi minum ASI, yaitu dengan cara memeluknya.
- e. Ketika bayi rewel, carilah penyebabnya dan atasilah masalahnya. Tangisan tidak selalu berarti bahwa bayi lapar.
- f. Angkat dan peluklah bayi serta gendonglah berkeliling rumah/halaman sambil menunjukkan benda-benda yang ada di sekitarnya
- g. Sering-seringlah berbicara kepada bayi anda setiap hari, pada saat memakaikan pakaian, memberinya makan, memandikan, atau ketika melakukan kesibukan rumah tangga lainnya. Bayi tidak pernah terlalu muda untuk diajak bicara
- h. Ajaklah bayi anda bermain sambil tersenyum dan tirulah gerakan, mimik, dan kegiatannya. Bayi akan menirukan kegiatan yang dilihatnya.

- i. Senandungan dan ayunlah bayi pada saat menidurkan, sehingga ia akan tertidur dengan nyaman
- j. Perkenalkan dengan berbagai macam benda, bunyi-bunyian, dan warna. Hal ini akan mempercepat perkembangan bayi

Segala hal yang dapat mengganggu proses menyusui dalam hubungan ibu-anak pada tahap ini akan menyebabkan terganggunya pembentukan rasa aman dan percaya. Hal ini menyebabkan goyahnya tahap perkembangan berikutnya. Anak diliputi rasa tidak aman dan tidak percaya.

3. Gangguan/ penyimpangan yang dapat timbul pada tahap ini
 - a. Kesulitan makan
 - b. Mudah terangsang/marah/tersinggung (iritabilitas)
 - c. Menolak segala sesuatu yang baru
 - d. Sikap dan tingkah laku yang seolah-olah ingin melekat pada ibu dan menolak lingkungan

Bila gangguan itu tidak diatasi dengan baik, maka pada masa dewasa timbul kelainan jiwa yang dicoraki ketergantungan (dependensi) yang kuat, seperti:

1. Depresi (rasa murung, sedih, dan perasaan tertekan)
2. Adiksi obat
3. Skizofrenia (gangguan jiwa dengan kepribadian yang terpecah)

B. Tahap Kedua: Anak Usia 1,5 – 3 Tahun

Bertambah matangnya perkembangan fisik, anak sudah bisa berjalan, ia mulai menyadari bahwa gerakan badannya dapat diaturnya sendiri, dikuasai, dan digunakan untuk suatu maksud. Tahap ini merupakan tahap pembentukan rasa otonomi diri. Apabila terdapat gangguan dalam mencapai rasa otonomi diri maka anak akan dikuasai rasa malu, ragu-ragu, dan pengekan diri yang berlebihan.

1. Ciri dan tuntutan perkembangan

Anak akan bergerak dan berbuat sesuatu sesuai dengan kemauannya sendiri, sehingga ia seolah-olah ingin mencoba sesuatu yang dapat dilakukannya, tak henti-henti ia berjalan dengan perasaan senang dan puas, tangannya meraih segala sesuatu yang terjangkau olehnya. Anakpun dapat menuntut atau menolak sesuatu yang ia kehendaki atau tidak dikehendaki, melalui pengalaman pada tahap ini akan tertanam dalam diri anak perasaan otonomi diri, yaitu suatu rasa kemampuan mengatur badannya dan lingkungannya sendiri. Hal ini akan menjadi dasar terbentuknya rasa yakin pada diri dan harga diri di kemudian hari.

2. Sikap orangtua

- a. doronglah agar anak dapat bergerak bebas dan berlatih melakukan hal-hal yang diperkirakan mampu ia kerjakan, sehingga akan menumbuhkan rasa kemampuan diri. Namun, harus bersikap tegas untuk melindungi dari bahaya, karena dorongan anak berbuat belum diimbangi oleh kemampuan untuk melaksanakannya secara wajar dan rasional
- b. usahakanlah agar anak mau bermain dengan anak lainnya, dengan demikian ia belajar mengikuti aturan permainan. Namun, jangan lupa bahwa dalam bermain atau berhubungan dengan orang lain, anak masih bersifat egoistik, yaitu mementingkan diri sendiri dan memperlakukan orang lain sebagai obyek atau benda sesuai dengan kemauannya sendiri.
- c. Banyaklah berbicara kepada anak dalam kalimat pendek yang mudah dimengerti
- d. Bacakanlah buku cerita atau dongeng kepada anak setiap hari, dan doronglah agar ia mau menceritakan kepada oranglain mengenai yang dilihat atau dengar
- e. Ajaklah anak ke taman, toko, kebun binatang, lapangan terbang, atau tempat lainnya
- f. Usahakanlah agar anak dapat membereskan mainannya setelah bermain, membantu kegiatan rumah tangga yang ringan dan menanggalkan pakaiannya sendiri tanpa bantuan. Hal ini akan melatih bertanggungjawab
- g. Latihlah anak dalam hal kebersihan diri, yaitu buang air kecil dan buang air besar pada tempatnya, namun jangan terlalu ketat
- h. Latihlah anak untuk makan sendiri memakai sendok dan garpu, dan ajaklah anak makan bersama keluarga
- i. Berilah alat permainan yang sederhana, dan doronglah agar anak mau bermain balok-balok atau menggambar
- j. Jangan terlalu banyak memberikan larangan. Namun, orangtua pun jangan terbiasa menuruti segala permintaan anak. Bujuklah dan tenangkanlah anak ketika ia kecewa, dengan cara memeluknya dan mengajaknya berbicara. Gangguan dalam mencapai rasa otonomi diri akan berakibat bahwa anak dikuasai oleh rasa malu dan keragu-raguan serta pengekan diri yang berlebihan, sebaliknya dapat juga terjadi sikap melawan dan memberontak.

3. Gangguan/penyimpangan yang dapat timbul pada tahap ini

- a. kesulitan makan, terutama bila ibu memaksa makan
- b. suka mengadat (ngambek/ *temper tantrum*)
- c. tingkah laku kejam (*sadistik*)
- d. tingkah laku menentang dan keras kepala

- e. gangguan dalam berhubungan dengan orang lain yang diwarnai oleh sikap menyerang (agresi)

C. Tahap Ketiga: Anak Usia 3-6 Tahun

Anak mengalami peningkatan kemampuan berbahasa dan kemampuan melakukan kegiatan yang bertujuan, anak siap meluaskan lingkup gerak terhadap dunia sekitarnya.

1. Ciri dan tuntutan perkembangan

- a. anak bersifat ingin tahu, banyak bertanya berbagai macam, dan meniru kegiatan di sekitarnya
- b. anak mulai melibatkan diri dalam kegiatan bersama dan menunjukkan inisiatif untuk mengerjakan sesuatu, tapi ia tidak mementingkan hasilnya. Pengalaman dalam melakukan aktivitas ini amat penting artinya bagi anak
- c. seringkali terlihat bahwa anak cenderung berpindah-pindah dan meninggalkan tugas yang diberikan kepadanya untuk melakukan yang lain. Hal ini dapat menimbulkan krisis baru karena hal itu bertentangan dengan lingkungan yang semakin menuntut, sehingga anak mengalami kekecewaan.
- d. Jika dalam tahap sebelumnya hanya tokoh ibu yang bermakna bagi anak, dalam tahap ini tokoh ayah mempunyai peran penting baginya, di sini terbentuk segitiga hubungan kasih sayang ayah-ibu-anak. Anak laki-laki merasa lebih sayang kepada ibunya, dan anak perempuan lebih sayang kepada ayahnya
- e. Melalui peristiwa ini, anak dapat mengalami perasaan sayang, benci, iri hati, persaingan, memiliki, begitu pula mengalami perasaan takut dan cemas
- f. Kedua orangtua harus bekerjasama untuk membantu anak melalui tahap ini. Peranan orangtua sebagai tokoh ayah (sebagai tokoh pria dewasa) dan tokoh ibu (sebagai tokoh perempuan dewasa) sangat penting
- g. Ayah dan ibu merupakan suatu kesatuan, oleh karena itu orangtua jangan mau dimanipulasi oleh anak. Ayah dan ibu memberikan kasih sayang yang sama, baik terhadap anak perempuan ataupun anak laki-laki.
- h. Dengan terselesaikannya hubungan segitiga tersebut, maka anak perempuan akan beridentifikasi dengan ibunya, dan anak laki-laki dengan ayahnya (identitas seksual maupun identitas diri).
- i. Bila ibu terlalu dominan (menonjol pengaruhnya) dalam rumah tangga, sedangkan ayah kurang tegas atau ayah tidak ada (absen) secara fisik atau mental, anak akan terjadi identifikasi (proses meniru) yang salah. Anak laki-

laki akan beridentifikasi dengan ibunya, sehingga ia lebih mengembangkan sifat keperempuanan.

- j. Sebaliknya, bila ibu bersikap dingin dan kurang dekat dengan anak perempuannya, maka anak tersebut akan beridentifikasi dengan ayahnya, dan ia lebih mengembangkan sifat kepriaan.
- k. Anak mulai melihat adanya perbedaan jenis kelaminnya, seringkali terlihat anak laki-laki memegang alat kelaminnya sampai ereksi. Jangan anak dimarahi karena hal ini, tetapi alihkanlah perhatiannya, bila diatasi dengan baik fase ini akan berakhir dengan baik pada usia 6 tahun.

2. Sikap orangtua

- a. berilah kesempatan kepada anak untuk menyalurkan inisiatifnya, sehingga ia mendapat kesempatan untuk membuat kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut
- b. ikut sertakan anak dalam aktivitas keluarga, misalnya menyapu, berbelanja ke pasar, memasak, atau membetulkan mainan yang rusak
- c. jangan menakut-nakuti anak, pada anak laki-laki akan berakibat cemas, karena tahap ini ia sangat takut akan kehilangan alat kelaminnya (kartasis), sedangkan pada anak perempuan timbul rasa iri hati
- d. dengar dan hargailah pendapat serta usul yang dikemukakan oleh anak
- e. jangan menuntut yang melebihi kemampuan anak
- f. ibu perlu lebih dekat kepada anak perempuannya, sebaliknya ayah perlu lebih akrab dengan anak laki-lakinya
- g. jawablah pertanyaan anak dengan benar, jangan membohongi atau menunda jawabannya, misalnya bila anak bertanya bagaimana caranya adik keluar dari perut mama, jawablah bahwa keluarnya melalui jalan lahir, jangan katakan dibelah dari perut, hal ini akan menakutkan bagi anak yang dapat berdampak negatif pada jiwanya.
- h. Sering-seringlah membacakan buku cerita atau dongeng, kemudian diskusikanlah isi ceritanya dan tanyakanlah beberapa pertanyaan kepada anak
- i. Berilah ia kesempatan untuk mengunjungi tetangga, teman, dan saudara tanpa ditemani.
- j. Luangkan waktu setiap hari untuk berdialog dengan anak, dengarkanlah ia dan tunjukkanlah bahwa orangtua mengerti pembicaraannya dengan mengulangi topik yang dibicarakannya, pada saat ini janganlah menggurui, mencaci, dan menyepelkannya

- k. Ajarkanlah untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta tata tertib dan sopan santun yang berlaku di masyarakat setempat.
- l. Peranan ayah menjadi penting di sini, oleh karena itu ajaklah anak bermain bersama, disini ayah perlu bersikap sebagai teman bagi anak

Gangguan dalam mencapai rasa inisiatif akan menyebabkan anak merasa bersalah, rasa takut berbuat sesuatu, takut mengemukakan sesuatu, serta serba salah dalam pergaulan. Gangguan penyimpangan yang dapat timbul pada tahap ini:

- a. kesulitan belajar
- b. masalah sekolah
- c. masalah pergaulan dengan teman
- d. anak yang pasif dan takut serta kurang kemauan, kurang inisiatif

Mengutip yang dituliskan Fatmawati (2024) mengenai promosi kesehatan terkait dengan gizi bayi dan balita yaitu promosi kesehatan bukan hanya sebuah proses penyadaran individu maupun masyarakat atau peningkatan pengetahuan di bidang kesehatan saja, tapi juga merupakan sebuah program kesehatan yang telah dirancang untuk memperbaiki perubahan perilaku kesehatan masyarakat (Manggala et al., 2021). Promosi perilaku kesehatan merupakan intervensi yang penting dalam mengatasi masalah kesehatan, khususnya dalam konteks pencegahan kurang gizi pada masyarakat. Pengetahuan atau kognitif memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku seseorang; setelah pengetahuan terbentuk dengan baik, masyarakat menjadi tahu, mau, dan mampu melakukan perilaku pencegahan kurang gizi (Kirana et al., 2022). Promosi kesehatan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap individu, tetapi juga merupakan bagian dari program pemerintah untuk mengurangi angka stunting dan mengubah perilaku kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Draini et al., 2023a). Metode promosi kesehatan adalah pendekatan terstruktur yang digunakan untuk mengarahkan proses perubahan individu dalam mencapai tujuan kesehatan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara luas (A'ini et al., 2023; M. Sahli, 2021).

Fatmawati (2024) juga menyampaikan mengenai beberapa metode yang dapat digunakan dalam memberikan edukasi kesehatan termasuk metode ceramah, diskusi kelompok, curah pendapat, panel, permainan peran, demonstrasi, simposium, seminar untuk komunitas atau kelompok, serta bimbingan dan konseling untuk individu (Notoatmodjo, 2012). juga masih dikutip dari Fatmawati (2024) yaitu promosi perilaku kesehatan terutama pada kejadian stunting dan masalah kurang gizi

pada komunitas balita sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi risiko masalah kesehatan ini. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan (Rachmawati, 2019; Silitonga et al., 2024):

A. Pendidikan dan Informasi Kesehatan

1. Edukasi Gizi Memberikan informasi tentang makanan bergizi yang diperlukan selama kehamilan, untuk bayi, dan balita.
2. Promosi ASI: Mengedukasi pentingnya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi.
3. Promosi Makanan Pendamping ASI: Mengenalkan makanan pendamping ASI yang tepat saat bayi mulai menerima makanan padat.
4. Suplemen Gizi: Edukasi mengenai pentingnya suplemen gizi seperti zat besi dan vitamin A untuk ibu hamil dan balita.

B. Pemantauan Kesehatan Rutin

1. Pemeriksaan Kesehatan Berkala: Mendorong ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilan dan bayi/balita untuk pemeriksaan kesehatan berkala.
2. Pemantauan Pertumbuhan: Memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara teratur untuk mendeteksi dini masalah kesehatan.

C. Promosi Higiene dan Kebersihan

1. Pengelolaan Makanan dan Air: Edukasi tentang pentingnya memasak makanan dengan baik dan mengonsumsi air bersih.
2. Praktik Higiene: Mengedukasi tentang mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan dan sebelum memberi makan bayi atau balita.

D. Penyediaan Akses Terhadap Layanan Kesehatan

1. Kemudahan Akses: Memastikan komunitas memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan, termasuk posyandu atau puskesmas.
2. Kerjasama dengan Tenaga Kesehatan: Melibatkan petugas kesehatan untuk memberikan informasi dan layanan kesehatan yang diperlukan.

E. Kampanye Komunitas dan Pendekatan Partisipatif

1. Partisipasi Komunitas: Melibatkan tokoh masyarakat dan kelompok ibu-ibu untuk mendukung dan mengedukasi anggota komunitas lainnya.
2. Kampanye Edukasi: Menggunakan media sosial, pamflet, poster, dan ceramah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kesehatan.

F. Penguatan Peran Keluarga

1. Peran Ayah: Mengedukasi peran ayah dalam mendukung kesehatan ibu hamil dan perkembangan bayi/balita.
2. Peran Keluarga: Mendorong keluarga untuk aktif terlibat dalam memberikan perhatian dan dukungan pada gizi dan kesehatan anak.

G. Monitoring dan Evaluasi

1. Pemantauan Program: Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur untuk mengukur efektivitas program promosi kesehatan.
2. Penyesuaian Program: Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan penyesuaian dan perbaikan program agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan komunitas

Edukasi gizi merupakan salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan perilaku makan, yang berpotensi menciptakan status gizi yang optimal. Edukasi gizi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap terhadap konsumsi makanan, yang akan berdampak pada perilaku makan sehari-hari (Atasasih, 2022). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi prevalensi stunting, salah satunya melalui program "Isi Piringku" yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap makanan yang berkualitas dari segi jumlah dan gizi yang diberikan kepada balita (Sinaga et al., 2022). "Isi Piringku" merupakan panduan dari Kementerian Kesehatan yang mengedukasi masyarakat untuk mengonsumsi makanan sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Dalam setiap hidangan, setengah piring diisi dengan sayuran dan buah-buahan, sedangkan setengah sisanya diisi dengan sumber karbohidrat dan protein (Kemenkes, 2018). Pendekatan ini menunjukkan bahwa porsi makan yang seimbang, dengan 50% terdiri dari sayuran dan buah-buahan serta 50% sisanya dari karbohidrat dan protein, dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan balita (Kusuma et al., 2022).

Berikut merupakan tabel angka kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air yang dianjurkan (per orang per hari) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2019):

Tabel 5.2 Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia

Kelompok usia Balita	0 – 5 bulan	6 – 11 bulan	1 – 3 tahun	4 – 6 tahun
Berat badan (kg)	6	9	13	19
Tinggi badan (cm)	60	72	92	113
Energi (kkal)	550	800	1350	1400
Protein (g)	9	15	20	25
Lemak Total	31	35	45	50
(g) Omega 3	0.5	0.5	0.7	0.9
Omega 6	4.4	4.4	7	10
Karbohidrat (g)	59	105	215	220
Serat (g)	0	11	19	20
Air (ml)	700	900	1150	1450

Fadhilah (2013) yang berasal dari Fakultas Adab dan Humaniora & Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ada menuliskan mengenai Kearifan Lokal dalam Membentuk Daya Pangan Lokal Komunitas Molamahu Pulubala Gorontalo di dalam artikelnya tersebut ada tertulis mengenai makanan dalam konteks budaya merujuk pada persoalan– persoalan praktis serta perilaku konkret masyarakatnya, sebagian dari kita memang cenderung menilai orang lain dari selera budaya makannya, tanpa kita sadari dalam pergaulan antar suku bangsa atau antar bangsa telah terbentuk semacam stereotip etnik berdasarkan budaya makan; bukan hanya stereotip pada budaya makan tradisional, tapi juga pada budaya makan masa kini. Di masa kini kita masih mengidentikkan bangsa-bangsa tertentu dengan kebiasaan makan kebanyakan warganegaranya, seperti macaroni dan pizza bagi bangsa Itali, keju bagi bangsa Belanda dan Skandinavia; kentang bagi bangsa Irlandia; ayam, kentang goreng dan daging bagi bangsa Amerika; jagung bagi bangsa Mexico; sea-foods bagi bangsa Jepang; mie bagi bangsa Cina; nasi goreng dan sambal pedas bagi bangsa Indonesia. Keterikatan sosial pada makanan muncul ketika makanan itu disajikan pada berbagai peristiwa yang dialami oleh individu maupun masyarakat. Peristiwa yang mengacu pada siklus kehidupan manusia seperti kelahiran, menikah, dan kematian selalu dihadirkan dan ditandai dengan berbagai ritual yang dilengkapi dengan adanya ragam makanan, dan makan bersama baik dengan anggota keluarga maupun teman. Kebersamaan menjadi inti dari keterikatan masyarakat ketika makan bersama pada ritual tersebut. Cara penyajian makanan dibedakan dan disajikan untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk sesaji yang bersifat ritual keagamaan, cara penyajian makanan untuk

sehari-hari adalah sederhana, sedangkan untuk pesta atau upacara lebih rumit, bahkan tampak lebih sedap dipandang daripada dimakan.

Fadhilah (2013) juga menuliskan mengenai Makna Ketahanan Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan pangan, pengertian ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketahanan pangan menyangkut ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang cukup dan bermutu dalam hal ini terdapat aspek pasokan (supply), yang mencakup produksi dan distribusi pangan.

Stunting saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat utama di negara penghasil rendah dan menengah termasuk Indonesia (Mulyaningsih et al., 2021). Data dari UNICEF, WHO, dan World Bank menunjukkan bahwa sebanyak 22.2% dari anak diseluruh dunia mengalami stunting, jumlah ini lebih tinggi pada anak – anak di negara berpenghasilan menengah kebawah (UNICEF, 2018). Di Indonesia, kejadian stunting pada anak usia dibawah lima tahun mencapai 30.8%, meskipun jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI, 2019). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang dirilis Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa kasus stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari tahun 2021 sebanyak 24,4% menjadi 21,6% pada tahun 2022. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan kasus stunting sebanyak 3,8% pertahun atau mencapai target 14% kasus pada tahun 2024.

Keluarga berperan penting dalam pemenuhan nutrisi balita mulai masa kandungan (kesehatan maternal) hingga balita (Susanto, Yunanto, et al., 2021). Keluarga yang menjalankan peran dan fungsinya dengan baik berkaitan dengan pemenuhan status nutrisi balita yang lebih baik. Sehingga keluarga perlu secara aktif terlibat dalam pemenuhan dan monitoring status nutrisi balita khususnya dalam pencegahan dan penanganan stunting (Febrianti et al., 2022).

Peranan ibu dalam melakukan pemeriksaan gizi anak dan mengetahui serta memahami mengenai status gizi anak dapat meningkatkan kepedulian Ibu untuk mencegah terjadinya penyimpangan status gizi pada anak. Gangguan gizi bisa diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan gizi dalam upaya menerapkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan gizi ibu berdampak terhadap ketahanan pangan keluarga, dimana pemilihan bahan makanan keluarga sangat dipengaruhi oleh pengetahuan gizi ibu, ibu yang mempunyai pengetahuan gizi kurang, akan memilih bahan makanan yang kurang sesuai dengan persyaratan gizi, sehingga akan berdampak buruk terhadap pemberian makan dan asupan makan balita yang akan mempengaruhi status gizi balita.

Tabel 5.3 Kebutuhan Zat Gizi

Makronutrien								
Usia	Energi (kkal)	Protein	Lemak			Karbohidrat (g)	Air (ml)	
			Total	n-6	n-3			
0 – 6 bulan	550	12	34	4.4	0.5	58	-	
7 – 11 bulan	725	18	36	4.4	0.5	82	800	
1 -3 tahun	1125	26	44	7.0	0.7	155	1200	
4- 6 tahun	1600	35	62	10.0	0.9	220	1500	
Mikronutrien (vitamin)								
Usia	Vit A (mcg)	Vit D (mcg)	Vit E (mcg)	Vit K (mcg)	Vit B1 (mg)	Folat (mcg)	Vit B12 (mcg)	Vit C (mg)
0 – 6 bulan	375	5	4	5	0.3	65	0.4	40
7 – 11 bulan	400	5	5	10	0.4	80	0.5	50
1 -3 tahun	400	15	6	15	0.6	160	0.9	40
4- 6 tahun	450	15	7	20	0.8	200	1.2	45
Mikronutrien (Mineral)								
Usia	Ca (mg)	P (mg)	Mg (mg)	Na (mg)	K (mg)	Fe (mg)	I (mg)	Zn (mg)
0 – 6 bulan	200	100	30	120	500	-	90	-
7 – 11 bulan	250	250	55	200	700	7	120	3
1 -3 tahun	650	500	60	1000	3000	8	120	4
4- 6 tahun	1000	500	95	1200	3800	9	120	5

Sumber: Angka Kecukupan Gizi, 2013

Referensi

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas. (n.d.).

Rasni, H., Susanto, T., Nur, K. R. M., & Anoegrajekti, N. (2019). Pengembangan budaya masak abereng dalam peningkatan status gizi balita stunting di Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dengan pendekatan agronursing. *Journal of Community Empowerment for Health*, 1(2), 121. <https://doi.org/10.22146/jcoemph.42852>

White, J., Drummond, E., Bijalwan, V., Singhkumarwong, A., Betigeri, A., Blankenship, J., Badham, J., Cade, J., Cashin, J., Cosenza, L., Kupka, R., Morpeth, A., Mulder, A., Nasser, N., Nguyen, T., Pries, A., de Silva, A., Sweet, L., Threapleton, D., ... Zehner, E. (n.d.). *UNICEF East Asia and the Pacific Regional Office, and World Food Programme Asia Pacific Regional Office.*

Profil Penulis



Ns Liza Putri M.Kep, Lahir di Bengkulu, 20 April 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Stikes Tri Mandiri tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2018 pada Prodi D3 Keperawatan, Pernah Mengajar di Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, aktif dalam pengembangan karakter mahasiswa program Pendidikan Karakter.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lizaputri363@gmail.com

Motto: "setiap hari merupakan kesempatan baru untuk berkembang."



Nama lengkap: Yupi Supartini, S.Kp. M.Sc

Lahir di Cianjur, tanggal 14 September 1962

Pendidikan S1: Program Studi Ilmu Keperawatan FKUI

Pendidikan S2: Master of Health Care Practice, Liverpool John Moores University, Inggris

Mulai mengawali karir sebagai dosen di Akademi Keperawatan Dep Kes RI Jakarta, Jl. Kimia, 17 Jakarta Pusat, pada Januari 1985. Selanjutnya menjadi bagian dari jajaran manajemen Poltekkes Kemenkes Jakarta III dimulai sebagai Ketua Program Studi DIII Keperawatan, Ketua Jurusan Keperawatan, Pembantu Direktur I bidang akademik dan terakhir menjabat sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III pada April tahun 2018 sampai April 2024. Sejalan dengan tugas manajemen, penulis juga terus mengembangkan peran sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Jakarta III khususnya jurusan keperawatan dengan bidang keilmuan Keperawatan Anak dan saat ini berada di homebased Sarjana Terapan Keperawatan (STrKeperawatan dan profesi Ners). Penulis aktif melakukan darma lainnya baik Penelitian maupun Pengabdian Masyarakat di bidang Keperawatan Anak serta aktif berkontribusi dalam Organisasi Profesi Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI), Paediatric Nursing Society (PNS), Asia Pasific Paediatric Nursing Association (APPNA) dan International Children Paediatric Nursing Network (ICPCN).

Profil Penulis



Rina Nur Hidayati, S.Kep. Ns., M.Kep.,Sp.Kep.Kom Lahir di Mojokerto, 11 September 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, lulus tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Indonesia dan lulus tahun 2011. Selanjutnya melanjutkan pendidikan Spesialis Keperawatan Komunitas pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2012. Penulis bekerja di Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto mulai tahun 1999-

sekarang mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keluarga dan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar maupun narasumber pada area keperawatan komunitas, keluarga dan gerontik. Penulis tergabung dalam pengurus DPK PPNI, pengurus Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) dan pengurus organisasi Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI) Provinsi Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rinahaqqyraff@gmail.com

Motto: "Break free from the ordinary, explore the extraordinary."

"Never stop learning, growing, and evolving."



Helena Kidi Labot, SST., M.Kes. Lahir di Horinara Flores Timur. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Perawat Pendidik Universitas Hassanudin tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro dan lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 dimana awal menjadi guru pada Sekolah Perawat Kesehatan St. Elisabeth Lela, sampai kepada konversi SPK St.Elisabeth Lela menjadi Akper St.Elisabeth

Lela pada tahun 2008. Dilanjutkan dengan perubahan bentuk menjadi Stikes St Elisabeth Keuskupan Maumere pada tahun 2024. Saat ini penulis bekerja di Stikes St Elisabeth Keuskupan Maumere mengampu mata kuliah Keperawatan Anak sebagai dosen dengan Perjanjian kerja ASN non Dosen dan sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr.T.C.Hillers Maumere Flores . Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Promosi Kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: helenakidi70@gmail.com

Motto: "Never stop learning"

Profil Penulis



Hanny Rasni, S.Kp., M.Kep. Lahir di Jakarta, 19 Desember 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas Keperawatan, Universitas Indonesia tahun 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2008. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 di Akademi Keperawatan Blambangan dan tahun 2001 di Universitas Jember. Saat ini penulis bekerja di Universitas Jember mengampu mata kuliah Keperawatan Keluarga, Keperawatan komunitas dan Keperawatan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai

kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penerjemah yang terkait dengan bidang keilmuan. Penulis dapat dihubungi melalui email hanny_r.psik@unej.ac.id

Buku "*Bunga Rampai: Keperawatan Keluarga dalam Asuhan Kesehatan Anak*" membahas secara komprehensif bagaimana peran keluarga, khususnya dalam konteks keperawatan, sangat krusial dalam mendukung tumbuh kembang anak, terutama pada masa bayi dan balita. Dalam buku ini, pembaca akan diajak memahami peran aktif keluarga sebagai mitra tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkelanjutan di lingkungan rumah.

Beberapa topik utama yang diangkat mencakup strategi perawatan balita dalam keluarga, pendidikan kesehatan anak untuk pencegahan kecelakaan dan cedera, serta manajemen gizi yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan anak. Tak hanya itu, buku ini juga menyoroti pentingnya pembentukan kebiasaan hidup sehat sejak dini yang dipandu oleh peran serta keluarga secara aktif dan konsisten.

Keunikan buku ini terletak pada pembahasan mengenai pendekatan *ethno-agronursing*—sebuah metode yang memadukan nilai-nilai budaya lokal dan potensi agrikultur dalam mendukung praktik keperawatan keluarga, khususnya dalam pemberian asupan gizi bagi bayi dan balita.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa keperawatan, praktisi kesehatan, pendidik, serta keluarga yang peduli akan pentingnya kesehatan anak dalam lingkungan rumah. Dengan gaya bahasa yang mudah dipahami dan berbasis pada pendekatan ilmiah serta praktik nyata, buku ini menjadi panduan aplikatif sekaligus inspiratif dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan anak melalui peran keperawatan keluarga.

Buku "Bunga Rampai: Keperawatan Keluarga dalam Asuhan Kesehatan Anak" membahas secara komprehensif bagaimana peran keluarga, khususnya dalam konteks keperawatan, sangat krusial dalam mendukung tumbuh kembang anak, terutama pada masa bayi dan balita. Dalam buku ini, pembaca akan diajak memahami peran aktif keluarga sebagai mitra tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkelanjutan di lingkungan rumah.

Beberapa topik utama yang diangkat mencakup strategi perawatan balita dalam keluarga, pendidikan kesehatan anak untuk pencegahan kecelakaan dan cedera, serta manajemen gizi yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan anak. Tak hanya itu, buku ini juga menyoroti pentingnya pembentukan kebiasaan hidup sehat sejak dini yang dipandu oleh peran serta keluarga secara aktif dan konsisten.

Keunikan buku ini terletak pada pembahasan mengenai pendekatan ethno-agronursing—sebuah metode yang memadukan nilai-nilai budaya lokal dan potensi agrikultur dalam mendukung praktik keperawatan keluarga, khususnya dalam pemberian asupan gizi bagi bayi dan balita.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa keperawatan, praktisi kesehatan, pendidik, serta keluarga yang peduli akan pentingnya kesehatan anak dalam lingkungan rumah. Dengan gaya bahasa yang mudah dipahami dan berbasis pada pendekatan ilmiah serta praktik nyata, buku ini menjadi panduan aplikatif sekaligus inspiratif dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan anak melalui peran keperawatan keluarga.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-09-1



9

786347

219091